

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA
Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR

3

JORGE GARCIA BADARACCO

Introducción de la problemática familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico.

JUAN A. YARIA

Reflexiones sobre el complejo de Edipo en la psicosis a través de un fragmento de un historial clínico.

JUAN C. NOCETTI

Sistemas de parentesco y organización familiar

ALEJANDRO R. SICARDI

Aportes de E. Pichón Riviére a la Terapia Familiar

CARLOS KLIGMANN – RAFAEL SKIADARESI

Familia e Intersubjetividad

LUIS ALBORNOZ

Reflexiones sobre Terapia Familiar

ALFREDO A. CANEVARO

Apuntes para una filosofía terapéutica del grupo familiar

DAVID RUBINSTEIN, GERALD ZUK, ALFREDO A. CANEVARO

Diálogos

M.E. CZERTOK, I. GUZMAN y J. BEBCHUK

Ateneo Clínico

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar

Año 1 - Nº 3 - Septiembre de 1979

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina

Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Gerald Zuk (Filadelfia)

Alberto Serrano (Buenos Aires - San Antonio - Texas)

Jacques Rudrauf (París)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Maurizio Andolfi (Roma)

Richard Sauber (Massachusetts)

Robin Skynner (Londres)

Mara Selvini Palazzoli (Milán)

Raymundo Macías (México)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina - St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Donald Bloch (New York)

Ives Colas (Lyon)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Secretaría Administrativa

Graciela Rodríguez

Edición a cargo

Edal Ediciones s.r.l.

Distribución exclusiva para el exterior
EDAL EDICIONES SRL

TERAPIA FAMILIAR es una publicación cuatrimestral de Editorial ACE S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs. Aires, Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 1382769.

Compuesto y armado en Octógono, Berutti 3471, e impreso en los Talleres Gráficos Offsetgrama s.r.l., Matheu 1135, Capital Federal, en septiembre de 1979.

Tarifa reducida 3053 - Franqueo pagado 339
Número del Registro Internacional
de Publicaciones Científicas ISSN 025-5905

Indice

Editorial	7
JORGE GARCIA BADARACCO	
Introducción de la problemática familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico.....	10
JUAN A. YARIA	
Reflexiones sobre el completo de Edipo en la psicosis a través de un fragmento de un historial clínico	25
JUAN C. NOCETTI	
Sistemas de parentesco y organización familiar	33
ALEJANDRO R. SICARDI	
Aportes de E. Pichón Rivière a la Terapia Familiar	48

CARLOS KLIGMANN – RAFAEL SKIADARESI	
Familia e Intersubjetividad	66
LUIS ALBORNOZ	
Reflexiones sobre Terapia Familiar	86
ALFREDO A. CANEVARO	
Apuntes para una filosofía terapéutica del grupo familiar ..	97
M. E. CZERTOK, I. GUZMAN y J. BEBCHUK	
Ateno Clínico	105
DAVID RUBINSTEIN – GERALD ZUK, ALFREDO. A	
CANEVARO	
Diálogos	137

EDITORIAL

Discurso de apertura pronunciado por el Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, Dr. Alfredo A. Canevaro.

Hablar de terapia familiar supone no sólo fundamentar el desarrollo y aplicaciones de una técnica sino también la creación de un método científicamente válido para el estudio de la estructura, patología y terapéutica del grupo familiar. Para ello es requerible un nuevo enfoque epistemológico centrado no sólo en el individuo, sino en su relación con el mundo mediatizada fundamentalmente por su grupo familiar.

De esta doble articulación nace la lectura de los hechos clínicos que como observables empíricos emergen de un campo multifacético.

Los presupuestos teóricos con que abordamos los observables empíricos permiten enriquecer su comprensión, ofrecernos explicaciones y permitir predicciones, sin olvidar que son siempre recortes arbitrarios de un fenómeno que no se dirime en una sola lectura.

La riqueza del hecho clínico es tan inagotable en su esencia como lo son las personas con quienes trabajamos. La necesidad de la estandarización de las variables, de la abstracción teórica y de la producción de un método científicamente válido no puede hacernos perder de vista el encuentro profundo con el ser humano que vive y que sufre. La pasión por el conocimiento se nutre de este encuentro

humano profundo que es lo que da sentido a nuestra tarea de terapeutas.

Por ello, el carácter dialógico y artesanal de nuestro quehacer enfatiza la importancia de la maduración personal del terapeuta. El impacto emocional e intelectual que supone el mayor grado de exposición de su persona en el encuentro con las familias, es el catalizador que conmueve su estructura profunda. A lo largo del camino se van desbrozando rápidamente la fascinación, del trabajo prudente, la necesidad de la propia reparación, de la consideración del Otro y la omnipotencia, del sereno optimismo.

Esta depuración no puede realizarse sin el paso previo y simultáneo del reconocimiento de las propias falencias y limitaciones. Esto es el mejor antídoto para que el canto de las sirenas no nos pueda hacer equivocar el camino. Las soluciones mesiánicas en nuestra profesión tienen corto vuelo y no hacen más que distraer del trabajo perseverante y honesto que requiere nuestra doble condición de terapeutas e investigadores.

Por eso, conviene diferenciar el carácter científico de nuestra disciplina, de la seducción de una moda, o de un movimiento sociológico. La creación de este espacio puede parangonarse al enclave en el que está situada la familia respecto del desarrollo del individuo y su inclusión en la cultura. La complementariedad de la terapia familiar con la individual, puede ser el campo mutuamente potenciado que reinserte en forma creadora en la sociedad, individuos antes desahuciados. La búsqueda de delimitaciones necesarias sin caer en compartimentos estancos, a la par de la creación y consolidación de un cuerpo de teoría que integre estos múltiples aspectos es un desafío estimulante y renovador. Para esos fines hemos creado esta asociación científica que hoy nos congrega y a la cual invitamos a todos aquellos profesionales cuya vocación por el estudio de la familia se constituya en un saber crítico constructivo que ayude a una mejor y más profunda convivencia entre los seres humanos.

La raigambre ética de este encuentro, es más que nunca necesaria, pues el mundo difícil en el que hoy vivimos desafía nuestra inteligencia creadora. El incesante flujo renovador científico y tecnológico debe estar necesariamente en función del ser humano y de su grupo familiar, única vía idónea para su inclusión en la cultura, so pena de constituir una fractura irreparable en nuestra convivencia.

Estas son las condiciones por lo tanto, para nuclearnos pensando que las distintas vertientes teóricas y experienciales alrededor del hecho clínico puedan integrarse de manera enriquecedora, creando un espacio ontológico nuevo que esté más cercano a la realidad.

En nuestro país se dan condiciones excepcionales para el desarrollo fructífero y renovador de esta disciplina científica. Más que en otros lugares del mundo, la existencia de un fenómeno sociocultural especial por el hecho de ser un país joven, producto de una inmigración masiva de todas las latitudes, crea un ambiente heterogéneo en el cual los conflictos transculturales y generacionales y las ilusiones y las frustraciones heredadas giran en torno del grupo familiar y de su necesidad de arraigo duradero y búsqueda de identidad.

La existencia de una cultura psicológica importante y la tradicional universalidad de la formación científica argentina hace que recibamos los aportes de distintos países y distintos autores sin prejuicios que limiten la información científica.

Finalmente, el hecho de ser el cuarto país en el mundo que posee una revista especializada en terapia familiar, primera en habla hispana y la existencia de pioneros importantes en este tema quienes, algunos habiéndonos legado conocimientos e inquietudes científicas, otros aún hoy enseñando permanentemente, en el país y en el extranjero, nos muestran la importancia que puede tener este desarrollo científico y cultural para nuestra nación.

Todo esto nos permite augurar que la escuela argentina se constituya en los próximos años en una de las más importantes en el mundo, consolidando el respeto que nos han tenido los países más desarrollados y fortaleciendo el liderazgo científico en América Latina, orgullo que nos legaran nuestros mayores y que hoy debemos revitalizar.

Por último, nuestro profundo agradecimiento a todos quienes nos han apoyado en esta difícil pero apasionante tarea, y a ustedes que con su generosa presencia justifican ya todo este esfuerzo.

Introducción de la problemática familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico

JORGE GARCÍA BADARACO

*Médico. Profesor adjunto de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Bs.As.
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Director de
Clínica Psiquiátrica, O'Higgins 2328, Buenos Aires.*

Es una responsabilidad bastante grande el iniciar con ésta, el ciclo de Conferencias anunciadas, en primer lugar, porque es el comienzo de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, de la cual esperamos una importante contribución científica y cultural para el desarrollo de la ciencia psiquiátrica y psicoanalítica en general, pero por otra parte, porque me resultó bastante difícil pensar qué iba a decir hoy. El tema es apasionante, pero delicado para tratarlo en profundidad y fácil para hacer de ésta una exposición superficial.

El público es bastante heterogéneo: hay un grupo de colegas que me conocen bastante y con los cuales hablo cotidianamente; ellos conocen las ideas que yo pueda exponer, pero hay muchas otras personas que no me conocen y con las cuales el contacto en una sala tan grande como ésta se pierde, y la terapia familiar hay que explicarla, a través de un contacto personal en el cual uno puede ver la respuesta de cada persona al escucharlo; éso me hace temer no obtener el clima adecuado.

Traje cosas escritas que tengo preparadas, pero me pareció que

necesitaba improvisar, porque si no el tiempo del que dispongo podría resultar escaso y perderíamos la unidad que esta exposición necesita.

Quisiera transmitirles algunas ideas generales que han ido surgiendo a través de la práctica cotidiana que si bien se ha hecho fundamentalmente con pacientes psicóticos y con sus familias, se fue haciendo también simultáneamente con grupos de colegas, con los cuales fuimos realizando un trabajo en equipo que tuvo su inicio en el hospital psiquiátrico, que se continuó luego en una clínica privada. En todos estos años hemos ido adquiriendo juntos una experiencia bastante grande, nos hemos enriquecido mutuamente en el diálogo permanente y por éso, lo que yo pueda decir, no me pertenece en exclusividad, sino que es compartido seguramente por muchos de mis colegas.

Voy a tratar de entrar en tema: una idea es que, para mí, la psicoterapia de la familia es un campo de trabajo psicológico privilegiado y extremadamente estimulante. Yo no llegué directamente al campo de la terapia familiar —creo que los que puedan hacerlo se van a sentir beneficiados— sino a través del psicoanálisis individual. La experiencia psicoanalítica individual me permitió entender una serie de cuestiones que por experiencia vivencial podría comprender mejor, pero cuando comencé a trabajar en el campo de la terapia familiar, empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que yo mismo, en el campo de la relación bi-personal, no había podido conocer y que podía conocer a través de la experiencia que estaba haciendo como terapeuta incluido en un grupo familiar.

El trabajo con pacientes psicóticos nos obliga como terapeutas a salirnos de las pautas habituales que reglamentan la terapia psicoanalítica llamada ortodoxa y que constituye lo que se llama el setting analítico, es decir, aquél conjunto de reglas que articulan la relación terapéutica entre el paciente y el psicoanalista. El paciente psicótico nos obliga a abandonar un rol demasiado fijo, ligado a determinadas reglas técnicas y nos lleva a la necesidad de comprometernos en la relación terapéutica de una manera mucho más intensa y profunda. Esto, incluyendo la familia como campo de la experiencia psicológica, se da todavía en mayor grado y exige del terapeuta una participación emocional que no es habitual en el trabajo terapéutico con pacientes

neuróticos en general y más aún en la terapia individual. Estos elementos me llevaron a pensar en la historia de la psicoterapia en general.

La psicoterapia, como ustedes saben, nace y se desarrolla como una técnica; en la psicoterapia el terapeuta trataba de influir positivamente sobre el paciente intentando ayudarlo a eliminar los síntomas que lo aquejaban. Freud, a través de la hipnosis, desarrolla el psicoanálisis descubriendo sucesivamente la noción del conflicto, la idea del inconsciente, la represión, las resistencias y entre otras cosas, la transferencia, que sería aquel componente de la relación médico-paciente, que además de motor del proceso terapéutico apareció desde el comienzo como un aspecto especial de la relación a través del cual se desarrolla el proceso de la cura.

La elaboración del concepto de transferencia, como proceso, hace que el psicoanálisis se convierta en una de las técnicas más importantes para el tratamiento de los pacientes neuróticos y que, a través de la experiencia clínica, Freud descubra y desarrolle algo así como el proceso terapéutico del paciente neurótico en análisis. Pero la aplicación de la técnica psicoanalítica se presentó para Freud como inadecuada para aplicar al paciente psicótico, que no respondía o no podía participar en la experiencia terapéutica tal como Freud la visualizaba en ese momento. Recorriendo el mismo camino de Freud, con un grupo de colegas, fuimos encontrando poco a poco que no se trataba de que la técnica psicoanalítica no fuera útil para la comprensión del paciente psicótico, sino que la situación terapéutica que plantea el análisis ortodoxo, es inadecuada para este tipo de personas, porque necesitan otro tipo de continente psicológico para desarrollar su proceso terapéutico. El paciente psicótico colocado en análisis, comienza a experimentar una serie de cambios que de alguna manera lo movilizan emocionalmente y que al ser llevados al núcleo familiar no son tolerados por éste. El enfermo, entonces, se encuentra en un campo intensamente conflictivo entre el tratamiento y su familia, lo que lleva en general a la interrupción del tratamiento. De esta situación se llega a visualizar la necesidad de incluir al paciente psicótico en el medio familiar y a trabajar con él a través de la terapia familiar simultáneamente con la terapia individual. Esta experiencia, desde el punto de vista teórico, significa que es necesario incluir el contexto en el proceso terapéutico tratando de lograr un

clima psicológico familiar adecuado para hacer posible el tratamiento psicoanalítico mismo. Estos aspectos que descubrimos en la terapia psicoanalítica de pacientes psicóticos podremos encontrarlos en la psicoterapia de cualquier paciente, es decir que también en los pacientes neuróticos se observan los mismos fenómenos, pero no de igual forma. La reflexión fundamental a la que lleva este planteo, es que el proceso terapéutico —más allá de la técnica utilizada— es un proceso de re-desarrollo, de un crecimiento del paciente dentro de un contexto familiar real o virtual, es decir, esté presente o no la familia en la realidad, el proceso terapéutico será necesariamente un proceso que tiene lugar dentro de un contexto familiar. Es así que la inclusión de la familia en el trabajo terapéutico será una consecuencia necesaria de este nuevo enfoque del proceso. Del tal manera, que más allá de la técnica utilizada, el proceso terapéutico tendrá que incluir necesariamente a la familia.

Desde el punto de vista de la técnica, el psicoanálisis individual postuló desde un principio la necesidad de que la experiencia psicoanalítica estuviera aislada de la familia llamando a esto la pureza del setting analítico. Si bien Freud lo planteó de esta manera, como un aspecto importante de la técnica, él mismo, sin embargo, en los primeros historiales muestra que su contacto con los familiares de los pacientes que él atendió existía y existió en varias oportunidades. Es evidente que la pureza del setting está destinada fundamentalmente a preservar la privacidad del proceso terapéutico y apunta al hecho de que el paciente pueda volcarse con la confianza necesaria para poder, por ejemplo, asociar libremente, teniendo la seguridad de que el terapeuta no revelará sus intimidades. El contacto entonces del terapeuta con la familia podría atentar contra esa necesidad del paciente de tener una confianza absoluta en la privacidad de lo que él va a revelar. Pero si bien esto es un aspecto fundamental de la técnica psicoanalítica, el paciente psicótico no está en condiciones ni de tenerlo ni de utilizarlo y colocado en una situación donde siente que no puede aprovechar la experiencia, va a movilizar a la familia para que intervenga y es allí donde vamos a empezar a entender cuáles son los vínculos que realmente ligan al paciente psicótico con sus familiares y de qué manera el paciente reclama la participación de la familia. Si el terapeuta, —pretendiendo protegerse detrás de necesidad de la pureza del setting, de la invasión familiar

en su territorio terapéutico—, insiste la preservación de esa situación, va a ser invadido de alguna manera o va a perder su paciente. Para poder abordar esta fenomenología fundamental del proceso terapéutico del paciente psicótico, vamos a tener que incluir a la familia en este proceso y hacernos cargo de la patología familiar que acompaña a la patología individual. En este sentido y entonces desde el punto de vista de la técnica, vamos a tener que utilizar una combinación de la terapia psicoanalítica individual con la terapia familiar y la pureza del setting estará reglada, fundamentalmente, por la prudencia del psicoterapeuta, su capacidad de discriminar cuáles son los contenidos que él debe guardar como totalmente privados del paciente y aquéllos que podrá utilizar adecuadamente en la relación con los familiares. Desde el punto de vista del enfoque psicopatológico, la terapia familiar mostró una serie de aspectos de la patología psicótica que permitió que pudiéramos ir ahondando en la naturaleza del proceso psicótico. Alrededor de los años '30, empezaron a aparecer algunas nociones fundamentales, como por ejemplo, la de madre esquizofrenógena, concepto de Frida Fromm Reichmann; luego se describió la patología del padre, fundamentalmente en el concepto del padre ausente y aproximadamente en los años '55-'56 Mindelfort, es uno de los primeros que habla de la familia total como una estructura familiar enferma. Esta fue descrita con los conceptos de la psicopatología psicoanalítica que eran conceptos extraídos de una relación bi-personal en donde se estudiaba, como dije antes, fundamentalmente, los conflictos intrapsíquicos y los aspectos de los contenidos inconscientes que pudieran explicar los fenómenos patológicos, pero cuando aparece la familia como un todo o la patología individual como incluida en una patología familiar, comienza a ser necesario empezar a visualizar la patología individual en relación con la patología de otro o de la familia y entonces aparece la noción de vínculo patológico o de la patología vincular.

Entre nosotros, en la Argentina, uno de los autores que desarrolló los primeros conceptos, fue Pichon Riviére, cuyo aporte ha sido muy valioso en el campo del psicoanálisis y de la patología familiar que estamos desarrollando. En relación a la patología vincular aparecieron conceptos como simbiosis, depositario, depositante, etc. Posteriormente aparece el concepto de doble vínculo que

Bateson, Jackson, Waakland y Haley desarrollan para explicar uno de los aspectos fundamentales de la patología esquizofrénica. Por otro lado autores provenientes de la vertiente familiar describen fenómenos como mutualidad, pseudomutualidad, cisma y sesgo marital, etc., conceptos desvinculados del aporte original de Freud y de los autores de la escuela Kleiniana que se ocuparon especialmente de la patología psicótica.

¿De qué manera articular los conceptos que surgen de la terapia individual con los conceptos que surgen de la terapia familiar? Éste es uno de los aspectos que, a mi entender, han podido o pueden enriquecer todavía mucho la concepción que podemos tener de la patología psicótica y es en este sentido donde quisiera decir algunas cosas.

Desde el punto de vista de la terapia familiar la simbiosis aparece como un vínculo patológico y el momento de modificación de la relación simbiótica como uno de los momentos fundamentales para darle solución a este conflicto psicótico, lo vamos a ver más adelante cuando intente describir el proceso terapéutico combinado, entre el psicoanálisis individual y la terapia familiar. Pero la simbiosis es, antes que un vínculo patológico un vínculo fundamental en el desarrollo del ser humano, de la relación del niño con su madre. ¿De qué manera un vínculo simbiótico normal se transforma en patológico? Esto constituyó, yo diría durante mucho tiempo, un secreto. Freud describe con una profundidad realmente extraordinaria las primeras etapas de lo que llama el narcisismo que sería la condición en la cual el ser humano nace, las primeras formas de relación objetal con la madre y luego la entrada en el conflicto edípico que sería uno de los puntos básicos de la concepción psicoanalítica.

En el ser humano normal el conflicto edípico se resuelve en lo que se llama la "resolución del Complejo de Edipo" que se produce aproximadamente a los 4 ó 5 años de edad y es a partir de allí que el ser humano entra en un período de latencia, desde el punto de vista del desarrollo psico-sexual, pero que implica un período de desarrollo muy importante de la estructura de su aparato psíquico y de la capacidad de pensar realmente.

Freud describe esto con todo detalle y una lectura adecuada nos permite comprender que la patología psicótica está de alguna manera relacionada con estas etapas anteriores a la resolución del

Complejo de Edipo. Entonces para que el ser humano pueda enfrentarse con el Complejo de Edipo tiene que haber desarrollado y antes un tipo de relación objetal que le haya permitido una preparación es decir, para poder enfrentar las etapas ulteriores de ese desarrollo, esa preparación la va a hacer fundamentalmente en relación con la madre.

En las etapas de bebé el ser humano va a poner a la madre a prueba en sus propias etapas de desarrollo como bebé y si de alguna manera esa madre no tuvo un desarrollo adecuado, es decir, que ella no alcanzó una etapa de resolución verdadera del Complejo de Edipo, se van a reactivar en ella aspectos no resueltos y va a establecer sin darse cuenta una relación narcisística patológica con su hijo en términos de una relación libidinal de tipo pre-genital, que en vez de ser entonces una etapa necesaria para una estructuración de una personalidad sana, va a ser un momento en el cual se va detener el crecimiento. La patología psicótica comienza a estructurarse justamente en este momento. Una madre que no ha podido ella misma desarrollarse como tal en su capacidad de ser continente de las ansiedades de su bebé, en su capacidad de aportarle al bebé los aspectos necesarios para su desarrollo, como dice Winnicott, será una madre que establecerá con él un vínculo simbiótico patológico. La patología psicótica se dará, entonces, como una patología del vínculo que, ligado y detenido en un nivel narcisístico, no va a poder salir de allí.

¿De qué manera el vínculo narcisístico se observará posteriormente en el ser humano psicótico y en la terapia familiar? Se va a observar justamente en los términos de lo que los terapeutas de familia describieron como doble vínculo, doble mensaje, aspectos que formarían parte de lo que Freud describió en correlación con el Complejo de Edipo mismo, si incluyéramos en él las vicisitudes vividas por los propios padres. En ese sentido la relación pre-genital del niño con su madre estará no solamente determinada por la etapa del desarrollo que él está atravesando, sino por las dificultades de la madre de acompañarlo adecuadamente en esas etapas de desarrollo. Es decir, que sin saberlo y sin quererlo, lo va a detener en esa situación, de allí es de donde van a surgir las identificaciones primarias en el sentido de identificaciones con los objetos en los cuales el ser humano es obligado, o por decir así, queda atrapado en un vínculo simbiótico, obligado a identificarse con el objeto, no va a poder

nunca desarrollarse como sujeto y va a quedar entonces desde los primeros momentos de la vida atrapado en esa situación vincular en donde tendrá que ser rescatado de alguna manera por el proceso psicoterapéutico. De tal manera que el paciente psicótico no podrá hacer un proceso terapéutico por sí mismo, sino que tendrá que ser rescatado de esa situación vincular en la que ha quedado atrapado. ¿Qué significa esto en términos de la estructura familiar? Significa que lo que habitualmente se da en la relación triangular, madre, padre, hijo, donde el padre tendrá como función principal el rescatar naturalmente al hijo del vínculo simbiótico con la madre, no va a poder hacerlo, primero porque el vínculo simbiótico con esa madre será desde el vamos patológico y además el padre será un padre ausente, porque estará excluido de alguna manera de ese vínculo simbiótico. ¿Cuál será en este momento la intervención del psicoterapeuta? El psicoterapeuta tendrá que intervenir entonces como llenando esa función paterna no realizada o no cumplida, pudiendo dar al padre de esa estructura familiar un modelo de resolución de la situación edípica que no pudo desarrollarse adecuadamente.

Freud describió, en la patología, por ejemplo de las perversiones, la naturaleza de la sexualidad infantil —éste es uno de los puntos que más escandalizó en su momento—, es decir, la teoría de que el niño tendría una sexualidad infantil que no se le reconocía antes, pero resulta que es de esa sexualidad infantil no reconocida de la que se trata para poder comprender en qué tipo de vínculo simbiótico ha quedado atrapado, porque es la persistencia de la sexualidad infantil de los padres, en donde ellos mismos no pudieron resolver su propio Complejo de Edipo, de donde va a surgir la patología del hijo. De tal manera que la patología será la consecuencia no solamente de un conflicto existente (el conflicto edípico no resuelto, o a un nivel preedípico, el vínculo simbiótico o narcisístico no superado), sino también la resultante de las carencias que los distintos miembros de esa familia tienen para no haber podido dar en esa situación la posibilidad de un desarrollo normal. Es entonces en términos de lo que no pudo ser y no se dió que vamos a tener que entender la psicoterapia. Como psicoterapeutas vamos a tener que hacer que lo que no se dió, se dé, que lo que no tuvo lugar, pueda tener lugar y que el crecimiento que quedó detenido o atrapado en etapas fundamentales del desarrollo del ser humano pueda darse.

Pero en el abordaje de la psicoterapia familiar misma nos vamos a encontrar con que cuando el paciente hace algún intento de crecimiento propia hacia la desimbiotización, se va a encontrar con una reacción o una respuesta de la madre, por ejemplo, que va a intentar volver a retomar ese vínculo que para ella es necesario en la medida en que cumple una función vicariante de carencias existentes dentro de ella misma.

Es decir, que la patología vincular a la que nos vamos a enfrentar con el paciente esquizofrénico, por ejemplo y su madre, nos obliga a considerar la patología individual de esa madre que remite de alguna manera a la patología vincular que ella tuvo con sus propios padres y así sucesivamente vamos a encontrar una serie de aspectos que van a ser solamente comprensibles en los términos de una herencia psicológica que se va a dar a través de distintas generaciones y que va a tener que ser rescatada en la medida en que podamos ocuparnos de las diferentes personas que están incluidas en esa transmisión, esa herencia, porque éstos van a ser eslabones necesarios para poder rectificar esa misma patología que ha sido transmitida como patología de una carencia de desarrollo o de una carencia de experiencias que son necesarias para la vida. El paciente esquizofrénico es, finalmente, la consecuencia de una familia carenciada para permitir el desarrollo del ser humano y van a tener que realizar juntos experiencias de re-desarrollo y de crecimiento auténtico que no ocurrieron en su momento.

Hay otros aspectos fundamentales en el proceso terapéutico, el lenguaje psicótico y el proceso de desimbiotización a los que me voy a referir ahora. En general se dice que el paciente psicótico no es abordable desde el punto de vista psicoanalítico y que no hace transferencia. Si leemos detenidamente a Freud encontramos que nunca dijo tal cosa y que más allá de no haber dicho esto, dijo que, por ejemplo, la patología de los delirios, que es una de las características de la psicosis, no solamente remite a experiencias infantiles no resueltas, sino que también expresa de una manera distorsionada e indirecta aquellos aspectos de esa patología infantil a los cuales alude directamente a través del delirio mismo. En el caso Schreber, que es uno de los casos que Freud desarrolló, de una autobiografía relatada por el propio paciente y que es un estudio que data de 1911, Freud muestra hasta qué punto el delirio de Schreber hace referencia

a las dificultades que este paciente había tenido en su vida, apareciendo en su contenido de una manera directa o indirecta las referencias al conflicto con el padre. Freud llama a esto transferencia, es decir, que el paciente psicótico no solamente establece transferencia, sino que lo hace con gran intensidad: la máxima intensidad de la patología psicótica está dada en el delirio mismo. Cuando abordamos el tratamiento del paciente psicótico nos enfrentamos con el lenguaje psicótico y el lenguaje psicótico es, por naturaleza, un lenguaje críptico, es una especie de enigma que nos plantea el paciente para ser descifrado y el psicoanálisis se dedicó, en un primer momento, a descifrar el contenido de esos delirios como si fueran el contenido de los sueños. Pero el terapeuta que intenta descifrar el contenido del delirio como si fuera un sueño no atiende a uno de los aspectos fundamentales del lenguaje psicótico, que es el de cómo el paciente intenta, a través de ese lenguaje hacernos vivir aquello que él sufre, o ha sufrido y sigue sufriendo, expresado a través de un lenguaje indirecto, que es el lenguaje psicótico, en el cual las palabras no tienen un significado convencional, sino que tienen un significado secreto en la medida que transmiten o pretenden transmitir algo que el paciente muchas veces no sabe decir ni reconocer, pero siente.

Es decir, que la transferencia psicótica no será la transferencia habitual neurótica donde el paciente, por ejemplo, a través de un sueño, nos está revelando el contenido del conflicto o la necesidad de ayuda, o de una interpretación, sino que nos estará haciendo sentir a través de las palabras, a través del lenguaje psicótico, las cosas que él mismo no comprende dentro de sí, las emociones que se despiertan en él a veces con mucha intensidad y violencia que representan las emociones que quedaron disociadas en épocas primitivas del desarrollo de su personalidad y que vuelven allí en esa transferencia psicótica con una intensidad particular. El paciente psicótico nos requiere como terapeutas en términos de una relación muy intensa que se describe como la transferencia psicótica.

¿Pero qué descubrimos cuando simultáneamente se hace terapia individual y terapia familiar? Que en la transferencia psicótica lo que aparece es la reactualización de los vínculos primitivos del paciente con sus familiares ¿pero de qué vínculos? de aquellos vínculos en los cuales él quedó detenido en su proceso de desarrollo,

porque fueron vínculos que no pudieron ser elaborados en su relación, por ejemplo, con su padre y que el psicótico tratará de elaborar con su terapeuta. En este intento de elaboración el paciente trae fundamentalmente sus emociones primarias, sus emociones profundas para encontrar en el terapeuta, más allá de un descifrador de enigmas, un *yo* que le permita elaborar, un *yo* del cual él mismo carece, un *yo* que cumpla una función materna o paterna que no fue cumplida en su momento, que nos exige ser, por momentos, la madre o el padre que no tuvo.

En la terapia familiar ésto se va revelar directamente a través de reclamos de todo tipo que van a aparecer en el paciente, a través de los delirios, o directamente con el vínculo con sus familiares, entonces el terapeuta se va a tener que transformar en una especie de amortiguador de estos intensos fenómenos transferenciales con los padres actuales, porque son expresiones en las que el paciente toma a los padres como los padres de la infancia. A través del proceso terapéutico, si podemos ir superando estas etapas, nos vamos a encontrar con los intentos de individuación del paciente del vínculo simbiótico que lo atrapa y en éstos, cuando comience a tener algún tipo de autonomía nos vamos a encontrar con la aparición de fenómenos patológicos en los padres, que surgirán en la medida que el rol de enfermo quede sin llenar por el paciente, entonces aparecerá con toda intensidad la patología familiar, es decir, la patología que estaba concentrada en el paciente y se va a distribuir en el conjunto de la familia. Podríamos decir que lo que va a aparecer fundamentalmente es la patología de la pareja, patología que nos va a remitir a los primeros momentos de la construcción misma de la pareja como tal, a la elección de pareja por motivaciones patológicas y que describieron algunos autores, por ejemplo, Bychowski. Allí podremos observar un vínculo narcisístico dentro de la pareja misma, de dependencia o interdependencia recíproca, donde se van a jugar aspectos de la conflictiva de cada uno de los miembros de la pareja entre sí y donde el hijo, cuando nace, va a empezar a jugar el papel de un depositario de esa patología de la pareja no resuelta en la misma.

De tal manera que, por ejemplo, vamos a encontrarnos con una madre que, no pudiendo incluir la presencia del padre dentro de ella misma, como su pareja o del padre frente al hijo, va a revelar a través

de la relación que establece con ésta su propia patología vincular atrapándolo en una relación simbiótica, es decir, que la terapia familiar nos va a revelar de una manera mucho más directa y esclarecedora algunos aspectos ya descriptos por el psicoanálisis.

En Freud, la transferencia aparece como el motor del tratamiento y la resolución del conflicto neurótico, en la transferencia, aparece como el camino obligado para la realización del proceso terapéutico. Pero Freud, curiosamente, tiene un trabajo "Más allá del principio del placer". El principio del placer fue una especie de hilo conductor que Freud utilizó para la comprensión del conflicto neurótico, para su resolución y elaboración, pero resulta que más allá del principio del placer, se dan cosas que contrarían este tipo de fenómeno y que Freud describe como ligado a la patología, lo que él llamó la compulsión a repetir; esta compulsión a repetir lo llevó a hacer investigaciones sobre la existencia de un posible instinto de muerte a ella ligado y que estaría vinculado a las dificultades que tiene el psicoanálisis para abordar cierto tipo de patología que hacen un análisis interminable, es decir, un análisis que no termina nunca o que no termina nunca de poder procurar realizar otras etapas de su proceso terapéutico.

Una lectura de Freud realizada a través de la patología familiar y de la experiencia en terapia familiar, me conduce a mí a pensar que en la discusión que Freud hace en "Más allá del principio del placer" y en las especulaciones teóricas sobre el instinto de muerte, se refiere precisamente a esta patología vincular primaria, en donde, en la relación con el objeto, el niño, no pudo hacer otra cosa que identificarse obligadamente con él, es decir, prácticamente tragarse al objeto, dejando de ser él mismo y no teniendo nunca más, diríamos así, la posibilidad de un desarrollo auténtico a partir de su propia espontaneidad este fenómeno que será descripto más tarde, por ejemplo, por autores como Winnicott, en términos de la existencia del falso self, en relación con el self verdadero que será necesario descubrir y recuperar en el proceso terapéutico de todo paciente y especialmente en pacientes psicóticos.

Creemos ver en lo que descubrimos en la terapia, donde en muchos momentos al hijo habla como la madre, se mueve como la madre, gesticula como ella y es la madre, prácticamente en todo (o el padre), justamente el tipo de vínculo patológico en donde el sujeto, identi-

ficado con el objeto, queda atrapado y asimismo detenido su proceso de crecimiento normal, esperando ser recuperado de esa situación, como diría Winnicott, a través de rescate y redesarrollo del self verdadero, o recuperado del vínculo simbiótico por el padre, como dicen los autores que trabajan con familias y finalmente, revelando, en el sentido de Freud, el instinto de muerte en la compulsión a repetir, como una situación de la cual si no se puede salir, significa la muerte, porque es la muerte del sí mismo, de la persona, que no puede desarrollarse en la estructura familiar del tipo de la que me estuve refiriendo y en la cual no se dan las condiciones para el desarrollo de un verdadero self. Freud habla de que el Complejo de Edipo es el complejo que crea una neurosis, que es a través de la resolución del Complejo de Edipo que se estructura definitivamente en el aparato psíquico del ser humano la personalidad. En la patología psicótica se encuentran personas que tienen una estructura pre-edípica, pre-genital no resulta, donde los aspectos disociados vehiculizan en general esos aspectos de una sexualidad que no pudo ser integrada en su propio desarrollo, en el desarrollo de cada hombre y de esta manera se produce la persistencia de un Complejo de Edipo que revela justamente esa perturbación.

El psicoanálisis individual, que fracasa habitualmente si es el único método terapéutico para el abordaje del paciente psicótico y que se enriquece enormemente con la inclusión de la terapia familiar, nos muestra precisamente que, a través de la terapia familiar se hace posible un proceso terapéutico que el psicoanálisis no había podido conseguir, pero que está previsto en el desarrollo teórico y clínico del mismo Freud desde las primeras épocas, hacer posible esa parte tan difícil del proceso terapéutico y nos abre un campo, a mi entender, de una riqueza muy grande.

En el desarrollo que traté de hacer hoy, evidentemente he intentado hacerlo, a partir de ciertos conceptos teóricos y de la articulación con ciertas experiencias clínicas, porque los campos de trabajo donde los analistas individuales y los terapeutas familiares habitualmente se desempeñan, son campos de trabajo separados y casi todos los terapeutas de familia no tienen, es decir, pueden ser psicoanalistas, pero dejan la experiencia individual por algún motivo o por alguna preferencia personal, o no son psicoanalistas y abordan el campo de la terapia familiar desde otro punto. Pero general-

mente, se quedan en el campo de la terapia que utilizan y no enriquecen su campo de trabajo con otras técnicas, con otros abordajes.

La patología psicótica nos llevó a la inclusión de la terapia familiar, a la necesidad en muchas situaciones de la inclusión de una institución para poder abordar el paciente psicótico, es decir, a la internación en una institución adecuada, en donde el paciente puede realizar también una parte complementaria de su proceso terapéutico.

A medida que fuimos haciendo experiencias en este campo, vimos que lo que se llama una comunidad terapéutica —si es entendida en términos del proceso terapéutico que cada paciente puede realizar dentro de ella— como campo psicológico de experiencia y de desarrollo, como un campo psicológico de estructura multifamiliar donde cada paciente va a intentar rehacer, a través de los vínculos transferenciales con los distintos miembros de la comunidad, los vínculos que tuvo y tiene todavía con las figuras parentales de su propia familia y es a través del estudio de estos vínculos donde se va a revelar su verdadera personalidad y donde se van a poner en evidencia también sus verdaderas dificultades.

El estudio combinado entre la psicoterapia individual y la terapia familiar, todo incluido dentro de la estructura de la comunidad terapéutica, nos permita abarcar de una manera pluridimensional la patología mental y nos provee de instrumentos o recursos terapéuticos que hasta ahora no teníamos, permitiéndonos enriquecer el arsenal de recursos terapéuticos y el conocimiento de los procesos terapéuticos posibles, ampliando así la posibilidad de obtener resultados positivos. Si bien, como dijo hace un momento el Dr. Canevaro, el entusiasmo debe ser prudente, la experiencia clínica nos muestra que el entusiasmo y la convicción en la posibilidad de la curación es fundamental para que el paciente psicótico pueda realizar etapas de su proceso terapéutico.

Es algo así como si para poder recuperar o rescatar a ese paciente de esos vínculos primarios que lo detuvieron en su desarrollo, hay que poder llegar a él con una convicción particular, la de que él podrá ser un ser humano rescatable como tal, para sí mismo y para los demás.

Esta convicción particular en un primer momento es una espe-

cie de deseo profundo, de deseo realmente, de ayudar al prójimo que yo mismo he sentido profundamente, aparece como algo así como si fuera una condición que no está incluida habitualmente dentro de lo que llamamos psicoanálisis, porque el psicoanálisis y sobre todo algunas escuelas que se desarrollan actualmente, es algo así como que el psicoanalista no debería tener, que debe funcionar más bien con una neutralidad muy grande para poder hacer psicoanálisis.

Yo creo que a veces esa neutralidad no es suficientemente bien comprendida.

El poner una especie de necesidad personal de curar al paciente como una particularidad propia, digamos propia de un psicoterapeuta, no es, pienso yo, algo que sea conveniente, en la medida que revela algo así como una necesidad narcisística del terapeuta de curar a este paciente, porque entonces el paciente va a quedar nuevamente atrapado en ese vínculo vicioso del cual intentamos rescatarlo y será muy difícil mantener una actitud adecuada en donde no atrapemos al paciente con nuestras necesidades narcisísticas, pero le podemos transmitir la convicción de que él sí tiene potencialmente recursos propios para poder desarrollar un ser humano valioso y nosotros vamos a poder ayudarlo.

Reflexiones sobre el Complejo de Edipo en la psicosis a través de un fragmento de un historial clínico.

JUAN ALBERTO YARIA

*Doctor en Psicología. Coordinador fundador de la Clínica Grativa.
Rivadavia 5840, Buenos Aires, República Argentina.*

Cita de Francois Perrier del trabajo Fundamentos Teóricos de una psicoterapia de la esquizofrenia.

“Desde el lugar que ocupamos el esquizofrénico tiene una historia pero ésta no le pertenece. No es más que la de sus progenitores, de la misma manera que éstos no son más que niños más estructurados bajo disfraces parentales”. “Es la novela familiar de cada uno de los padres lo que predestina la psicosis que hace del menor de los hijos el resultado aberrante de una colisión inconsecuente, el éxito biológico de un mal entendido”. “Es a menudo del sólo estudio de tres o cuatro generaciones que puede deducirse la fórmula psicótica condensada en ese esquizofrenico que parece nacido del desgraciado encuentro de dos progenitores decadentes”.

Desde que surgió la idea de estas Jornadas pensé de qué manera podía acercarles a Uds. la imagen viva de una experiencia terapéutica con una familia. Podría expresarles una intención doctrinaria o teórica, pero súbitamente me di cuenta que era necesario realizar el relato de una aventura, la aventura de adentrarse en una familia

concreta. La historia de un tratamiento de un paciente rotulado comunmente como un esquizofrénico. Es de suyo una síntesis apretada que forma parte de un trabajo de mayor dimensión. Me voy a referir a ciertos elementos nucleares que posibilitaron la elaboración a nivel familiar de la psicosis.

1. Reseña de la Historia Clínica

L. de 29 años ingresa a la institución luego de un intento de suicidio en donde se quema el tórax. Se sentía un hereje participante de la secta religiosa Testigos de Jehová. El paciente es de religión judía. Refiere que ser hereje es tener deseos homosexuales. Comenzó a sentirse peor desde el nacimiento del primer hijo de su hermano. Los dos hermanos son albinos. Su primer intento de suicidio fue en el año 1970 con medicamentos (psicofármacos) cuando vivía en La Plata donde estudiaba con su hermano luego que éste se pusiera de novio.

Su segundo intento fue en el año 1971 con psicofármacos, luego de un suceso en donde al entrar a su cuarto en la pensión donde vivía con su hermano encuentra la puerta cerrada con llave. El hermano se encontraba con la novia teniendo relaciones sexuales.

En 1972 empeora su estado psíquico. En este año se casó el hermano. En 1976 en plena internación se encierra en un baño, se rocía con Colonia Valet ("la colonia que mata") y se prende fuego en el torax sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado. Esto fue a los pocos días del cumpleaños del sobrino que cumplía dos años (el paciente se lleva dos años). Luego, ya repuesto comenta las causas que lo llevaron a eliminarse: se enteró que el hermano había sido contratado para una gira importante, que su cuñada estaba nuevamente embarazada, su novia lo dejó definitivamente y lo rechazó sexualmente y cuando habla con una prostituta para salir siente que se le ríe telefónicamente y le comenta que se lo va a contar al marido. En esos momentos el paciente trabajaba y cuando volvió a la institución comentó que "ésta no lo podía contener".

Cuando el paciente nació la madre tuvo una crisis melancólica severa. Segundo hijo esperado como diferente, ya que el primero fue albino.

El padre del paciente quedó huérfano cuando tenía 8 años y

encontró en su suegro una figura paterna sustitutiva con una carga ambivalente. Otro personaje importante es el tío materno, soltero y ligado edípicamente en forma intensa a la hermana.

El tío materno murió hace dos meses y esto implicó un reordenamiento de la estructura de poder y del liderazgo en la familia. Desde el casamiento el padre tuvo un papel muy comprimido en la estructura por el hermano de la madre y por su suegro.

El tratamiento se estructuró con cinco sesiones semanales de psicoterapia individual, una sesión familiar, una sesión vincular con el hermano semanal y reuniones periódicas del paciente con su equipo terapéutico.

Voy ahora a reseñar ciertos hitos o "puntos de capitoneo" que operaron en el tratamiento familiar como verdaderos circuitos de significación.

2. Nacimiento simbólico no realizado

En un trabajo para la revista Imago (1978) titulado "El cerco de la familia en la psicosis" abordé este mismo tema y decía: "en la mayoría de las historias de los psicóticos encontramos un hiato insoslayable entre el nacimiento como hecho biológico y el nacimiento como hecho simbólico" Ahí me refería a la operación paterna como faltante en la estructura de la red simbólica familiar del psicótico. La operación paterna garantizaría el contacto con un "afuera" frente al "adentro de la célula narcisista".

El paciente nace en el marco de una expectativa familiar, debía no ser albino como era su hermano mayor. Los padres de tez morena y marroquíes habían apostado a que esto debía ser así. Consultan a un médico especialista y éste les afirma que "tener otro hijo albino era más difícil que sacarse la lotería". Al nacer el paciente le escriben al médico diciéndole: "me saqué la lotería". El nombre del paciente es el único de toda la familia que no pertenece a la comunidad judía.

La severa crisis melancólica de la madre hizo que el paciente fuera amamantado por diversas figuras sustitutivas.

El padre se dedica intensamente a los negocios, participa muy poco de la vida familiar. Juega todas las noches a las cartas y cuando vuelve encuentra a la esposa llorando y al paciente consolándola por

el presunto abandono paterno.

Toda esta temática ligada a lo siniestro debió ser hablada en el tratamiento. En la familia hay también una "cadena rota de discurso" que debía ser restituída y bordada nuevamente, a pesar de todas las resistencias tanto de la familia como del terapeuta. Es enfrentarse con el "verdadero self" al decir de Winnicot ligado en este caso a la muerte.

Fue un sufrimiento para todos, empezar a mencionarlo duró casi dos años. El paciente nos ayudó sugestivamente con un acting psicótico en pleno tratamiento: su intento de suicidio con fuego. Presentó a los ojos de la madre su cuerpo ahora tostado. En aquel momento utilizando una interpretación dramatizada, les dije: "Ahora sí me quieres, también aún así después de esto me aceptás". El paciente recordó que cuando era chico se cortaba el pelo para ver si le crecía de otro color, o si había alguna inyección que cambiara la pigmentación de la piel. El padre reconoció que había escrito varias cartas a EEUU buscando tinturas o tratamientos que cambien la coloración de la piel.

Pensemos en la re-presentación del cuerpo ante la mirada de la madre como tostado. Esto fue clave.

Pensemos en la mirada. La mirada materna catectiza a un cuerpo natural y lo transforma en soporte de una significación, de un deseo de otro.

Con respecto a esto J. Lacan en su trabajo: "El estadio del espejo como formador de la función del yo "nos dice..." basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. El sujeto del cuerpo fragmentado pasa a una situación de ilusión de completud en forma anticipatoria a pesar de su estado de inmadurez y de indefensión.

Freud en el Proyecto de una Psicología para Neurólogos plantea el problema de la vivencia de satisfacción. Esta es la que organiza el deseo y transforma al sujeto en humano. El otro es soporte del alivio de una necesidad pero además catectiza, erogeniza. Desde la fragmentación a la completud mediante el auxilio del otro materno.

Debemos realizar un elogio del narcisismo. El sujeto se pierde en la imagen que de rebote le brinda el objeto, pero a la vez se encuentra en una imagen jubilosa que supera la indefensión. El otro materno es un lugar "salvador" y también un lugar de alienación si el otro no interviene para rescatarlo de la madre fálica. Pero deseo privilegiar en este momento el encuentro con el otro de la identificación como un lugar de superación de la indefensión original.

El paciente fue repitiendo con distintos objetos maternos sustitutivos esta carencia de ser. Ser que es siempre, en un principio, una posibilidad de ser tenido por otro. La novia que no lo acepta, la gente que se burla de su albinismo, la gente que se aleja de él. ¡Ahí va al blanco ¡¡Blanco de las críticas!! Blanco para jugar al tiro al blanco ¡¡Blanco de tiro!! Me estoy refiriendo a distintas asociaciones que el paciente fue teniendo, en las reuniones familiares, de sus temores transformados en su momento en alucinaciones y delirios.

La mirada tiene, sostiene. La mirada está siempre sostenida por una palabra que la sustiene. Freud lo recuerda en este párrafo:

—Tía ¡Cuéntame algo, tengo miedo, está todo tan oscuro...!

—¿De qué te serviría, si no puedes verme?

—Eso no importa; en cuanto alguien habla ya hay claridad. (Standard Edition Tomo VII).

3. El problema del amor

El paciente en terapia ocupacional realiza un modelado en cerámica en donde surge un robot y un mundo. Comenta que se siente como un robot e inscribe sobre él: "para que continúe yo debo aceptar mi muerte". Otro día realiza una esfera sin terminar y la describe como un mundo frágil. Al día siguiente la esfera sin terminar la transforma en un árbol y comenta "es la vida, tengo ganas de vivir", de repente se levanta abruptamente y dice: "tengo miedo de morirme, quemarme y arder". En Musicoterapia imita un crash que con instrumento musical, realiza el musicoterapeuta, y lo relaciona con una cabeza de feto, embarazo, rotura de cráneo y herejía.

En las entrevistas de familia la madre comenta un recuerdo de los primeros momentos de vida del paciente: "uno sí, ya dos no".

Todas estas situaciones fueron habladas en las reuniones fami-

liares. Es que estaba en juego el infanticidio por parte de la madre, el paciente con su lenguaje "caído" pero no por ello asimbólico mienta una situación de parte en donde no sabe si su destino ha de ser vivir o morir. El robot con su cuerpo fragmentado cual el de un bebé se encuentra dentro de un continente materno (su vientre) en donde el nacer implica previamente romper la palabra del otro materno que es de rechazo. Nacer implica para él la culpa de vivir. Más adelante nos va a comentar: "si yo me curo mi madre se mata". S. Leclair en "Matan a un niño" con respecto a esto nos dice: "no hay vida sin pagar el precio de asesinar la imagen primera, extraña en la que se inscribe el nacimiento de todos". "...ninguna vida de deseo es posible si se suspende el asesinato del niño abandonado, perdido en un desamparo total, solo frente al terror y a la muerte".

El padre lo estigmatiza, asevera la palabra de la madre y me dice: "a mi hijo no le veo capacidad para triunfar".

La Esfinge Tebana (representación según la versión mítica de la figura materna) interceptaba el paso de los transeuntes y si no se respondían a sus enigmas los tebanos morían. El que consiga resolver el enigma de la Esfinge tendrá, en el mito, el reconocimiento de Creonte, Regente de Tebas (figura sustitutiva del padre). El mito en sus diferentes versiones nos dice que Edipo mata a la Esfinge o que la Esfinge se suicida.

Tomo esta parte del mito para resaltar el camino a la humanización en relación con el nacimiento.

En el deseo de la madre solo había lugar para uno, no para dos. Con lo cual lo convierte en idéntico al primero pero con preeminencia de éste. Reino de identidades, de semejanzas. Para diferenciarse el otro se debe convertir en rival, debe matarlo para ocupar el único lugar colocado por la madre. El que es deseado se convierte en un objeto que por sí mismo enamora. Enamoramiento mutuo, que en la fusión es un enamoramiento. El hijo se convierte así en refugio de una completud. El enamoramiento funciona desde el narcisismo, el amor desde la castración. El enamoramiento implica posesión, creer que el otro real tiene; pero no por ello deja de ser una relación de sostén, de catectización. El amor presupone carencias, peaje, tránsito, circulación en la triangularidad.

El gradiente que va desde la donación de la vida (parir), el

enamoramiento y el amor queda reservado al primero. El apres-coup de la adolescencia reactiva toda esta situación en el paciente. Cada logro del hermano en la constelación edípica, cada diferenciación implica la muerte de él como sujeto.

4. El problema de la Agresividad: La Imago del semejante

En una reunión familiar que coincidía con el cumpleaños del paciente, éste se levanta de la silla y ante la mirada atónita de todos enuncia: "te quiero matar".

El dilema como vimos antes estaba marcado desde la impronta materna. El intruso debe morir. Suicidio u homicidio en la teoría psicoanalítica se complementan ya que desde los dos lugares se accede al único lugar de prestigio: ser el falo de la madre.

Lacan en su estudio sobre la Familia Humana nos dice: "¿el estudio de los gemelos confirma esta fórmula? Sabemos que múltiples mitos le atribuyen el poderío del héroe, y, de esa forma, se restaura en la realidad la armonía del seno materno, aunque a costa de un fratricidio" "la violencia del suicidio primordial engendra la violencia del asesinato imaginario del hermano".

La vida del paciente estuvo signada por la gloriosa sombra y el triunfo del hermano, el cual fue proclamado vencedor antes de partir.

En la programación terapéutica se incluyó la reunión vincular con el hermano. Esto fue decisivo. Se elaboró conjuntamente las relaciones homosexuales en la infancia en donde el hermano cumplía el papel pasivo. Sugestivamente el nombre de la segunda hija del hermano lleva el nombre del paciente en femenino.

5. Estructura Familiar

En una sesión familiar comenta: "mi tío me quiso matar con una pistola, yo estaba al lado de mi madre, me la quise coger. El se dió cuenta y me eyaculó sobre mi pierna, estoy embarazado".

En un trabajo publicado en el libro *Letra Freudiana* traté de mostrar como el delirio mismo es la novela familiar del psicótico.

El tío materno ejerció una gran preponderancia y un papel de organizador de la estructura del parentesco. Antes lo fue el abuelo

materno que funcionó como padre sustituto para el padre del paciente.

El suegro lo mantuvo económicamente, le dió casa, trabajo y le enseñó a ser comerciante.

En la Roma antigua el suegro no podía adoptar a su yerno sin antes emancipar a su propia hija casada por él, pues el matrimonio sería incestuoso ya que de proceder así ambos serían hermanos.

El papel del padre siempre estuvo constreñido en su rol por el suegro y el cuñado. La familia conyugal tenía escasa vida propia.

Drama de tres generaciones que se hace patente en el paciente. Este no puede formar un linaje en donde se reconozca trascendiendo la tercera generación y creando la cuarta generación. El como hijo no puede ser padre de... sólo al hermano le corresponde este derecho. No entra en la sucesión de los dones paternos. En Derecho Sucesorio cada una de las porciones que corresponde a un heredero se llama sugestivamente parte viril. El padre donador, sustento de la Tradición, quedó abolido. Porque para ser donador en el Derecho Romano hay que ser propietario de algo. Para poseer hay que tener Palabra. Eso no se compra ni se vende.

La Palabra permite la posibilidad de la autoridad mediatizada por el Poder. Poder con Palabra, con Autoridad, fundando una Tradición, por ende un linaje. Linaje que nos encadena en la cadena de las generaciones. Entrega de nuestra individualidad en la trascendencia de la muerte del narcisismo.

Este es un breve resumen de un trabajo de mayor volumen acerca de la historia de un tratamiento familiar con un miembro esquizofrénico que lleva actualmente casi cuatro años de duración.

Sistemas de parentesco y organización familiar

JUAN CARLOS NOCETTI

Licenciado en psicología - Miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar -

Luis María Campos 317 - 2° B, Buenos, República Argentina.

Suele aceptarse que el punto de partida de todo intento de comprensión psicoanalítica de las relaciones familiares está constituido por el modelo teórico denominado "Complejo de Edipo". La riqueza de este modelo, la incuestionabilidad y validez de su valor explicativo, dejan fuera de toda duda su pertinencia en la tarea de dar cuenta de los fenómenos en juego.

Desde la perspectiva de una teoría de las relaciones familiares pone en evidencia, sin embargo, las limitaciones propias de todo intento de explicar un sistema apuntando a los elementos. Conduce además, frecuentemente, a consecuencias poco fructíferas tanto teórica como técnicamente. La transpolación no crítica de conceptos a él ligados, la reificación de las determinaciones y la definición lineal de las relaciones causales, son algunas de ellas.

Hay pruebas suficientes como para pensar que las relaciones familiares se encuentran organizadas como un sistema. Ello obliga a una inversión en la dirección de nuestras investigaciones, con lo cual el Complejo de Edipo aparece como una consecuencia de las

leyes de organización de ese sistema. Es por esta razón que les propongo comenzar echando una ojeada al sistema de parentesco.

Las hipótesis que intentaré poner a prueba una vez más en este trabajo parten de la distinción establecida por Berenstein (1976) entre la familia pensada y la familia vivida. De pensar a la familia como un sistema de intercambio, de concebir las relaciones biológicas bajo la forma de sistemas de oposiciones.

Para introducirnos en el tema he seleccionado algunos acontecimientos del relato de la vida de una familia. Servirán a modo de ilustración y apoyatura de lo que luego desarrollaré.

"Las dificultades de Concepción comenzaron ocho años atrás, cuando dejó su hogar para ir a estudiar y llegar a ser maestra". Tanto Pedro como Esperanza —sus padres— "gastaban el dinero con gran satisfacción en educarla, con la idea de que cuando se hiciera maestra ayudaría a elevar el nivel económico y social de la familia".

"Un año antes de que Concepción se fuera a estudiar, Pedro conoció a un joven de nombre Juan, huérfano y que por ilegítimo no era reconocido por sus parientes. A los veintidós años Juan permanecía soltero y sin casa propia. A Pedro le simpatizó y lo invitó a vivir con ellos durante ese año". Probablemente ninguno de ellos sabía que estaban tratando de resolver con el otro problemas no resueltos desde su infancia. Por lo que veremos, la hostilidad y el resentimiento hacia padres que los abandonaron.

"Concepción tenía 14 años por esa época y pronto se hizo la novia secreta de Juan. Se las arreglaban para verse cada vez que ella regresaba a casa y, cuando el sueño de la posición elevada como maestra se hubo desvanecido, Juan sintió que podía pedirle que se casara con él. Ella aceptó y su padre también aceptó de inmediato". El apresuramiento quizá no les permitió pensar en lo que en ese contrato los tres intercambiaban.

"Después de la ceremonia del matrimonio civil, la pareja se fue a vivir con la media-hermana de Juan". Quizá por eso "las cosas no marcharon bien. Concepción no podía adaptarse y, cuando quedó embarazada sintió que Juan no la cuidaba en forma adecuada". Probablemente pensara que sus padres la hubieran cuidado mejor. "El se rehusó a que tuvieran una sirvienta cuando el niño nació, así es que, cuando tenía un mes Concepción pidió a su padre que la llevara a casa porque Juan la estaba abandonando".

"Pedro llevó a su hija a casa y, por sus conocimientos de asuntos legales, hizo comparecer al yerno ante el Juzgado con el cargo de abandono". Indudablemente sabía que tenía derechos para reclamar al esposo de su hija por el incumplimiento de los compromisos en aquel contrato contraídos. Lo que no podía saber era la relación que su demanda tenía con el hecho de haber vivido hasta los siete años separado de sus padres. "Todo ello, naturalmente, originó un antagonismo entre los dos". Si bien, pensándolo mejor no fue sino el resultado de un antagonismo.

"Concepción regresó más tarde con su marido, pero él comenzó a embriagarse con frecuencia y a golpearla". Eso no fue obstáculo sin embargo para que quedara nuevamente embarazada y, pocos meses antes de que naciera su segundo hijo, Juan la golpeó tan bárbaramente que Pedro tuvo que llevársela nuevamente a casa".

"Mientras yo viva —le dijo Pedro a Concepción— tu esposo no abusará de tí". Quería a su hija y deseaba que permaneciera en casa por su bien. "Ella, por otra parte, parecía estar de acuerdo". Pero esta vez Pedro tendría que haber sabido que se equivocaba. "Concepción no era feliz en la casa de sus padres. Se puso en contacto con su marido y él aceptó que regresara a su casa siempre y cuando nunca más volviera a hablarle de su familia". Quizá ello iba a servir, por lo menos, para equilibrar las promesas no cumplidas de Juan; él debía saber que ella tampoco cumpliría la suya.

"Cuando Pedro se enteró, prohibió a su familia que volviera a verla. Era por esta razón que Esperanza hacía ahora visitas secretas a su hija. Y no sólo ella, Felipe y Macrina, sus hermanos, también la visitaban. Como Juan y Pedro habían prohibido que se vieran, debía escoger con todo cuidado el momento de hacerlo".

"Pero ahora era Felipe, el hijo mayor, quien quería casarse. En realidad el matrimonio era lo último que Pedro deseaba para sus hijos. El peso económico de la boda, los regalos a la novia y a su familia, el mantenimiento de la nuera mientras Felipe viviera con ellos, todo eso era más de lo que podía soportar. También desanimaba los intentos de su hija Macrina por aparecer arreglada y bonita."

"Esperanza tenía una actitud parecida. Si hubiera tenido necesidad de una nuera que la ayudara a cuidar de los hombres de la casa hubiera sido diferente. Pero tenía una buena ayudante en Macrina.

Esta, por su parte, si bien pensaba en el casamiento, no estaba segura. Le gustaría casarse con un protestante y poder conservar la religión de su padre. Si no, tendría que convertirse y no quería hacer eso. Era preferible quedarse en casa con sus padres". (LEWIS, Oscar, 1964)

"En verdad, ¿qué podía ganarse con el cambio de familia?, un marido no es siempre una protección tan segura como los padres. Y estos, ¿qué beneficio podían obtener al entregar a su hijo en matrimonio y recibir en cambio una nuera? La ganancia del matrimonio no lograba compensar las pérdidas en el patrimonio.

Pero estas cuestiones nos conducen al estudio de los sistemas de parentesco.

Como aspecto de la organización social, los estudios acerca del parentesco comenzaron en el siglo XIX. Algunos juristas, sorprendidos por las diferencias notables entre las distintas regiones en cuanto al derecho de familias, trataron de explicarlas mediante la teoría de la evolución, entonces en boga. Las reglamentaciones del matrimonio, la paternidad, la legitimidad, la herencia y la sucesión fueron contemplados por estos estudios comparativos. Trataban sobre hechos básicos de la vida social: las relaciones sexuales, el nacimiento y la muerte.

Aun cuando estos hechos de la vida son comunes a otros mamíferos, ninguno de ellos, ni siquiera los primates pueden recordar a sus antepasados hasta la cuarta generación ni denominar a su "prima matrilateral", anunciando biológicamente pueda poseer a tal pariente. Les es imposible por lo tanto atribuir a esas relaciones algún significado legal, político, económico o religioso. No es, por supuesto capaz de impedir el apareamiento con semejante deudo. El hombre puede hacerlo y lo hace a veces de maneras muy complicadas.

Así como en los mamíferos, la continuidad de la especie humana está asegurada por la división sexual. La mujer está dotada para la gestación, el alumbramiento y la lactancia. Surge de este modo la relación madre-hijo, el más sólido de los lazos sociales. Los varones, lo sepan o no, están capacitados para fecundar a las mujeres. Este da lugar a la relación de alianza.

Las leyes biológicas obligan a los seres humanos a la cópula heterosexual, si es que desean tener descendencia. Pero esas leyes no

determinan cuál de los varones o mujeres disponibles debe ser elegido para ello. La elección queda librada al azar. Esta libertad se encuentra sin embargo restringida y son muchos los científicos que opinan que esa interdicción a la libertad sexual es uno de los fundamentos de la cultura. Me estoy refiriendo al Tabú del Incesto.

El hecho inesperado de su universalidad llamó la atención de los antropólogos y pronto observaron que las denominaciones del parentesco cumplen la función de diferenciar los grados prohibidos y proscriptos para las relaciones matrimoniales. Si las relaciones sexuales no se encontraran reguladas, muchas de las complicadas medidas que ordenan las relaciones familiares serían innecesarias.

Con todo la relación madre-hijo sigue siendo básica, cualquiera sea la forma en que aquella fue fecundada. Es una relación biológicamente determinada y empíricamente verificable. Que el padre conviva con la madre de modo más o menos permanente es algo sujeto a variación. El reconocimiento del papel procreador del padre puede oscilar desde firmemente aceptado hasta simplemente inexistente en diferentes culturas.

La maternidad es un hecho dado, que al padre se le pueda permitir o no la permanencia en el hogar es un problema de otro orden, de orden cultural. Pero, a partir de estos hechos pueden desprenderse tres principios básicos para la comprensión de la organización de las relaciones familiares:

- 1º) las mujeres gestan, alumbran y lactan niños;
- 2º) los varones fecundan mujeres;
- 3º) los parientes cosanguíneos no se casan entre sí.

El primero de estos principios es el producto de una ley biológica, el tercero lo es de una convención social, el segundo, a medio camino entre ambos, tiene sus raíces en un hecho biológico pero requiere de una convención social para ser validado en todos sus alcances.

Las familias pueden extenderse y así conservar su patrimonio a través del tiempo reclutando parientes de dos maneras: por consanguinidad o por alianza. El reclutamiento cosanguíneo da lugar a las fratrias, los grupos totémicos, los clanes. Son "grupos de filiación" que pretenden descender de un antepasado común. Dada la división sexual, la pertenencia se define de acuerdo a dos modos básicos de filiación: patrilineal o matrilineal.

Un grupo de filiación paterna, por ejemplo, se extenderá gracias a la descendencia. Cuenta para ello con los varones del grupo que, según el segundo principio fecunda mujeres para que tengan niños, debe por lo tanto contar con ellas. Para ello están las mujeres del linaje, pero este apareamiento atenta contra el tercer principio. Este *obliga* al grupo de filiación a buscar, para su varones, mujeres en otro grupo de filiación.

No está de más destacar que este carácter obligatorio —producto a la vez de la prohibición del incesto y del mandato de exogamia— supone un deseo contrario, deseo que queda, conscientemente o no, impedido de realización, más no por ello abolido. A pesar de todo la interdicción opera introduciendo un nuevo principio, el de intercambio y con él la noción de reciprocidad.

El libro del Génesis en su versículo 34 nos ofrece una primitiva versión de estos principios. El príncipe Siquem había deshonrado a Dina, hija de Jacobo, pero se enamoró de ella. Pidió entonces a su padre que la pidiera en matrimonio. Dijo éste a Jacobo:

“...el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija; os ruego que la deis por esposa.
Y emparentad con nosotros; dadnos vuestras hijas,
y tomad vosotros las nuestras.

Aceptó Jacobo el trato y agregó:

“... os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras;
y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo.

Acercáronse entonces el Rey y su hijo a las puertas de la ciudad y así hablaron a sus súbditos:

“Estos varones son pacíficos con nosotros,
y habitarán el país, y traficarán en él;
pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos;
tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras.”

Pero los hermanos de Dina, resentidos por la deshonra sufrida y deseosos de vengarla, a los tres días del pacto tomaron sus espadas y, sorpresivamente, dieron muerte a todos. (SANTA BIBLIA, 1960).

En síntesis, el matrimonio, consecuencia inevitable de una prohibición, afirmación de un mandato positivo que obliga al inter-

cambio entre dos familias, producto de una entrega que es devolución y de un quita que deberá ser reintegrada, sella un pacto de mutua dependencia en la tarea de resolver un problema que una y otra vez plantea a los grupos biológicos la regla antinatural del Tabú del Incesto. Pero introduce con ello entre las dos familias una relación de hostilidad que es, al mismo tiempo, objeto de una reglamentación social.

Diferentes son los modos en que cada cultura intenta una solución a estos problemas, pero todos ellos dependen del régimen de residencia. (LEVY STRAUSS. 1969)

Simplificando la situación, sin que por ello se vea nuestro objetivo alterado, toda familia deberá, además de respetar las normas acerca de la filiación —patrilineal o matrilineal—, decidir acerca de la futura residencia de los contrayentes. Esta podrá coincidir con la del linaje materno —solución matrilocal—, con la del linaje paterno —patrilocal—, o con ninguna de ellas —neolocal—.

Desde un punto de vista lógico, la solución más simple, partiendo de la unidad madre-hijos, es la que logra reunir la matrilinealidad con el régimen materno de residencia. Los hijos serán así herederos del linaje materno y de su patrimonio. Los hermanos podrían, respetando los dos primeros principios, perpetuar el linaje y la propiedad reclutando por medio de la procreación nuevos miembros para el linaje. Pero el tercer principio impide esta solución. Si lográramos definir a las relaciones cosanguíneas como más importantes que los lazos de alianza y fortalecer de esa manera el patrimonio a expensas del matrimonio, la solución sería sencilla: “importemos” varones desde otros grupos de filiación para que fecunden a nuestras mujeres y cedamos los nuestros para sus hermanas. Una vez realizado esto, cada uno volverá a su localidad para cuidar su patrimonio y los hijos de las hermanas.

En esta solución, los vínculos de cosanguinidad son sólidos y estables, no así los de alianza. Lo que interesa son los nuevos miembros del linaje, y los maridos no lo son. No hay motivo por lo tanto para hacer del matrimonio una relación obligatoria y duradera.

Hay comunidades que han adoptado esta solución —la casta guerrera de los nayar, en el suroeste de la India, por ejemplo— y he visto también familias que consultan que parecen inclinarse por esta modalidad. Allí las separaciones son frecuentes y la causa ha-

Juan C. Nocetti

bría quizá que buscarla en la preponderancia del linaje materno y en el peso del patrimonio en juego.

Muchas familias de clases altas —que por algo conservan el apellido materno— y de grupos marginales —donde el apellido paterno suele desaparecer— se encuentran organizadas de este modo.

Si la solución se orienta en cambio hacia un reclutamiento desde el patrilineaje serán miembros los hijos de los hermanos, no los de las hermanas. Si a ello se agrega un régimen de residencia patrilocal, la subordinación de las esposas a la familia paterna será grande. A fin de preservar el tercer principio, deberá ahora, “importar mujeres, pero, además de mantenerlas hasta que sean fecundadas, deberán hacerlo durante nueve meses más y, finalmente, hasta que por lo menos la lactancia haya concluido. Es pues menester que el vínculo de alianza sea estable. No podrá ser un apareamiento casual y temporario como en el caso anterior. El poder del patrimonio pesará, pero el matrimonio hará valer sus derechos, aun cuando subordinados a la patria potestad, problema que en el caso anterior carecía de importancia. Los lazos de cosanguinidad entre los hermanos se encuentran también debilitados. Las mujeres no sirven para reproducir el linaje, se irán a ser fecundadas a otros grupos de filiación y no pertenecerán ya al linaje paterno.

Los Tallensi, al norte de Ghana, son un ejemplo de esta solución, así como algunas de las familias que consultan, en general, y con algunas variantes, ligadas a la comunidad italiana o campesina.

En las dos modalidades citadas, la nueva pareja encuentra un lugar en el seno de alguno de los linajes. Recibe, por el sólo hecho de su pertenencia, parte del patrimonio. Pero, si por alguna razón, los bienes o el territorio fueran escasos y no pudieran dar cabida a las esposas, o a los esposos, ambas soluciones no serán viables.

Se impone pues otra vía: buscar un nuevo habitat para la nueva pareja y producir los propios bienes. Cuando los hermanos llegan a la madurez se ven entonces obligados a abandonar el reducto de los linajes. Esta solución neolocal obliga a la dispersión de los miembros del linaje. Debilita con ello los lazos cosanguíneos y consolida aún más las relaciones de alianza. Con todo la participación de los linajes no será nula. Desde la prescripción del matrimonio con la hija del hermano de la madre —origen de la relación avuncular

entre el sobrino y el tío materno— hasta la elección por razones raciales, religiosas, económicas, políticas o sociales, los grupos cosanguíneos intervendrán en forma más o menos activa.

Bien lejos estamos, llegados a este punto, de los libres apareamientos regidos por leyes naturales. Es que, si bien la organización familiar tiene sus raíces en el orden biológico, ha devenido fenómeno cultural. Es como tal que puede ser pasible de un estudio rigurosamente psicoanalítico.

Pero la raíz biológica de los intercambios matrimoniales no ha sido trascendida gratuitamente. Toda vez que la organización familiar deba enfrentarse con una situación crítica, sus fundamentos serán puestos a prueba y aquella se revelará, en última instancia, como una contradicción entre las leyes naturales y los mandatos culturales. Esta contradicción deberá ser resuelta una y otra vez por los miembros de las familias.

Es que la prohibición del incesto ha obtenido su significación a partir de discriminar y oponer dos sistemas de relaciones que, sin su presencia, podrían ser confundidas y homologadas: las relaciones de cosanguinidad y las de alianza. Allí donde exista la cosanguinidad no podrá haber alianza y viceversa. Esta oposición obliga al intercambio entre dos familias y, en la medida en que es una mujer lo intercambiado, no podemos evitar el modelo avuncular para pensar ese intercambio. El representante de la familia materna, como lo ha denominado Berenstein (1976), define el carácter cultural de la organización familiar.

El representante de la familia materna que permite resolver la prohibición a través del intercambio introduce, sin embargo y al mismo tiempo, una contradicción inevitable, una hostilidad en el seno de las relaciones familiares. Antagonismo que cuenta entre sus manifestaciones más generalizadas las prohibiciones que recaen sobre las relaciones entre el yerno y la suegra “uno de los lados más espinosos de la organización familiar”. “E. B. Taylor opina que la actitud de la suegra con respecto al yerno no es sino una forma del no reconocimiento de este último por la familia de su mujer. El hombre es considerado un extranjero hasta el nacimiento de su primer hijo” (FREUD, S. 1913).

Pero es entonces, con la presencia de la descendencia, cuando aquel antagonismo se extiende oponiendo ahora a las relaciones de

filiación —culturalmente definida entre padre e hijo— las relaciones avunculares —entre éste y la familia materna— que suelen asumir un carácter sagrado y sobrenatural.

La solución conyugal a la interdicción del incesto resuelve algunos de los problemas planteados a las opciones apoyadas en la continuidad del linaje, pero revela otros que aquellos resolvían. En primer lugar, obliga a un mayor desprendimiento de las familias de origen, de aquí que, en segundo término, exija a los contrayentes un mayor grado de desarrollo, un mayor tiempo de aprendizaje social, una mayor aptitud en cuanto a la capacidad para autoabastecerse. Está por lo tanto sujeta a mayores riesgos. Las exigencias son, sin embargo, asimétricas: la mujer deberá seguir al marido donde aquél vaya y éste tendrá que poder ser el sostén económico de la familia.

Esta asimetría es concordante con la que corresponde a las vicisitudes del Complejo de Edipo y su final en el varón y la mujer. También el desprendimiento de sus respectivos linajes ostenta esta marca. El de la mujer es más penoso y prolongado y no poco colabora con ello el hecho de que, debido a la patrilinealidad, el apellido materno suele perderse.

¿Qué ofrece el marido en compensación ante tanta pérdida? En principio la posibilidad de culminar un proceso que hace a su desarrollo psicosexual. Pero ello se equilibra con la seguridad y las gratificaciones infantiles que la ligan a sus parientes cosanguíneos y a éstos con ella.

De aquí que la tensión entre las relaciones de alianza y las relaciones de cosanguinidad sea constante. En algunos períodos franca y manifiesta, en otras latente y a la expectativa de una crisis. Con todo, su persistencia es la mejor solución que puede plantearse a lo que en este contrato participan el marido, la esposa y un representante de su familia.

Porque si el varón no ha alcanzado el grado de desarrollo que aparece como condición de la alianza conyugal, puede intentar ahora alcanzarlo a expensas de la familia materna, con lo cual la sobrecarga será excesiva para todos.

Dos vías se abren en este caso: Que la tensión se resuelva en subordinación gratificante, en complicidad perversa donde, tras una fachada de legalidad suelen esconderse la estafa, el robo, la droga-

dicción, la transgresión en fin siempre al borde del escándalo. O bien se exacerbe en una hostilidad delirante e irreconciliable donde el sabotaje y la impotencia impiden la concreción de todo proyecto compartido.

Pero no son estas sino algunas de las transformaciones posibles de un modelo constitucional de las relaciones familiares. Una estructura desconocida por quienes la ponen de manifiesto a través de diferentes configuraciones, determinante del modo de organización familiar que ellos mismos, sin saberlo, reproducen y perpetúan, universal en la medida en que responde a la correlación de dos oposiciones o bien deducidas lógicamente a partir del Tabú del Incesto, o bien establecidas inductivamente a partir de la observación.

Este modelo constitutivo surge de la puesta en correlación de dos relaciones contradictorias: un eje definido por la oposición entre las relaciones de cosanguinidad que unen a la esposa con su familia y las relaciones de alianza entre aquella y su marido. Otro eje, que incluye a la descendencia y opone a las relaciones de filiación de un padre con su hijo, las relaciones avunculares de éste con la familia materna.

Este modo de concebir las relaciones familiares surge del pensar las relaciones biológicas bajo la forma de sistemas de oposiciones. Oposición entre los lazos cosanguíneos y los de alianza, entre las relaciones de filiación y las avunculares, entre las series diacrónicas y las series sincrónicas, entre los varones y las mujeres, entre el matrimonio y el patrimonio, entre el orden de la naturaleza y el orden de la cultura. Oposiciones en fin en las que debe buscarse el punto de partida de una tentativa de explicación de los fenómenos en juego.

Es, en suma, la hostilidad, garantía del cumplimiento de estas oposiciones nacidas del mandato cultural de exogamia, la que ha sido objeto de una reglamentación social. Reglamentación que impone al matrimonio la tarea de resolver las mismas contradicciones que le han constituido.

Veamos, para poder volver a pensar, las dificultades por las que atraviesa una pareja que ha solicitado tratamiento.

Daniel y Olga consultan porque hace ya un año que se conocen y no pueden formalizar su relación. No saben bien por qué, pero a ambos les da miedo. No es, sin embargo, la primera vez que lo in-

tentan; ambos son ya separados.

Olga está tramitando su divorcio de Esteban, con quien estuvo casada durante seis años. Vivieron en el mismo edificio de departamentos de la madre de Olga y durante los primeros años se llevaron bien. Hasta que nació Claudia, Esteban empezó a percibir que su hija pasaba demasiadas horas en el departamento de sus suegros y que estos finalmente la malcriaban. Las discusiones comenzaron a hacerse interminables y Olga empezó a tener encuentros esporádicos con otros hombres a sabiendas de su marido.

Eran aventuras sin importancia, no iban más allá de un primer encuentro, hasta que apareció Daniel. Salieron primero como amigos pero pronto la relación se hizo más intensa. Lamentablemente una tarde fueron vistos y debieron sostener una fuerte discusión en la casa de los padres de Olga. Es decir, en el mismo lugar donde, según Esteban su hija era malcriada.

El padre y el marido encararon la situación con sentido práctico y serenidad. Daniel estaba seguro de su cariño y sostuvo que estaba dispuesto a casarse con Olga. Pero la madre, lejos de tranquilizarse con esas razones, los increpó con suma dureza. Sostuvo que Daniel era un desfachatado: "Ya tuviste otros matrimonios —le dijo— y los destruiste, ahora querés destruir también el de mi hija. Pero vos a la nena no te la vas a llevar, para eso estoy yo, para impedirlo". Por esto Daniel opinaba que era necesario hacer un tratamiento porque hasta que Olga no arreglara los problemas con su madre era inútil proponer una fecha de casamiento.

La madre de Olga no podía saber, claro está, que en realidad tampoco había permitido que se llevaran a su hija antes, cuando se casó con Esteban, que éste, con "sentido práctico" había aceptado la situación al igual que Olga y su padre y que Claudia vino seguramente a poner de manifiesto una hostilidad que hasta ese momento había podido ser soslayada. Vino a confirmar que la estabilidad de la alianza se oponía a la matrilocalidad que, al modo de un síntoma, ocultaba y revelaba al mismo tiempo el peso de la cosanguinidad.

Pero con todo, quizá no deja de tener razón la madre de Olga en cuanto a las consecuencias de las honestas intenciones de Daniel. Efectivamente, no es esta para él la primera vez que enfrenta un nuevo matrimonio. Ya sus padres se habían separado. Cuando tenía nueve años lo pusieron en un colegio pupilo y se enteró al volver

que su padre había hecho abandono del hogar y se había ido a vivir con otra mujer. Su madre siempre le habló bien de él, pero nunca perdonó a quien se lo había quitado.

Probablemente la madre de Olga esté tratando de hacernos saber su temor, quizá no consciente, de que el daño que esa mujer hizo destruyendo un matrimonio y quitándole un padre, pueda ser ahora equilibrado por Daniel con el intento de destruir otro matrimonio, quitando así una mujer a su esposo y una hija a su madre.

Pero Daniel no quiere apresurarse, sabe por experiencia que las separaciones no son el comienzo sino la culminación de ciertas condiciones críticas presentes en el contrato de alianza. Teme, quizá tenga razones para ello, que se transforme ésta en su cuarta separación.

Los líos con Paula, su primera mujer, aparecieron "cuando se enganchó en un problema con su madre". Como ella vivía en San Luis, no estaba al tanto del concubinato de su hija con Daniel, así es que decidió, intempestivamente, visitarla. "¿Qué hacemos ahora?" preguntó Paula. "Y qué se yo, andate a un hotel y cuando se vaya volvés". Pero ella tuvo una solución mejor, casarse, y él, para no entrar en discusiones, aceptó. La madre comenzó al poco tiempo a llenarle a Paula la cabeza de celos: que él no trabajaba, que llegaba tarde por las noches, que no la respetaba... Terminó yéndose, y ellas también, a San Luis, con un hijo de ambos.

Al año conoció a su segunda esposa. Estaba desocupado y como el hermano de ella tenía una estación de servicio, lo puso como socio. Ellos no tenían por qué saber que era ésta una complicada manera de comenzar, que participar en el patrimonio de la familia materna incrementaba las deudas surgidas del matrimonio. Quizá por esto todo anduvo bien "hasta que la familia empezó a molestar". Habían empezado viviendo solos pero ella fue volviendo por diferentes razones a la casa de sus padres. Terminaron todo allí, viviendo en la planta alta después del nacimiento de la primera hija. La situación se hizo cada vez más tirante y finalmente Daniel decidió irse. Como la resolución fue excesivamente abrupta, le prohibieron volver a ver a sus hijas.

Quedó nuevamente sin trabajo, pero se encontró con Adela, su tercera esposa. Como vivía sola, lo invitó a quedarse. Todo anduvo bien hasta que quedó embarazada. La familia de ella, que lo quería

como a un hijo, comenzó a insistir que era mejor legalizar la situación. Una vez más aceptó, pero los celos de Adela hicieron imposible la convivencia. No podía soportar que su propia madre les pasara dinero, les hiciera regalos y les ofreciera finalmente un lugar para vivir.

Daniel no quiere volver a repetir los mismos errores. Vive en un departamento de un ambiente. Para él solo es suficiente, pero no para los tres. Por eso han pensado en instalarse en el departamento que Olga y su marido han abandonado luego de la separación. Como se encuentra ubicado en el mismo edificio donde viven sus suegros, Daniel exige que los problemas de Olga sean primero solucionados, de otra manera, la convivencia va a ser difícil. Por supuesto, ninguno de ellos puede estar al tanto de que quizá están preparando el terreno para una cuarta separación de Daniel. Es que no tienen por qué haber llegado a conocer nuestro modelo para pensar sus relaciones.

Con todo, a Olga le ha molestado la actitud prescindente de Daniel. Cuando su madre lo insultó, tuvo que hacerse frente ella sola. A pesar de eso habló francamente con su madre: "te molesta le dijo, que yo me anime a hacer lo que nunca te atreviste vos". Hace ya años, su madre fue una tarde a buscarla a la salida de la escuela. Salieron a pasear y se encontraron con el socio del padre de Olga. Fueron a tomar algo juntos y su madre le pidió que no comentara nada de todo eso. Con los años comprendió que se trataba del amante de su madre. Por temor a enfrentarse con su marido y con sus propios padres, nunca se atrevió a separarse.

Olga no puede estar al tanto de que quizá esté buscando en Daniel al amante deseado por su madre para realizar con él un deseo que ésta no pudo realizar. La preponderancia del linaje materno y la matrilocalidad crean las condiciones, con la involuntaria complicidad de Daniel, para que este deseo pueda llegar a verse cumplido.

No es imposible, desde el modelo Edípico, poner de manifiesto las determinaciones ocultas en cada contrato matrimonial. Es que la función de la historia es mostrarnos la reiteración de las mismas configuraciones y poner en evidencia que aquí también, iguales reglas enfrentadas con idénticas circunstancias producen efectos similares.

Lo que seguramente este modelo no contiene es esta siste-

mática oposición entre alianza y cosanguineidad, entre patria potestad y matrilocalidad, entre matrimonio y patrimonio.

Consecuencias inevitables del Tabú del Incesto, estas oposiciones definen la estructura constitutiva de la organización de las relaciones familiares. El grado de abstracción y generalización que estas reglas ostenta hace que, al margen de las censuras a su conocimiento, difícilmente la conciencia de los miembros de una familia pueda acceder a ellas y menos aún, relacionarlas con su modo de organización y su comportamiento. Pero, por otra parte, estas son metas terapéuticas, no objetivos de vida.

Bibliografía

- BERENSTEIN, Isidoro: "Familia y enfermedad mental". Paidós. Bs. As. 1976.
 FREUD, Sigmund: (1913) "Totem y Tabú". Biblioteca Nueva. Madrid. 1948.
 LEVY-STRAUSS, C.: "Estructuras elementales del parentesco". Paidós. Bs. As. 1969.
 Sociedades Bíblicas en América Latina: "Santa Biblia". 1960.
 LEWIS, Oscar: "Antropología de la pobreza". F.C.E. México. 1964.

Buenos Aires.
 Noviembre de 1978.

Aportes de Enrique Pichón Riviere a la Terapia Familiar (un caso clínico)

ALEJANDRO SICARDI

*Médico. Profesor de la primera escuela de Psicología Social. Egresado de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
French 2647 - 3° D, Buenos Aires, República Argentina.*

Pichon Riviere, define a la familia, como la estructura social básica configurada por un interjuego de roles diferenciados.

Define a la locura, como nuestra expresión de la incapacidad para elaborar y soportar determinado monto de sufrimiento.

La relación de causalidad que existe entre la estructura familiar y el emergente psicótico o enfermo, no es una relación de causalidad directa y mecánica, sino que se trata de una causalidad gestáltica, en el sentido de que todas las tensiones de la estructura, convergiendo en un punto dado, hacen salir un emergente. Quiere decir es un todo actuando a través de uno.

Hay un desajuste en la estructura familiar, que puede deberse por ejemplo, a la pérdida del liderazgo del padre u otro. En la familia el enfermo es el portavoz de las ansiedades del grupo. El paciente como integrante, desempeña un rol específico: el depositario de las tensiones y conflictos grupales.

El estereotipo de la situación se configura cuando la deposición es masiva. El sujeto queda paralizado, fracasa en su intento de

Aportes de E.P. Rivière a la Terapia Familiar

elaboración de una ansiedad tan intensa; se produce un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo y el sujeto enferma. Con esto se produce la segregación por la peligrosidad de los contenidos depositados. Sería el miedo al retorno de lo depositado, que tiene que ver con el concepto de Pichon de las tres "D", que consisten en el depositante, el depositario y lo depositado. Agrega Pichon, que en las terapias del grupo familiar, la familia se transforma en una empresa, cuyo objetivo, cuya tarea, es la curación de uno a través del esclarecimiento de todos.

Es importante tener en cuenta lo mucho que subrayó el concepto de tarea Pichon, especialmente en un trabajo que se denomina: "La noción de tarea en psiquiatría" del año 1964.

Escribió cuatro trabajos específicamente dedicados a la familia, aunque el concepto de familia lo tiene asiduamente. Uno de ellos es "El empleo de Tofranil en psicoterapia individual y grupal", "Tratamiento de grupos familiares: psicoterapia colectiva". Estos dos trabajos del año 1960. "Grupos familiares: un enfoque operativo", es un curso que dicta entre los años 1965/66. Ahora que digo esto me acuerdo que Pichon, dictó un curso en este mismo lugar en el año 1968, donde hablaba sobre Freud, Melanie Klein y Faibain. Y finalmente "Una teoría del abordaje de la prevención en el ámbito familiar" en el año 1970, trabajo que presenta en una mesa redonda durante el desarrollo del Congreso de terapia familiar.

Yo me voy a dedicar especialmente al segundo de los artículos mencionados, o sea: "Tratamiento de grupos familiares; psicoterapia colectiva", no sólo por una cuestión de tiempo, sino porque me parece que es uno de los trabajos más ricos, desde el punto de vista práctico, de Pichon con respecto al grupo familiar.

Este trabajo lo voy a hacer con la presentación de un material clínico, con la idea de que pueda haber un enriquecimiento mutuo: es decir, que los conceptos teóricos del artículo puedan enriquecer al material clínico y que el material clínico sirva para entender mejor los conceptos teóricos.

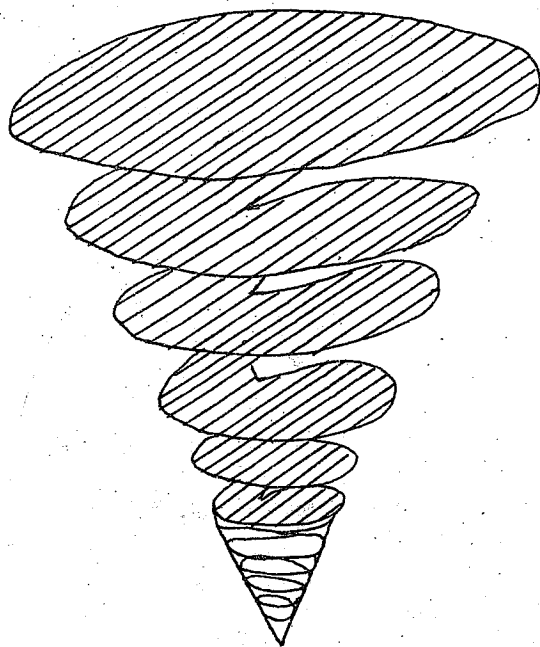
Pichon en "Tratamientos de grupos familiares...", en este artículo, ha inventado un modelo esquemático que es el de un cono invertido, en cuya base sitúa los explícitos o situaciones manifiestas; es decir, el material de una sesión, por ejemplo.

Hacia el vértice, no el vértice, lo cual implica un movimiento,

los implícitos o situaciones universales. Las llama situaciones universales porque las ha observado después de trabajar muchos años, en prácticamente todas las familias.

A través de la interpretación, que para él es hacer explícito lo implícito, se va a ir realizando un trabajo en forma de espiral dialéctica, donde a medida que se va levantando cada capa, lo implícito de antes va a pasar a ser lo explícito y así sucesivamente. Este trabajo permanente, se va a dar no solamente en una sesión, sino en el transcurso de todo un tratamiento.

La idea sería de un cono invertido, recorrido por un espiral desde su base hacia el vértice, y un corte horizontal o mas bien oblicuo, que siguiera este espiral.



Los universales estarían en el vértice y serían cinco: 1° Los miedos básicos, que para Pichon son: el miedo a la pérdida de una estructura anterior y el miedo al ataque de una nueva situación estructural.

2° La situación terapéutica negativa. Estaría relacionado con el miedo al cambio y la resistencia al cambio. Como van a ver en el

material clínico, se visualiza a través de los sabotajes ante los progresos realizados por el paciente. Vamos a adelantar algo: en esta familia el padre era un jugador y los sabotajes se hacían a través de jugar grandes cantidades de dinero, con lo cual se ponía en peligro la persistencia del tratamiento.

3° Sentimientos básicos de inseguridad. La fórmula, dice Pichon, sería: más vale pájaro en mano que cien volando.

4° Proceso de aprendizaje y comunicación. Por procesos de aprendizaje se entiende el reaprendizaje de la realidad, no solamente la comprensión de la historia verdadera, sino el aprendizaje de roles perdidos o nunca ejercidos. Esto es importante, porque yo creo que hay dos tendencias dentro de la terapia del grupo familiar: una sería el propender a la comunicación y al encuentro de la familia y al poder estar unos con otros y hablar. Y hay otra tendencia que consiste en una investigación más bien histórica y arqueológica. Yo creo que Pichon plantea como una síntesis entre estas dos tendencias y lo especifica cuando dice en este punto que "la comunicación es el riel del aprendizaje"; es decir, cómo si no se pudiera recuperar la historia y el grupo no pudiera llegar a que donde está la novela familiar, pase a estar la historia familiar, si no se reparan y arreglan las redes comunicacionales distorsionadas y fracturadas.

5° Las fantasías básicas referidas a la enfermedad, a la curación y el tratamiento. La familia tiene fantasías con respecto a la enfermedad, distintas de las que puede tener el terapeuta; es decir, el terapeuta puede tener la idea de que la enfermedad es una manera de curarse en realidad y que los delirios y las alucinaciones son fenómenos restitutivos de la libido. Las fantasías que tiene con respecto a la curación una familia, por lo general la más común, es que la curación sería que el analista lo transforme al paciente en lo mismo que era antes; o puede sentir que el analista les va a hacer sentir culpa; o que va a ser juez que va a dictaminar quien tiene razón y quien no.

Pichon dice que el terapeuta se manejará con un ECRO específico, para trabajar con familias, en donde hay once puntos: 1. Portavoz. El enfermo es el portavoz de la enfermedad grupal. Esto creo que ha quedado mas o menos explicado en esa especie de prólogo que hice. De todas maneras esto va a ser retrabajado junto con el material clínico.

2. Análisis de los roles. Por ejemplo, esclarecer el rol de un padre al que se haya adjudicado un rol materno; o el rol de un hijo que este cumpliendo un rol paterno, como va a aparecer en el material clínico.

3. Análisis de las ideologías o prejuicios. El prejuicio o los prejuicios son normas en decadencia; es decir, una norma es algo que puede tener una utilidad práctica, pero si se la sigue usando cuando ha perdido esa utilidad práctica, es un prejuicio. Por ejemplo en una época, cuando nosotros eramos chicos, existía la idea del ahorro y tanto en nuestras casas como en los colegios se decía que el ahorro es la base de la fortuna, y teníamos en casa alcancías y en los colegios había libretas de ahorro. Si alguien mantuviera esta idea hoy, del ahorro con una alcancía, sería un prejuicio.

4. Análisis de los malentendidos básicos. Estos no hay más que verlos en el trabajo clínico.

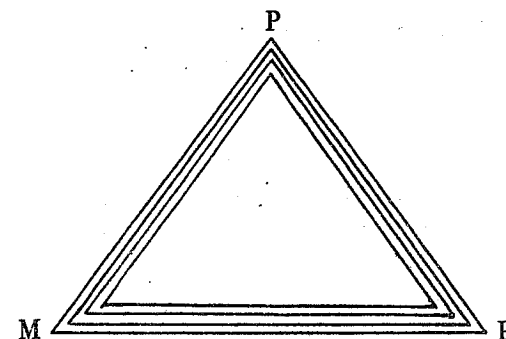
5. Análisis de los secretos familiares. Este es un punto muy importante porque se presta para hacer una investigación con respecto a otros conceptos, si ponemos al lado de este de secretos familiares, la idea de metacomunicación, familia inconciente de Sirlens, inconciente transpersonal de Framo, o estructura familiar inconciente de Bernstein.

6. Análisis de los mecanismos de segregación. Pichon, lo vamos a ver mejor en el material clínico, dice con respecto al mecanismo de segregación de que el psiquiatra ve la segregación cuando ya esta declarada, cuando el paciente se lo interna en el hospicio por ejemplo, pero que existe previa a esta segregación manifiesta una segregación sutil. El paciente habitualmente esta segregado por una falta de comunicación en general de problemas que hacen al ser adulto dentro de la propia familia. El siente que pasan cosas pero no sabe bien qué pasa; es decir, que la segregación a un sanatorio o a un hospicio, no hace más que legalizar una situación que ya está dada.

8. Análisis de los mecanismos de preservación. Estan relacionados con los mecanismos de segregación y estarían relacionados con el miedo al retorno de lo depositado.

9. Análisis de las fantasías de omnipotencia e impotencia. Habitualmente esto se proyecta sobre el terapeuta, el cual se lo ve como capaz de todo o incapaz de hacer nada.

10. Análisis de la situación triangular básica. La situación triangular, Pichon la describe como compuesta por doce vínculos, cuatro por cada lado. Estos cuatro vínculos estan dados porque el hijo siente que quiere al padre y el feedback siente que es querido por el padre, y siente que odia al padre y es odiado por el padre. Cuando los vínculos de un lado son positivos, se dan como negativos en el otro. Pichon subraya la importancia del segmento que va de la madre al padre, en general bastante poco tenido en cuenta, quizás mas tenido en cuenta por los terapeutas familiares. También subraya la importancia del padre en la situación triangular, sobre todo en las primeras épocas, del cual dice que es peligroso y operativo justamente por los escamoteos.



11. Evaluación de los medios o logística. El terapeuta familiar debe tener muy en cuenta todas las posibilidades con que cuenta.

12. Análisis de las fantasías inconscientes. Para Pichon las fantasías inconscientes son el proyecto o la estrategia totalizante de una acción sobre la base de una necesidad.

El último concepto es mío y consiste en lo que yo llamo "quedar en descubierto". Sería en resumen, cuando un padre o una madre tienen cierta conducta con respecto al hijo, para que no tenga que quedar en descubierto la actitud que a su vez el padre o la madre tenían con ellos. Es decir que el padre sobreprotege al hijo por ejemplo, para no darse cuenta de que lo sobreprotegeron a él; o que le

pega para que quede normal o natural el hecho de que le hayan pegado a él. Pueden ser cosas más específicas, por ejemplo inducirlo a jugar a cualquier otro tipo de cosas. Ahora esto de quedar en descubierto es entre comillas porque no es el padre si empieza a ser bueno con el hijo en ese aspecto específico, empieza a darse cuenta de que el padre no era así con él; en general esto no ocurre. Lo que ocurre es que esto se traduce por una depresión clínica. Sí puede quedar realmente en descubierto en algún caso especial o a través de las interpretaciones.

Bueno, vamos al material clínico.

Se trata de una familia que denominaremos Rodríguez. Es una familia que yo vi hasta el año 1975, de 1970 a 1975 y los veo muy esporádicamente ahora.

Esta constituida por la madre, a la que llamaremos Alba, de cuarenta y nueve años, que aparece vestida con negligencia, sin cosméticos, con cara de aflicción y cansancio. Fue la hija mayor de una familia árabe de diez hermanos, que vivía en el campo. Su padre eran vendedor ambulante. Los estudios son hasta tercer grado.

El padre, el marido de Alba, Luis Roberto, tiene cincuenta y cinco años. Es santafecino, de aspecto bastante acicalado, trabajó en el puerto y en frigoríficos. En el momento en que yo los veo, ya estaba jubilado. Sus padres murieron y tiene hermanos que hace mucho que no los ve.

Luis el hijo mayor; tiene veintisiete años, esta recién casado. Viene la primera vez para acompañarlos y después no viene más.

Juan José es el que está diagnosticado de esquizofrénico. Tiene veintiun años, es soltero, con aspecto de mastodonte; rostro inexpresivo, ropa nueva, y habla en forma totalmente disgregada. Existe una disgregación del pensamiento.

Me cuentan que se enfermó a los diez y siete años. Se despertó una noche como si hubiera tenido un sueño terrorífico, muy asustado apareció en calzoncillos en la habitación de los padres diciendo cosas que no se entendían. A partir de ahí lo trataron; al principio le hicieron una serie de electroshocks, después por varios psiquiatras clásicos, hasta que inició un tratamiento de psicoterapia.

En las primeras entrevistas no se entendía nada. Sentí que me decía algo sobre un lapicero que yo tengo sobre el escritorio y acerca de mujeres y prostitutas, pero en general no se entendía.

Como esta gente vive a unos doscientos kilómetros de la capital, un poco menos tal vez, decidí internarlo en una clínica. En otro viaje el padre lo trajo, lo internó y se volvió. Cuando el tren se puso en marcha sintió que lo tocaban de atrás y era Juan José que le había dado un puñetazo al portero de la clínica y se había escapado.

Hace tiempo que está en cama, les hablo de las primeras épocas, casi mudo, por las noches se levanta, tiene crisis durante las cuales rompe cosas.

Lo único que le entendí en las primeras entrevistas es que dijo: "El que quiere celeste que le cueste" y "Dicen que juegan al metegol pero no juegan". La madre me comentó que debía guardar relación con un barcito que había al lado de la casa, donde existía este tipo de juegos y al cual había ido a veces Juan José.

En un principio, ya empezando a trabajar, apareció entre los padres un pacto. El padre se había ido de la casa con una mujer y hubo una situación muy penosa. El hijo mayor, Luis, se hizo cargo de la casa y del negocio pues la madre hizo en ese momento un cuadro de anorexia nerviosa. El hijo mayor fue a buscar al padre, lo trajo. El padre prometió quedarse, pero siempre y cuando Alba le permitiera seguir saliendo con mujeres. Acá ya se puede ver y analizar la situación triangular. En realidad el que tiene el rol de padre es Luis además lo ha despojado al padre que se llama Luis Roberto, de su primer nombre; es decir, al padre algunos lo llaman Roberto, pero ni siquiera le llaman Roberto, sino que le llaman "El Negro". y el padre, sobre todo como resultado del pacto, pasa a ser una especie de hijo soltero y Juan José está adherido a la madre en una relación simbiótica.

Todo esto que ocurre, Luis por supuesto, está completamente enterado y Juan José no sabe nada; no solamente el no sabe lo que pasa entre los padres, sino que está alejado de los problemas familiares en general, especialmente de los económicos.

Pichon dice que la segregación es anterior a la segregación manifiesta; acá lo podemos ver bien claro. También podemos empezar a vislumbrar porqué Juan José se enferma y Luis no, aunque hay otros elementos mas para dilucidar esto.

La madre. Alba es una mujer totalmente frígida. Las relaciones sexuales las tenía, cuando las tenía, con el camión puesto. Acá

podemos ver también la relación triangular, las ideologías, los prejuicios, en función de la ideología que pueden tener los árabes. Todo esto la madre lo contaba casi con jactancia. Se podría combinar acá la ideología con el prejuicio, perfectamente, porque que una mujer mantuviera esta idea cuando tiene que compartir al marido con doscientas mujeres, podría aliviarla, pero acá en la Argentina no tendría sentido.

Había habido desavenencias conyugales desde el principio porque Roberto era muy jugador; en eso la madre se podía enojar.

Esta gente vivía de un negocio que se llamaba "Mercadito Juan José" que manejaba la madre. El padre también trabajaba, pero ella tenía que estar continuamente mirando que no metiera la mano en el cajón, porque se jugaba la plata. En esa época, por ejemplo, un millón de pesos en una noche.

La historia del padre es la siguiente: Había sido abandonado por sus padres, criado por un tío que lo hacía trabajar y lo castigaba. Las veces que iba a visitar a su familia lo trataban como si fuera el perro: le daban de comer las sobras.

Recién a los dieciocho años o veinte se juntó con su padre y trabajaron en forma ambulante y jugaban. Esta fue una de las mejores épocas de relación con su padre y explicaría, en parte, el afán de jugar de este hombre; es decir, podía sentir que jugar era como colocarse en el foco del afecto del padre.

Juan José también ha empezado a jugar. El padre lo lleva así como su padre había hecho con él. Acá se puede ver el concepto mío de quedar en descubierto. Roberto es analfabeto a pesar de que es muy inteligente y tiene mucha labia.

En la medida en que había ciertos progresos en la familia, aparecieron los sabotajes. Acá podemos ver los miedos básicos, la resistencia al cambio, el miedo a una nueva estructura y a la pérdida de la anterior.

Los sabotajes se producían fundamentalmente a través del juego y había grandes peleas con la madre porque el padre jugaba. Yo me quedaba mucho tiempo sin cobrar; me costaba mucho aumentarles cuando por otra parte se jugaban mucha plata. Había veces que ganaban mucho. Pude entender un concepto de Pichon: él dice que el líder del cambio esta habitualmente en complicidad secreta con el chivo emisario.

Así empecé a darme cuenta de que cada vez que venían yo estaba pendiente de la quiniela; por ejemplo, ¿qué número habrían jugado?, porque ellos por lo menos sabían que número habían jugado. Me di cuenta de que de alguna manera, yo estaba jugando o por lo menos estaba con toda la expectativa de jugador. Además estaba sin plata. Entonces pensé en la madre. Me dí cuenta, no se si le podemos llamar transferencia familiar a esto, pero que yo estaba identificado con la madre porque era ella la que más peleaba en contra del juego, pero estaba rasposa, desgarrada; en la casa no había toallas, las sábanas estaban hechas jirones, ella en realidad era la que estaba en complicidad; es decir, hacía economía porque los otros se jugaban la plata, pero la cosa probablemente era al revés. Cuando alguna vez el padre ganaba o traía la jubilación, bastante buena en esa época, y le daba la plata para que se comprara lo que quisiera, la madre no lo hacía. Nunca se compraba nada; yo la estuve viendo como tres años con el mismo vestido, supongo que lo lavaba. Alba no tocaba la plata que le daban, lo cual producía mucha indignación especialmente en el marido. Donde la ponían, allí la dejaba ella, al tiempo la volvían a tomar y la jugaban. En otro nivel se podría entender que era el pene del padre lo que la madre desvalorizaba.

En realidad se pudo entender que su apariencia personal también, era debida a su melancolía y no porque no hubiera plata.

Pero sólo cuando yo logré salir de esto, se pudo modificar un poco la situación. Primero mostrándolo, interpretándolo y finalmente en un momento me tuve que poner firme y decirles: si no me pagan no vuelvan más, con cierta elasticidad pero también con cierta convicción, porque si no era convincente no pasaba nada; haciéndoles también algún señalamiento lúdico, diciéndoles por ejemplo: Ud. qué opinaría si viniera y yo estuviera sin botones, con la pared sucia, etc. Y decía: Ud. Alba, está allí, siempre con la misma ropa, siempre sin arreglarse. Una vez le hice una receta, donde le decía: "Ud. tiene que ponerse esto", y le escribí: "una pollera".

A través de esta serie de interpretaciones, señalamientos y amenazas se modificó la situación. Alba comenzó primero comprando cosas para la casa, recién después para ella. La fiebre del juego empezó a mermar.

Pudimos ver el concepto de chivo emisario que fue variando y tenía distintos contenidos, por ejemplo el padre aparecía como

chivo emisario del juego. La madre, se vió, cómo era ella la que jugaba, cómo en alguna medida yo estaba en complicidad. El líder del cambio, que sería yo, el terapeuta, el que tiene ese status, en ese caso entraría en complicidad con el chivo emisario, porque en última instancia era yo el que me jugaba la plata y siempre perdía; era yo el que estaba identificado con esa madre melancólica, des preocupada de sí misma, como sin vida propia y en complicidad con el padre.

Cuando pude empezar a poner límites y la madre empezó a modificar su actitud y el padre también, y a sentir que la plata de él, la madre se la empezaba a valorar, a partir de eso la cuestión del juego se cortó o por lo menos mermó. Después de eso, de vez en cuando aparecía, cuando había algún progreso muy evidente que los movilizaba mucho y hasta el día de hoy de vez en cuando persiste. Por ejemplo en un momento del tratamiento Juan José empezó a hacer una terapia individual y el padre se lo llevó a jugar. Un día vino la madre sola pero me cuenta que se ganaron tres millones de pesos los dos. Hace mucho que no jugaban. Quizás había un sabotaje hecho por el padre, que está bastante ahora con el hijo. En esa etapa, se trataba de que el hijo se desprendiera del padre.

Luis tuvo varios problemas con su familia, me refiero a la familia propia de Luis, al lado del proceso terapéutico de esta familia, que fueron trabajados desde el grupo familiar, fundamentalmente a través de la madre. En algún momento se separó de la mujer, se volvió a juntar, en realidad se psicotizó un cuñado de él. Ahora, en la actualidad está muy bien especialmente en lo económico; tiene dos hijos, creo, y un chalet con pileta de natación.

Más tarde apareció la madre jugó al Prode.

Un ejemplo más grotesco de chivo emisario, consistió en un momento en que, cuando venían y se iban, quedaba flotando en mi consultorio, especialmente en una época en que yo atendía en mi casa, un olor que muchos psiquiatras describen como el olor del esquizofrénico. Yo tenía que abrir las ventanas y airear. Una paciente que venía después, muy pulcra, había veces que no los veía, que no se cruzaba con ellos, pero olía y decía: "Estuvieron ¿no?".

Yo no soy prejuicioso, con respecto de las enfermedades mentales especialmente, y se me ocurre que el olor que describen los psiquiatras que tienen esquizofrénicos, debe ser de la época en

que se haría tanta insulina en el hospicio; porque la insulina produce una sudoración profusa, como además después probablemente no se bañan, esa transpiración era lo que los psiquiatras denominaban el olor del esquizofrénico.

Bueno, acá la madre un día empezó a decir que el hijo no se bañaba. Protestaba: "Yo le pongo la ropita, le abro la ducha pero no quiere bañarse". A mi se me prendió la lamparita: pensé que en algunas oportunidades el paciente no había, y habían venido los padres solos y el olor era el mismo. Entonces empecé a preguntar y el paciente me dijo que el padre no se bañaba nunca y la madre rara vez; es decir, era olor a "chivo".

Tomando un poco la historia de Alba, ésta tuvo una infancia de mucho sometimiento; con un padre ausente, idealizado, que viajaba con una valija y vendía géneros, cuando tomaba contacto con el padre se comportaba como un chico. Había veces que lo acompañaba a caballo a algún lado. Eran muchos hermanos, alrededor de once y ella que era la hermana mayor se tenía que ocupar de las tareas de la casa, de los hermanos, etc. La sacaron del colegio en tercer grado, allí la acompañaban los hermanos varones. La sacaron porque dijeron que era muy grandota; en realidad era para que trabajara y supongo que por la sexualidad y por todos los prejuicios de la familia árabe. Para esa época el padre había muerto. Más adelante la madre de Alba empezó a tener una nueva pareja y para estar más libre se llevó a todos los hijos y los puso en un asilo. Alba, con otra hermana, creo que la que le seguía, fue y los rescató y los llevó de nuevo a casa, por supuesto con la responsabilidad de hacerse cargo de todos.

Comentan que la madre de Alba tenía un látigo para pegarles y ella sufrió grandes castigos. Cuando lo conoce a Roberto éste ya era medio tarambana, jugador, muy jugador, se enamoran y se preparan para casarse con gran oposición de la madre de Alba que le vaticina el fracaso. Es muy común ver en familias de esta clase social donde una hija se quiere casar y esto es saboteado; es saboteado con castigos, con la oposición o como en este caso, con el vaticinio del fracaso.

Con el pedido de mano, lo que se pierde es la mano de obra, se pierde la mano de obra de la hija en el hogar. Esto se puede ver en los tangos y especialmente en los versos sobre "la costurerita que

dio el mal paso" y la familia nunca la perdona, de Evaristo Carriego.

La madre la vaticina el fracaso, cosa que es bastante importante, porque ella se propone entonces que nunca se va a separar, para no dar el brazo a torcer delante de la madre, es decir, por un aspecto narcisista de ella.

Se casan y nace Luis y dicen que ya desde chico era muy distinto: lloraba, pataleaba, era rebelde.

Más tarde Alba se embaraza de nuevo del que va a ser Juan José y hace tentativas de abortarlo que fracasan. Las tentativas del aborto eran debidas, como es obvio, a las malas relaciones que ella tenía con Roberto y además porque estaba desbordada de trabajo.

Nace Juan José, y probablemente por esas tentativas y por el rechazo tan grande que tenía durante el embarazo, debe haber sentido muchísima culpa, lo cual la lleva a desarrollar una conducta reactiva sobreprotegiéndolo, animándolo durante todo el tiempo. Además dice que durante el embarazo lo que esperaba es que fuera una nena, que fuera una mujer para que la acompañara, aunque alguna vez me dijo: "Bueno también he pensado que si hubiera sido una mujer cuánto la hubiera hecho sufrir".

Nace Juan José, lo llevan a bautizar, el nombre se lo pone una vecina; no tenían pensado ni el nombre, el padre no se le ocurre ninguno.

Durante la infancia Juan José fue un chico muy dócil, muy bueno obediente, hasta que llega a la adolescencia. En esa época se destaca jugando al fútbol, a tal punto que lo prueban en la reserva de Boca con mucho éxito. En ese verano se va a Mar del Plata y él dice que tuvo una novia, aunque nunca pudo recordar su nombre.

Tiene en esa época diez y siete años y se enferma, hace el primer brote; es decir, yo pienso que ante la noticia ésta de que podría jugar al fútbol y la emergencia de la sexualidad, ésta actúa como un motorcito que lo arranca, que lo desgarrar de la simbiosis que tenía con la madre y el resultado de esto es, probablemente una gran movilización de la estructura familiar, con la emergencia de su sintomatología.

En la medida en que se pudieron develar todas estas cosas, que yo se las doy ya un poco elaboradas, el padre por ejemplo, decía que él no tenía muchos problemas, que si la cosa se ponía muy mal, terminaría debajo de un puente. Esto ocurría cuando se le planteaba

que pasaría: "su mujer dice que ya está cansada de Ud. y que se vaya"; en algún momento Juan José también lo quería echar y él contestaba esto de terminar debajo de un puente.

La mujer decía que su vida ya mucho sentido no tenía y que si no hubiera sido por Juan José hacía tiempo que ya habría terminado debajo de un tren.

Empezamos a ver uno de los primeros puntos de urgencias, que fue operar sobre esta situación triangular distorsionada, también sobre la contradicción que había con respecto a que por un lado lo traían a Juan José para que se curara, pero era como si le dijeran también: "si vos te curas tu papá termina bajo un puente y yo bajo el tren.

Esta situación triangular que nosotros describimos acá, Pichon dice que en realidad es más compleja que estos doce vínculos, porque a su vez ambos miembros de la pareja aportan sus propios vínculos anteriores, los de sus propios complejos de Edipo. Es decir, esto está en relación con la patología de tres generaciones, o sea que lo que pudimos comprender son los vínculos trigeneracionales, donde se creaba un triángulo en el cual la madre depositaba en el padre todos los vínculos malos que había tenido ella, todo lo negado malo del padre y también lo de la madre, que no estaba negado pero mas o menos. Por ejemplo, cuando contaban lo del látigo se reían y Roberto hacía bromas diciendo: "Era brava la suegra eh". Era y es porque todavía vive y Alba tiene dos medios hermanos.

Ella depositaba en el padre los vínculos malos. Por otra parte el padre asumía bastante esta adjudicación. Por ejemplo, jugándose la plata, pues esto favorecía sus propias identificaciones con el padre de él.

En Juan José, Alba depositaba todo el vínculo bueno, pero con él fundamentalmente mantenía una relación simbiótica; es decir, representaba un aspecto narcisista de ella, que más adelante lo vamos a poder entender un poco mejor. Cualquiera cosa que él hiciera ella no se enojaba. Rompía la casa, después empezó a jugar y ella igual no se enojaba. Un día se me ocurrió hacer una comparación que era como si fuese ella para su hijo como un perro cachorro al cual le pegaban, lo maltrataban, pero estaba siempre disponible, moviendo la cola.

Vimos que en Juan José depositaba el vínculo idealizado con

el padre de ella. Todo esto es un poco esquemático. La situación triangular básica estaría integrada en realidad por Luis como padre, Alba en relación simbiótica con Juan José y Luis Roberto, "el Negro", como hijo.

Trabajando con esto se empezó a modificar poco a poco la situación, cuando se le mostraba por ejemplo, que ella estaba mejor ahora que nunca, especialmente estaba mucho mejor ahora que de soltera; tenía casa, plata, no la gastaba porque era melancólica, pero no le pegaban. Era bastante difícil trabajar sobre la etapa anterior al matrimonio. El esquema que ella traía armado se rompía. Acá podemos ver la resistencia al cambio y el miedo a la pérdida de una estructura anterior y el miedo al ataque de la nueva situación estructural, que sería uno de los universales.

Podemos ver la depresión de la madre, esto lo podemos relacionar, aunque yo no lo he desarrollado, con la fenomenología de las cinco depresiones, con la idea de enfermedad única de Pichon.

La fantasía inconsciente de la madre, por lo menos esto estaba relacionado con fantasías inconscientes de la madre, de reivindicación y con la idea de falo también, que correspondían a una alucinación que tenía Juan José. Esta hablaba y decía que pasaba gente y le decían que es el pibe o que sentía como alucinaciones: "sos el pibe". Esto correspondía a estas fantasías inconscientes de la madre; mas o menos pensaba, cuando empezó Juan José a destacarse en el fútbol, que iba a llegar a ser un personaje extraordinario y consiguiendo tenerla a ella entronizada en un palacete. Esto estaba relacionado con ideas de reivindicación de Alba, que había sufrido toda su vida, y el pibe, como se pudo entender, estaba relacionado con una canción de hace tiempo que se llamaba "El sueño del pibe", donde hay un chico que soñaba que estaba cero a cero y él jugaba al fútbol y gracias a él se ganaba el partido y ahí se despertaba.

El padre a su vez, tenía que ser padre medio ausente para sus hijos para no notar que su propio padre había sido ausente con él. Esto está relacionado con el concepto mío de quedar en descubierto.

En el caso de la madre de Juan José, de Alba, se pudo modificar la relación que ella tenía con su madre. Podemos ver también cómo Juan José se transformaba en el portavoz de la depresión de la familia. La madre empieza a vivir a través de él; en realidad se crea una simbiosis muy grande basada en sentimientos en parte de culpa

por no haber podido realizar la simbiosis natural que sigue a la relación parasitaria intrauterina y que se desarrolla durante el puerperio. Esto sería por sentimiento de culpa por haberlo esperado sin ganas y fundamentalmente por un empeoramiento de la relación conyugal durante la época del puerperio lo cual se constituyó en una verdadera invasión de la personalidad de Juan José. Todas las cuentas llevaban el nombre de Juan José y éste no participaba para nada; la madre pensaba a través de él, le decía lo que tenía que hacer, que firmar, él sentía que vivía para satisfacer la necesidad de la madre.

Esto se transformó con el tiempo en un síntoma, que hasta el día de hoy perdura, que consiste en una sensación que él describe como que no siente la cabeza; ahora, últimamente dice que siente la nariz y la frente; es decir, la cabeza era de la madre. Acá está diciendo también porqué se enferma Juan José y no Luis, porque lo tratan distinto y se entiende también porqué a él lo tratan distinto: como mecanismo reactivo.

Lo que podemos ver también es el malentendido: primero el secreto familiar del cisma existía entre los padres y Juan José no lo conocía para nada, se enteró durante el tratamiento. Esta relacionado con algo que dijo al principio: "Juegan al metegol pero no juegan", es decir figuraría como que tienen relaciones sexuales pero no las tienen.

Un malentendido sería que no se separan por sus hijos y especialmente por Juan José, pero en la época en la que se separaron Alba hizo una anorexia nerviosa. Otra situación de malentendido y de contradicción la podemos ver relacionada con respecto del tratamiento, fue lo que les dije antes: que Alba venía a traer al hijo para que se cure, pero si se curaba ella terminaba bajo el tren.

Había una serie de síntomas mas: Una vez estuvo una semana afuera, en la casa de una tía y se volvió porque dijo que la tía le dio un vaso de agua que tenía impresiones digitales que le hacían mal. Esto está relacionado con la tía no era la madre, que todas las noches a esa hora le llevaba un vaso de agua o de naranja.

Cuando empezó a estar mejor, venían y cuando bajaban de la estación de Constitución empezaban a traer el síntoma de que las chicas le decían cosas. La madre me decía: "Yo no sé qué pasa con mi chiquito que cuando baja me dice que las chicas le dicen cosas".

Lo que se vio es como empezaba a conectarse con la gente; para

esa época, además, había adelgazado veintidós kilos, lo que se puede entender es que empezaba a conectarse más.

El esquizofrénico que ha vuelto a un estado narcisista cuando se enfermó, que retiró la libido de los objetos, cuando empieza a mejorar, la libido vuelve a catectizar los objetos que aparecen como fenómenos restitutivos. Esto estaba relacionado con eso; aparentemente parecía una alucinación, pero especialmente por el tono de voz, y porque un día dijo: "Las chicas me dicen algo" yo me di cuenta que lo que ocurría es que las chicas le estaban empezando a llamar la atención y que él hablaba en un lenguaje mas bien simbiótico.

Cuando se entendió esto y yo se lo dije, me contestó: "Si doctor, si hace tiempo que se lo digo". Ahora, esto está relacionado con la idea de cono invertido. Cuando yo le interpreté esto y el me contestó que hacía tiempo que me lo decía, inmediatamente agregé: "Ahora doctor, porqué no se lo dice a ella?", señalándola a la madre. Entonces le respondí: "Bueno Juan José, si se lo digo a Ud. su madre también está escuchando". Me dijo: "No, pero dígaselo a ella". Entonces yo se lo dije a ella más o menos en el mismo sentido a ver lo que pasaba y lo que salió como asociación de eso es que la madre me dijo: "Y doctor Ud. debe tener razón, o el chiquito debe tener razón, porque el otro día me dijo un cliente si yo veía mal y me estoy dando cuenta de que cuando voy por la calle, la gente pasa y me saluda y yo no. . . es como si no la viera". Es que esta mujer estaba tan melancólica, tan introvertida, que le pasaba lo mismo que al hijo, aunque en un nivel un poco más neurótico. Es decir, si tomamos el síntoma "las chicas me dicen cosas" como una primer capa o un primer implícito, cuando se devela ese implícito y así sucesivamente. Esto, repito, es algo que se puede dar en una sesión y a lo largo del tratamiento también.

Mas adelante ese tema volvió de nuevo. Y ya no eran las chicas, sino la gente en general y Juan José decía que la gente tenía la cara exaltada y acá se ve también que lo que quería decir es que la gente tenía expresión en el rostro; es que en realidad era una identificación proyectiva porque él empezaba a tener expresión en el rostro y a sentirlo al mismo tiempo.

Por esta época también empezó un tratamiento individual que tuvo que interrumpir porque su analista viajó al exterior.

Ultimamente, en los últimos tiempos que yo los ví, hubo una notificación; Juan José estaba bastante mejor. La abuela enfermó de culebrilla y nadie se quería hacer cargo de ella, estuvo mucho tiempo enferma. Finalmente Alba la llevó a su casa y entonces "la casa del loco", que era evitada por todos los familiares, se transformó en centro de reunión; reunión que era animada por Juan José que tocaba la guitarra bastante bien.

Hubo otro momento especial en el tratamiento, donde Juan José empezó a hablar de comprarse un coche. A mi me pareció algo medio bizarro pero me mantuve expectante y se inscribieron en un sorteo de un Fiat 600 y empezaron a pagar cuotas. En esta época recrudecieron los sabotajes y había momentos en que yo estaba subvencionando el Fiat, pero finalmente un día se aparecen con el coche. Después de verlos estuvimos hablando. Había grandes dificultades económicas para pagar las cuotas y el padre, que estaba bastante mejor con él, le dice: "Vos quedate tranquilo, olvidate, que toda la entrada de mi pensión va ir directamente para las cuotas de tu coche". Entonces yo les dije: "Bueno, el coche es muy lindo, es 0 Km., ahora, su padre no será 0 Km. pero parece que Ud. tiene un papá ahora". Juan José se empezó como a derretir, se le llenaron los ojos de lágrimas y le dije que lo mirara a su padre, me contestó que él no lo podía mirar de frente al padre, entonces me levanté los hice abrazarse y ahí Juan José empezó, por primera vez en su vida, como a derretirse y a llorar convulsivamente.

Con el padre en éste último punto se puede ver cómo la divalencia se transforma en ambivalencia. Pichon dice que para que pueda haber depresión tiene que haber un pasaje de la divalencia a la ambivalencia. La divalencia está configurada por un splitting, esto lo podemos relacionar con los mecanismos de splitting, un splitting en el objeto lo cual hace que queden con vínculos libres: el vínculo bueno y el vínculo malo. Cuando se unifica el objeto se produce la depresión. Es decir, el padre malo sería ese que él quería echar, que le decía a la madre; "porqué no lo echas"; y el padre bueno sería el padre idealizado al cual él esperaba encontrar siempre y tal vez más el de la niñez;

Acá pudo sentir que el padre no era 0 Km., pero que era un padre y a partir de ahí se pudo deprimir.

Familia e Intersubjetividad

RAFAEL SKIADARESSIS

Médico psiquiatra - psicoanalista. Miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Neuquén 2638, Buenos Aires, República Argentina.

CARLOS ALBERTO KLIGMANN

Médico psicoanalista. Miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Pueyrredón 1017, 10° A, Buenos Aires, República Argentina.

Las ideas que siguen, reconocen su origen en la obra de S. Freud y J. Lacan. Se conocen las dificultades de estilo de este último, su oscuridad aparente, ese hermetismo oracular que le es tan propio.

Por nuestra parte, esta noche nos guía el afán de promover un intercambio, de formalizar un diálogo con Uds. La dificultad propia del sistema nos hace recordar lo que un formador de filósofos desde la Universidad Nacional de Tucumán, recomendara a sus discípulos diciendo:

“Para abordar la filosofía, para entrar en su territorio, una primera disposición de ánimo es absolutamente indispensable. Es absolutamente indispensable que el aspirante a filósofo se haga bien cargo de llevar a su ánimo una disposición infantil.

El que quiere ser filósofo, necesitará puerilizarse, infantilizarse, hacerse como el niño pequeño. Percibir y sentir por donde quiera. Plantearse ante el universo y el propio ser humano con un sentimiento de estupefacción, de admiración, de curiosidad insaciable, como el niño pequeño que no entiende nada y para quien todo es problema”.

Familia e Intersubjetividad

Es nuestra intención compartir esta disposición de ánimo y aventar una figura un tanto odiosa y cada vez más generalizada entre nosotros. Nos referimos a los dueños del saber.

Pero vayamos al tema; pues ni hablaremos de filosofía ni Uds. son aspriantes, ni nosotros maestros.

Familia e Intersubjetividad.

No dejarán de advertir que es éste un título que se las trae.

Quienes hayan leído “Alicia” de L. Carroll, recordarán ese maravilloso y ejemplar fragmento de diálogo con Humpty Dumpty:

—No sé que quiere decir Ud. con gloria— dijo Alicia.

—Humpty Dumpty replicó: Por supuesto que no, hasta que yo te lo diga. Quiero decir: debe ser un argumento aplastante.

—Pero gloria no quiere decir: “un argumento aplastante”, protestó Alicia.

—Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, esa palabra significa exactamente lo que yo decido que signifique. Ni más ni menos. El asunto es quien es el maestro aquí.

Evocamos este fragmento que entre nosotros se conoce de manera más reducida y no menos expresiva, a saber: Cada maestrillo con su librillo.

Queda señalado que tanto la noción de familia como la de intersubjetividad resultan tanto más abigarradas cuando no desconcertantes. Como para Humpty Dumpty, significan lo que cada autor intenta significar. Ni más ni menos.

En lo que respecta a familia se podría intentar, cosa que por otra parte se ha hecho ya, una definición desde la antropología, la sociología, la psicología, la religión, etc.

A propósito de intersubjetividad no hay escuela que no haya aportado la letra de su parecer en lo que respecta a este fenómeno de la existencia y el ser de los otros.

Por nuestra parte, y en tanto no nos creemos convocados para resolver definitivamente la naturaleza de estos conceptos, consideramos no proceder ilegítimamente al intentar contribuir con nuestro aporte a este campo tan proteiforme. También nosotros hacemos aquí un poco lo que Humpty Dumpty. Pero, aún aceptando que no remitan a conceptos unificados, no se puede negar la sugestiva

atracción que ejercen estas nociones. No sólo en lo que hace a su contenido nocional sino también en algo pertinente al orden de las palabras.

Familia e Intersubjetividad. Sea tal vez una confesable pasión estética lo que decidió la presente intitulación.

Comencemos entonces por las palabras.

El abordaje filosófico nos permitirá una primera aproximación.

El Diccionario Crítico-Etimológico de la Lengua Castellana de Joan Corominas nos dice lo siguiente:

Familia: tomado del latín familia: conjunto de los esclavos y criados de una persona.

Familia: derivado de famulus; sirviente, esclavo.

Intersubjetividad: derivado del latín Subjectus-subjectum: Sometido, sujeto, poner debajo.

Vemos entonces que esas dos palabras, esos dos significantes podríamos decir, están relacionados con un significado: esto es, algo nunca del todo ajeno al sometimiento.

¡Alto ahí! nos dirán. Advertimos desde ya que no se juega en esto ningún juicio de valor. Pero, no obstante, si hubiéramos de acordarle alguno, diríamos: un sometimiento beneficioso.

¿Por qué? Lo adelantaremos en breve y dogmáticamente para desarrollarlo luego.

En nuestras consideraciones respecto a la Familia y para nuestra Cultura, aquélla es la encargada de instituir un sujeto. Dicho de otra forma: Por su intermedio (la familia no deja de ser un instrumento) liga un individuo a la cultura.

O de otra manera: la Familia es la encargada de transmitir la Ley y el orden cultural. La Ley por antonomasia. La prohibición del incesto.

Aquél que advenga a la familia y por su intermedio se someta, se sujete a la cultura, devengará neurótico (De esas neurosis mínimas o no, cotidianas podríamos decir, hasta normales, casi).

Si él mismo, se convierte en la Ley, o por el contrario no se somete a ella, la psicopatología denunciará allí lo multifacético de los cuadros de la perversión y de la psicosis.

¿Ahora bien, cómo y por qué alguien queda sujetado?

Este trabajo podría haber sido intitulado no menos sugestivamente. Familia y Complejo de Edipo. Y tal vez estaríamos escu-

chando ya a quienes no dejarían de señalar que de vivir aún Freud, éste sería terapeuta familiar. Tal vez. Consentimos. No obstante, no se trata sólo de evocar la palabra de Freud. Al decir de Lacan: "Para reencontrar el efecto de la palabra de Freud, no recurrimos a sus términos, sino a los principios que la gobiernan".

Esta adhesión a los principios freudianos es lo que, creemos, nos impulsa a articular un modelo de Complejo de Edipo que permita dar cuenta de la estructura de la familia en lo que hace a la constitución de un Sujeto.

Vayamos al tema.

Como se sabe la denominación Complejo de Edipo aparece como tal y por vez primera en 1910, en "Sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre". No obstante, la apelación a la tragedia, a su temática, exenta aún de esa denominación de Complejo y para explicar lo que emerge en el autoanálisis de Freud, consta como primera referencia en carta a Fliess del 15 de octubre de 1897.

La idea que aparece es sencilla. El niño no ya tan ingenuo, se encuentra ligado a su madre por inclinaciones algo más que tiernas. Al mismo tiempo, se relaciona con su padre por conductas que denuncian algo más que hostilidad.

Hoy día, esta formulación del Complejo serviría tan sólo para simplificar los desarrollos teóricos ulteriores.

A Freud, en cambio, le sería muy útil para formular el concepto de sexualidad infantil.

Vamos viendo, entonces. El concepto teórico se produce. No es algo que como fruto desconocido alguien descubriera en viajes a lugares también ignotos.

Los conceptos formales-abstractos que constituyen el cuerpo de doctrina se invocan los unos a los otros más allá del dato empírico. Es ésta relativa independencia entre el objeto real y el objeto formal, lo que explica la existencia de diferentes teorías para dar cuenta de un mismo campo experiencial.

Pero volvamos al concepto de sexualidad infantil. Nos preguntamos por su función.

A Freud, le sirvió a los fines de una articulación indispensable para la teoría. La articulación entre sexualidad e inconsciente.

Esto es, que lo inconsciente, aparece como rechazo de la con-

ciencia de esos contenidos sexuales.

Si, contra Hesíodo, quien promulgaba que las enfermedades enviadas por Zeus avanzan en silencio, Freud propuso mostrarnos que hablan, y hablan por sus síntomas, debía entonces formalizar un lugar, una tópica, que se constituyera en reservorio de esas palabras o contenidos imposibles de confesar. A ese lugar lo llamó Inconsciente, y a esos contenidos, sexuales.

Tenemos aquí constituida la trama de la articulación edípica. Pero a este Edipo, que podríamos llamar de las primeras armas, faltaba articularle el concepto de Falo.

Sabemos que a lo largo de las Obras Completas, uno se puede cansar buscando un texto que haga síntesis con el Edipo. Tal obra no existe. Lo que sí se puede es ordenar una lectura.

Desde la óptica del Falo, tomando como concepto nodular, adquieren prevalencia los trabajos sobre sexualidad femenina y sexualidad infantil.

Continuemos por el momento con esta última.

En el apéndice a la edición de 1923 de los Tres Ensayos, el Falo adquiere la jerarquía de fase. Freud dice:

“Este carácter diferencial (esto es: entre organización genital infantil y adulta) consiste en que el sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, el masculino, para ambos sexos. No existe pues, una primacía genital, sino, una primacía del falo”.

Se ve, está con todas las letras, el falo no es el pene.

Que clase de pene podría ser éste que aparece tanto en los hombres como en las mujeres. Así en las locomotoras, como en las piedras.

Obviamente, falo es otra cosa.

El niño, por otra parte, se ve llamado en cierto momento a una experiencia crucial y dramática. La confrontación por un lado, de su teoría de que en todo hay pene, y la constatación de la diferencia de los sexos, por otro, que lo catapulta hacia lo que se denomina en la teoría: Complejo de Castración.

(Hacemos aquí una salvedad: siempre y cuando diríamos, aquella constatación no sea renegada).

Se sabe que el Complejo tiene dos caras. Envidia del pene en la niña y amenaza de castración en el varón. Dos caras pero no de la misma moneda. A partir de aquí, los avatares de la sexualidad feme-

nina y masculina no se pueden superponer ni analogizar.

Una teoría sexual infantil, no obstante, es común a ambos sexos. Cuando descubren, según Freud, que sólo las mujeres pueden parir a los niños, es cuando dejan de atribuir un miembro viril (léase falo) a la madre y aparecen complicadas teorías dedicadas a explicar la permutación del falo por un niño.

De donde, entonces, podemos pensar lo siguiente: en la cabeza del chico, el falo que antes había es ahora un niño.

Esa testarudez a aceptar la diferencia de los sexos es lo que produce la equivalencia falo=niño, en posición inconsciente.

Pero todo esto no puede ser cabalmente comprendido sin partir de la sexualidad femenina. Articulaciones que ya se pueden leer en Freud en 1931 y 1932, deben ser desmolidas, para echar luz sobre un punto, respecto al cual, gran parte de la literatura psicoanalítica posterior hizo silencio.

Esto es, parafraseando a O. Masotta, resulta imposible pensar la estructura del sujeto tan sólo a partir de una génesis real. “No se puede construir una teoría si se ubica al chico, en la panza de la madre, en posición de feto”.

Diremos que sólo para una psicótica o para la madre de un psicótico, su hijo está ahí como feto. Entre la madre y el hijo hay una mediación imaginaria. Ese mediador es el falo.

Se podría enunciar con Lacan que así como en el origen del sistema de parentesco (y según Levy-Strauss) encontramos a los hombres intercambiando mujeres, en el origen de la constitución del sujeto encontramos a las mujeres intercambiando falo por niño.

Vamos a precisar esto centrándonos en los desarrollos de Freud, sobre sexualidad femenina.

La niña, debe someterse a un doble vértigo en su estructura. Debe sufrir no sólo el cambio de zona erógena, sino que también debe cambiar de objeto. Esto es:

- a) Del clitoris a la vagina.
- b) De la madre al padre.

En un momento, la niña descubre una carencia fundamental en su madre y la decepción producida por esta verdad, momento fecundo por otra parte, la remite hacia el padre.

Si en el varón, el develamiento de la castración pone fin al Complejo de Edipo, en la niña por el contrario, le abre su vía regia.

Al decir de Freud: El complejo de castración estimula la femineidad e inhibe y restringe a la masculinidad.

Tenemos entonces a la niña dirigiéndose hacia el padre. Pero ¿qué es lo que va a buscar en él? Ciertamente, no un pene. Si el padre se vuelve atractivo para la nena es porque considera que aquél es quien la puede munir de un niño.

Para decirlo de una vez: "lo que la mujer busca en el padre como hombre, es el hijo y no el hombre". Este, para la mujer, y en este preciso sentido, no es más que un prestatario, un agente de cambio, una racionalización en última instancia.

En relación al deseo de hijo (en tanto la compensa imaginariamente de su falta de falo) el deseo de hombre es secundario.

Entonces, en el origen de todo sujeto humano, habrá que colocar ahí a una mujer permutando falo por niño.

Si de alguna manera hay que entender ese concepto engañoso de Narcisismo Primario, es a partir de este lugar de encuentro: un deseo materno de falo con el niño que lo viene a colmar.

"Su majestad el bebé" diremos parafraseando a Freud. El niño entonces es de entrada el falo de su madre.

Pero esta es una delicada situación y por más de un motivo.

De un lado el narcisismo infantil, del otro la madre fálica. Y agregamos que, si la figura de la madre fálica representa algo, no es otra cosa que la madre de este colmamiento ideal.

Tenemos constituida entonces, aparentemente, una mónada autosuficiente prefigurada por la madre y el hijo.

Delicada situación decíamos, pues de ser una mónada cerrada, no hay alternativa teórica posible para que el chico salga de esta cárcel del ser.

Pero vayamos despacio.

En primer término, el narcisismo tiene dos valores posibles: vida y muerte.

Vida, dado que es por este momento fecundo en que la madre lo sitúa como objeto de su deseo, que el niño va a ser libidinizado.

Sintetizaremos con este axioma. A saber: el narcisismo es fundamental en el sentido que es condición de toda catexia ulterior de objeto.

Pero, por otra parte, también puede ser muerte. No otra cosa nos evoca el mito de Narciso. Encerrado en la fascinación por su

imagen, en su intento por fundirse completamente con ella, encuentra la asfixia en el espejo de agua.

Si el colmamiento entre el deseo de la madre y el encuentro con ese niño no ofreciera vías de salida daría como consecuencia un aplastamiento del niño en su posible condición de sujeto deseante. Se ven los resultados.

Como nos pintaba dramáticamente una psicótica, en una pregunta que para ella contenía ya una respuesta definitiva: ¡¿Saben que hay más allá del amor?! nos gritaba parafraseando el título de un film que había visto recientemente. — ¡Más allá del amor, está la locura y la muerte!— afirmaba con tono concluyente. En su caso esto tenía peso de verdad. El narcisismo primero, luego la locura, después la muerte.

Pero, cómo puede el niño escapar de esta trampa en la que corre el riesgo de quedar atrapado eternamente como objeto, sin constituirse él en sujeto de un deseo?.

La posibilidad de constituir ese deseo depende de la prohibición, a saber: del padre. Con mayor precisión, de un padre que funcione como tal, y ésto independientemente de la genitura.

¿Qué quiere decir que funcione como tal?.

Supone que pueda ejercer el corte entre madre e hijo. Como lo expresa Lacan: el corte vehiculizado por una doble prohibición:

A la madre: no reintegrarás tu producto.

Al hijo: no te acostarás con tu madre.

Esto nos remite al Complejo de Castración. Y diremos con Masotta:

"Cuando se habla de castración se debe poder significar por lo menos los dos lados que constituyen el complejo. No solamente la amenaza en el hombre y la envidia de pene en la mujer, sino además, y muy particularmente, el momento fecundo por donde el sujeto queda separado de su ligazón incestuosa con la madre para darse un objeto fuera del grupo familiar". Hecho, éste último, inscripto en el concepto de sublimación según quedara expresado en el capítulo I de la obra de Freud "Presidente Wilson": de la madre a la hermana, de ésta a la prima y de aquí a una mujer del exogrupo.

Pero, llegados aquí, debemos hacer algunos comentarios respecto al complejo de castración que nos parecen pertinentes:

¿El complejo de castración remite tan sólo a la angustia de ser castrado?

Y entonces, si esto es así, ¿qué se quiere decir con ese lugar común de que el sujeto debe asumir la castración?

No podemos hoy, dar otra cosa que respuestas dogmáticas, con todas las limitaciones, inexactitudes y peligros que ello encierra.

A la luz de un texto como "Lo siniestro", pensamos que la angustia de castración tiene una doble vertiente:

1º) La que se origina a expensas de la figura del padre como castrador.

2º) Pero también y tanto más importante la que tiene su fundamento en el temor a quedar atrapado por la madre.

Concluiremos diciendo que el conflicto por antonomasia en relación al complejo de castración no remite tanto a la castración que el niño teme, sino a la que él necesita y que el padre no puede efectuar.

El destino y la cifra de ese niño como sujeto deseante dependerán entonces de la castración, como corte de la madre.

La posibilidad de abandonar el objeto primordial, para catectizar libidinalmente objetos otros, dependerá de ese corte con aquella que originalmente alimentó en el niño toda libido.

Ahora bien, como enunciáramos más arriba esta función de corte se corresponde con la función paterna. O dicho de otra manera, con un padre que pueda ejercer tal función.

La psicopatología no deja de evocar cierto ensañamiento contra la figura del padre. Ya sea por demasiado fuerte o por demasiado débil, nunca se desvincula la función del padre de un cierto sustancailismo teñido de ideología.

Ahora bien, ¿cómo un padre puede ejercer su función? ¿Qué es lo que le otorga a tal función el poder funcionar?

Responderemos a este interrogatorio diciendo que quien introduce la función paterna en la estructura familiar es la madre.

Precisemos. El deseo de la madre por el padre. El reconocimiento del padre o de ese padre y en ese momento de la historia familiar como el que tiene el falo.

¿Qué es entonces un padre?. Pues bien: es la diferencia introducida por un deseo de madre que no se agota en un deseo de hijo.

Como dice Leclaire con respecto a la función materna:

La madre debe ser como la tierra que sostiene sin fallar. Y no como el mar que engloba y traga. Que sostiene, agregaríamos nosotros, un deseo por el padre.

Parafraseando a Lacan diremos que:

"El padre interviene como aquel que tiene el falo y no que es tal. Reinstaura la instancia del falo como objeto deseado de la madre y ya no como objeto del que pueda privarla, como padre omnipotente. En otras palabras, en esta etapa (y para el niño) el padre es más preferido que la madre y esta identificación culmina en la formación del ideal del yo".

Pero, si precisamos por un lado, que algo del niño captura por medio de la identificación las insignias o emblemas para los cuales su padre se hace portador, en tanto vía posible para la instauración del ideal del yo sabemos que están los ideales colectivos. O dicho de otra manera, está el orden de la cultura.

Vale decir, que en ese sentido, el padre del niño es un agente en el medio familiar, de lo que podríamos llamar reproducción de cultura. Reproducción que se hace posible a través de esa ley mayor, de esa ley de leyes que es la prohibición del incesto, y de la cual, el padre, ese padre, debe hacerse garante.

En su forma generalizada y abstracta, el ideal del yo, está en el orden de la cultura, remite a la filogenie, y si se quiere construir un mito, tiene su origen la horda primitiva.

Pero con mito o sin él, queremos destacar este específico del del orden de la transmisión: el ideal del yo se captura de un padre que lo recibió de su padre.

Lo que en la teoría freudiana se destaca bajo el nombre de Edipo ampliado, remite entonces al Edipo de los padres y a su resolución.

Ahora bien, el concepto de Complejo de Edipo ha quedado confinado para cierta teoría y práctica psicoanalítica a dar cuenta tan sólo de los procesos intrapsíquicos, en tanto, el supuesto epistemológico ordena la atención de tal manera que recae sobre una enfermedad padecida por un individuo.

Al respecto, y seguimos en esto a M. Mannoni: El problema que todo niño debe abordar y en el cual, el psicótico ha fracasado, se plantea de algún modo en la relación del niño con la palabra de los padres.

No es posible aislar el síntoma que presenta el niño enfermo,

no ya de su propio discurso, sino también del discurso que lo constituye. Esencialmente el discurso de los padres.

Como dice Mannoni; "Antes su nacimiento, el niño ya posee un lugar en el discurso parental, ya tiene asignado un nombre y le hablarán en la misma medida en que lo harán objeto de cuidados" La verdad de estas palabras podría quedar consignada en un ejemplo clínico que aún cuando abre más interrogantes de los que resuelve no es menos revelador de lo que queremos comunicar.

Habiendo nacido ya dos varones a quienes llamaron Ramón y Pedro, la madre anhelaba una mujercita, que la acompañara en sus labores, o... por otros motivos.

A medida que el vientre le iba creciendo por la presencia de un nuevo niño, ella eligió nombre, le gustaba Laura. Pero, al noveno mes, ¡Oh, sorpresa! nace un varoncito.

Madre algo perversa, no puede ir totalmente contra la ley, pero... se las arregla en parte. Le ponen Lauro.

Cuarto embarazo. Se vuelve a repartir la historia.

El nombre se selecciona nuevamente. Se llamará María. Como Uds. ya suponen, no hay aquí lugar para la sorpresa, lo inscribieron como Mario.

De todas maneras, de los cuatro hijos, y por más de una circunstancia, el lugar de Lauro fue el más destacado. Su Lauro, su premio, por ese nombre, es hoy una esquizofrenia.

Antes de hablar todo niño que adviene al mundo es hablado.

Como reza el fragmento 74 de Heráclito: "niños al estilo de nuestros padres, lo que ellos nos han dicho".

Subrayamos lo que queremos transmitir. El modelo del Complejo de Edipo no se agota en un sujeto. Puede dar cuenta de una organización mayor que la intrapsíquica.

Esto es, nos puede permitir detectar según el modelo descripto, el arquetipo de una configuración familiar, independientemente para ponernos a salvo ya de posibles críticas contra un supuesto psicoanálisis de la familia.

Para concluir con esto: la génesis de un sujeto en el seno de una familia no deja de tener que ver con funciones maternas y paternas a que aludimos más arriba. Ni tampoco la aparición de un

loco en un grupo familiar deja de tener que ver con los extravíos de esas funciones, en aquellos que llamamos sus padres reales, y que, determinan su imposibilidad de acceso a una subjetividad plena.

Pasemos ahora a algo distinto sin olvidar que los conceptos hasta aquí expresados dan cuenta del basamento donde se articulará la relación entre sujetos.

La estructura anteriormente desarrollada, se caracteriza además, porque en ella se produce un discurso que podríamos llamar familiar. Con él se articularán mitos, normas e ideales que son propios de cada grupo familiar, más allá de las generales de la cultura en que ese grupo esté inserto.

Este fenómeno de discurso de la palabra, nos llevó a pensar en un modelo de comunicación, el modelo de la comunicación intersubjetiva. Ya que en el seno de una familia, la intersubjetividad se constituye o no.

Al trabajar con familias, en cada encuentro que con ellos tenemos, podríamos decir que algo del orden de una experiencia de realidad se produce. Pero he aquí un problema. ¿A qué llamamos realidad y cómo será interpretada ésta por cada uno de los integrantes de una familia?

Para responder a este interrogatorio, vamos a pedirles que nos acompañen por un camino previo.

Si por ejemplo, tengo una caja de metal donde guardo botones, podríamos preguntarnos: ¿Qué sucede con este objeto real y con la experiencia que podemos tener de él?

Alguien podrá decirnos: es una lata; otro, que es coleccionable como adorno; un niño podrá decir que es un juguete y hay quien nos dirá simplemente: es una caja de botones.

Así como podrán apreciar, las experiencias de realidad con este objeto son variables y todas pueden expresar su realidad. Pero si tuviéramos que evocar la realidad del objeto en cuestión, ningún nombre de los propuestos serviría, ya que no es sólo una lata, ni un adorno, ni un juguete, ni una caja de botones.

Entonces, para poder expresar la experiencia de realidad de ese objeto, deberíamos asociar una descripción formal; que es una caja, de lata, de tal o cual color y forma, etc; a un nombre botones, ya que en su autonomía la descripción de la forma o el nombre no especifican de qué se trata.

Es así que para que tengamos la *experiencia de realidad* de un objeto, es necesario que distingamos en él una forma, un contorno, un peso, un color, etc.; es decir, formarnos una imagen de él. Pero además debemos situarlo en un mundo convencional, simbolizándolo.

Al simbolizarlo, cualquiera sea el nombre que elijamos para ello, lo haremos entrar en el universo del lenguaje. Por ello podremos decir, que la experiencia de realidad de un objeto, exige al mismo tiempo el que sea imaginado y simbolizado.

Este sencillo ejemplo, nos permite ahora decir que vamos a usar la palabra *imaginario* como aquello que, como forma o imagen, se opone a la posibilidad de discriminación, nominación y designación que llamaremos registro de lo *simbólico*.

Proponemos además, que estas categorías de lo imaginario y de lo simbólico, son constitutivas de la experiencia de realidad. De esto, J. Lacan nos dice: "La experiencia de lo real presupone el uso simultáneo de dos funciones correlativas, la función imaginaria y la función simbólica".

Así diremos que es "Imaginario" todo lo que no tiene existencia propia como la sombra. Es imaginario un sueño, por ejemplo, mientras no sea interpretado.

Por otra parte, diremos que es "Simbólico" todo aquello que sólo indica la articulación, el vínculo y el sitio; es el signo (+) ó el (-), el guión, la coma, la palabra.

Desde el álgebra podríamos ilustrar el nivel simbólico diciendo: es lo que no tiene sentido por sí, sino aquello que da sentido a todo lo demás.

Por ejemplo, combinando paréntesis con el signo (x) y el signo (+) a 3 números, podemos obtener diferentes resultados. A saber: No es lo mismo decir:

$$(3+5) \times 2 - 16; \text{ que } 3+(5 \times 2) = 13$$

De la misma manera, la puntuación de una oración puede hacerle cambiar el sentido.

Así, una paciente nos decía: Los hombres son inteligentes las mujeres no.

Cuando por el sentido de su historia podríamos expresarla de la siguiente manera ¡Los hombres!, Son inteligentes las mujeres, no?.

Aclaremos ahora que lo imaginario o lo simbólico no existen en estado puro, a excepción quizás de las psicosis.

De esta forma, nuestra experiencia con un objeto se inscribe en los dos planos. Así lo experimentamos como real y podemos comunicar esa experiencia.

Pero, veremos que en las psicosis delirantes, el objeto, que no es simbolizable, se halla fuera de todo sistema simbólico convertido en un monstruoso perseguidor imaginario, mientras que en las psicosis esquizofrénicas el símbolo es tratado como un objeto.

Así, el esquizofrénico vive un mundo simbólico, desprovisto de lo imaginario, es decir, sin forma, sin límites, sin peso, sin color. Mientras que inversamente, en el paranocio delirante, la realidad es vivida de forma sólo imaginaria y formal, donde lo vinculado imaginariamente no puede ser simbolizado.

Por eso pensamos con Serge Leclair, cuyo pensamiento seguimos, que es necesario contar con una teoría que exprese la experiencia de la realidad en un psicótico.

En ese sentido la terapia familiar supone un enfoque amplio del fenómeno psicótico en tanto permite abordar el entorno, en que el psicótico aparece, y desde allí pensar tal teoría.

Recordaremos ahora un caso ejemplar, el del presidente Schreber. En un pasaje de su autobiografía nos dice: "Dicen que soy un paranoico, y dicen que los paranoicos son personas que lo relacionan todo consigo. En este caso se engañan, porque no soy yo quien relaciona todo conmigo, sino él: ese Dios, que habla sin parar dentro de mí a través de sus distintos agentes".

Recordemos además la pregunta constante referida al modo de afirmación de su subjetividad:

¿Quién soy yo? ¿Si no soy ni un hombre ni una mujer?; y correlativamente a ella otra pregunta por la cualidad del prójimo: ¿Quién es él?.

Así, veremos que el delirante reconoce un sólo otro, un sólo sujeto verdadero. Todos los demás no son verdaderos, sino, instrumentos en las manos de un Amo. De esta manera todo tiende a reducirse a dos sujetos verdaderos, el delirante y su perseguidor, o sea, un sólo Yo y un sólo otro alrededor de lo que gira todo.

Además, esto es algo que podemos ver en el ejercicio de nuestra práctica en terapia familiar.

El paranoico, destaca por lo general en el conjunto de su familia, a un otro privilegiado.

Tal vez hayamos generado ya en ustedes diversos interrogantes. Por ello consideramos ahora en conjunto los problemas de la comunicación y de la intersubjetividad.

La primera cuestión a resolver es una interrogación acerca de ¿quién habla, a quién habla y de quién habla?.

Nós planteamos este interrogante pues permite buscar una relación entre el sujeto y la comunicación. Podríamos decir además, que la intersubjetividad se ha ido convirtiendo en un lugar cada vez más confuso en la literatura psicoanalítica actual, por ello es preciso que tratemos de abordar este tema.

Salvo en el mundo de la psicosis, donde la relación se establece entre dos, en las neurosis esa relación se realiza entre tres sujetos. Tal es el espíritu del Complejo de Edipo.

Comenzaremos a hablar del esquema que vamos a utilizar, no sin antes destacar lo engañoso del mismo si no tenemos en cuenta para pensarlo la estructura edípica anteriormente desarrollada.

Llamaremos S y O a dos sujetos, (el sujeto y el otro) de la relación intersubjetiva.

Introduciremos ahora el yo de cada sujeto; pero antes queremos hacer una aclaración. Este Yo no debe confundirse con el Sujeto, como sucedería en la teoría del Yo. Cuando hablamos de Sujeto nos referimos al Sujeto del Inconsciente respecto de quien el Yo es solamente un efecto.

En ese sentido podríamos situarlo dentro del mismo sistema de referencias que habíamos usado para situar la experiencia de lo real. Es decir del lado de lo imaginario. Y podríamos definirlo de la siguiente manera: "El Yo es el lugar de la identificaciones imaginarias del Sujeto".

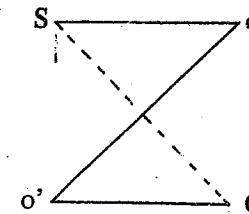
Destacaremos además que la función imaginaria del Yo, como formación, deformación o información se opone al carácter simbólico del sujeto.

Vayamos ahora al esquema de Jacques Lacan llamara L. Y comencemos por describir los elementos que lo componen:

Llamaremos con o (porque es la inicial de otro) el yo del Sujeto S. y o' al yo del sujeto O (lo designamos con O mayúscula, para enunciarlo como otro distinto del otro semejante).

Esto lo consignamos así porque la subjetividad propia del otro, se nos aparece a cada uno de nosotros bajo la forma del Yo. Así la

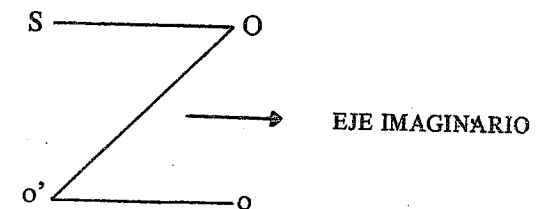
comunicación entre dos Sujetos se puede esquematizar como pueden observar en los esquemas con una línea que va de S a o, de o a o' y de o' a O, e igualmente a la inversa.



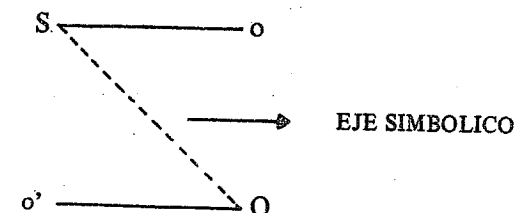
Con este esquema queremos señalar el desvío necesario por o — o' para comunicar a los sujetos S y O. Esta, por otra parte, sería la manera corriente (de yo a tú ó de tú a yo) en que se establece la comunicación intersubjetiva.

Discriminaremos ahora algunos de los elementos que componen el esquema.

Así, llamaremos al eje o — o', como Eje Imaginario, en tanto que une los dos Yo, cuya función imaginaria ya mencionamos.



A la otra diagonal, que hemos marcado con líneas de puntos y une a los Sujetos S y O, la llamaremos Eje Simbólico ya que une virtualmente lo simbólico de cada sujeto. (Es decir, lo inconsciente). En oposición como ya vimos a lo imaginario del Yo.



Este esquema, que, volvemos a repetir, es simplista y engañoso, tiene la ventaja de permitirnos ver donde se altera la vía de la comu-

nicación en el mundo de la psicosis.

Pero antes de adentrarnos en ese tema, recordemos que para que se produzca la comunicación entre los sujetos S y O, los segmentos en forma de Z deben acoplarse; en ese sentido ya podemos vislumbrar los inconvenientes que se producen en la psicosis, dado que el psicótico presenta dificultades con respecto a la propia subjetividad y a la subjetividad del otro.

Es decir, la comunicación es posible en la medida en que cuando hablo reconozco que soy yo quien habla como sujeto, dado que asumo las palabras pronunciadas por mí.

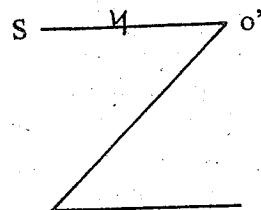
Por el contrario, cuando prestamos atención a lo que dice nuestro interlocutor, ajustamos sus palabras a la medida de la subjetividad que le atribuimos, tratando de reconocer en él, la intención que lo anima. Si este fenómeno se da, es porque algo del orden de la identificación interviene en ello.

Pues bien, en el psicótico esto no sucede. El ajuste de su palabra con respecto a la medida de su subjetividad es irrealizable.

Además, podríamos decir que el psicótico no reconoce siempre lo que dice. Recordando la cita de Schreber, señalemos, que Ello (Dios) habla de él.

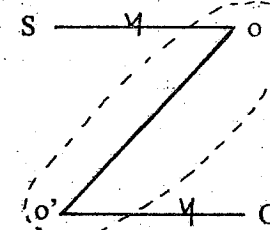
Aclaremos que al decir que no reconoce sus palabras, no significa que no comprenda lo que de esa manera se articula. Así, por ejemplo, desconociendo como suyo un discurso, dice que le es transmitido. Además, tampoco puede ajustar las palabras que un interlocutor le dirige, con respecto a la medida de la subjetividad que anima al otro.

Es como si la comunicación estuviera interrumpida entre el Sujeto y su Yo (entre S y o en el esquema), quedando sólo ese lugar imaginario, carente de toda referencia simbólica.



Al mismo tiempo, el interlocutor también es reducido a su yo, no siendo considerado el otro como una subjetividad alterna.

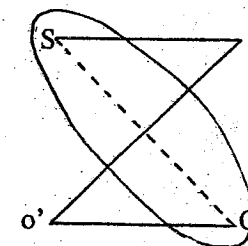
En nuestro esquema, deberemos agregar una ruptura entre o' y O, quedando así como única vía de comunicación posible, el eje imaginario o — o' de la comunicación intersubjetiva.



De esta manera, el orden imaginario se separa del simbólico, imposibilitando entonces una apropiada aprehensión de la realidad, por ello todo se jugará ahí, inserto en una dialéctica especular y agresiva. Es así como en el mundo imaginario de la relación paranoica, sólo podrá haber dos seres, el bueno y el malo.

Así, descentrando de su subjetividad, no deja por ello de usar el lenguaje como cualquiera, pero a este nivel el signo es dislocado en significantes sin significado. El delirante no conduce el lenguaje que habla. Como diría Lacan: el delirante "es hablado", ya no habla

Volvamos ahora nuevamente al esquema. Por lo que habíamos visto, el eje simbólico (S — O), se superpone al eje imaginario (o — o') de donde las palabras toman un pleno valor de cosa. Son tratadas como cosas.



Parecería pues que el esquizofrénico descuida de la experiencia de la realidad el aspecto imaginario y formal, percibiendo de todas las cosas sólo el valor simbólico.

Es así que negando toda identificación imaginaria, vive su relación con el otro, que, en el seno de su autismo ni siquiera merece el nombre de otro.

Pensamos entonces que todo intento terapéutico, deberá reubicar en el esquizofrénico la función imaginaria (eje o — o') con

el advenimiento de las identificaciones que los constituyan.

En nuestra experiencia la terapia familiar brinda un importante campo para que se desarrolle el proceso terapéutico donde un yo se formaliza.

Los esquemas que hemos presentado, representarían momentos críticos de la comunicación intersubjetiva y tendrían la función de permitir en nuestra práctica, la posibilidad de reconocer en una familia: quien habla, de quien habla y a quien habla. Esto es, la encrucijada donde se articulan una teoría del lenguaje con una teoría de la identificación.

Ahora bien, esta formulación nos ayuda a diferenciar entre el plano imaginario y la relación narcisista en que el delirante se mantiene, así como poder observar su recurrir desordenado a la simbolicidad de su subjetividad perdida.

Nuestra función con la familia será tratar de devolver, en el caso del delirante, el uso de su subjetividad y buscar la posibilidad de centrarlo alrededor de su propio valor simbólico. Para ello nuestras intervenciones deberán estar dirigidas a dar testimonio de una subjetividad autónoma tercera, o sea, deberán llamar allí a un Otro. a un PADRE que pueda hacer retornar al enfermo a un modo de comunicación más abierto a la dialéctica del proceso terapéutico.

Debemos tener presente además, que así como el neurótico se pregunta y nos pregunta en relación a sus síntomas, la entrada a la psicosis se constituye en una respuesta.

Decimos respuesta, ya que el delirante no pregunta por qué delira, sino que con ese delirio nos habla de una restitución en su ser.

Así podemos verlo por ejemplo en el delirio de Schreber, en tanto que la presencia de Dios en él, restituye la falta de la función paterna. Aquella que por su ausencia, le ha impedido constituirse en sujeto deseante.

Es decir, que es respuesta a su articulación en una particular estructura familiar. Es más, en el caso del delirante o del esquizofrénico, su discurso responde a la interrogación que sufre y que consiste en una carencia radical. Así, nos exponen sus vidas sin autocuestionamientos. Ahí la terapia familiar deberá permitir la transformación de esta respuesta en pregunta. Es decir, deberá gestar una transformación estructural.

A manera de resumen diremos que:

—Es importante encontrar el modo que tiene el enfermo de aprehender la realidad, sea a la manera de lo imaginario o lo simbólico, para oportunamente poderle responder mejor sin reforzar la deformación dominante.

—Saber *quien habla, de quien habla y a quien habla* en cada uno de los integrantes del grupo familiar, ya que esto distinguirá al sujeto y a su yo, así como las relaciones entre ellos.

—Reconocer por último, la pregunta psicótica que en su ambigüedad nos indica el problema de la *carencia*, lugar que se constituye en llamado a nuestra intervención y por medio de la cual deberemos intentar, junto con el psicótico y su familia, simbolizar la falta que de su carencia resulta.

Bibliografía

1. J. COROMINAS, "Diccionario crítico etimológico de la Lengua Castellana". Edit. Gredos - Madrid, 1974.
2. S. FREUD, "Tres ensayos para una teoría sexual" (Apéndice). La Femenidad. Sobre la sexualidad femenina. Algunas consecuencias psíquicas de las diferencias sexuales anatómicas. Sobre la transmisión de las pulsiones y especialmente del erotismo anal. Obras Completas. Edit. Biblioteca Nueva, Madrid, 1968.
3. GARCIA BADARACCO, N. PROVERBIO y A. CANEVARO. "Tratamiento de psicóticos". Acta Vol. XVIII N° 4, Bs. As. 1972.
4. GARCIA MORENTE, "Lecciones preliminares de filosofía" Edit. Losada, Bs. As., 1938.
5. J. LACAN, "Las formaciones del inconsciente" Edit. Nueva Visión, Bs. As. 1970. Lectura estructuralista de Freud. Edit. Siglo XXI, México, 1971. Escritos II. Edit. Siglo XXI, México, 1973.
6. S. LECLAIRE, "Acto Psicoanalítico". Edit. Nueva Visión, Bs. As. 1974.
7. M. MANNONI Y OTROS, "Psicosis infantil". Edit. Nueva Visión, Bs. As. 1971.
8. O. MASOTTA, "Cuadernos Sigmund Freud N° 4. Bs. As. 1974.
9. P. WATZLAWICK, J. H. BEAVIN, D. D. JACKSON, Teoría de la comunicación humana. Edit. Tiempo Contemporáneo. Bs As. 1971.

Reflexiones sobre la Terapia Familiar

LUIS ALBORNOZ

Médico psiquiatra. Psicoterapeuta, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar.
Arcos 1737 - PB. A, Buenos Aires, República Argentina.

En estas breves reflexiones que trataré de dar forma a lo largo de la charla quiero pensar un momento quién de nosotros no ha experimentado las satisfacciones e insatisfacciones de la vida familiar. Quién de nosotros no conoce los momentos de tensión o de sosiego, quién no ha sentido o ha impuesto de alguna manera una presión familiar en determinados momentos? Y si recordamos nuestra infancia y la relación con nuestras personas significativas creo que ya tendremos una primera imagen, ahora de la vida familiar y de las relaciones interpersonales en las cuales vivimos cada uno de nosotros y que nos sirve de referencia para podernos adentrar en el tema del grupo familiar.

En la vida de los grupos humanos quién no tuvo que decidir entre la elección individual y la del grupo en el cual está incluido en ese momento de la vida? Quién de nosotros en caso de haber vivido la experiencia de un análisis individual o grupal no supo lo que es depender para reestablecer niveles más maduros de identidad?

Y ya entrando en la patología Didier Anzier dice que: "Es

literato el que bajo el velo de la trasposición artística toma a su cargo las verdades desconocidas".

Así Sartre, dramaturgo, en "Huis Clos" muestra como tres personas condenadas a vivir juntas, sin poder apagar la luz, ni aislarse, detestándose piensan que "El infierno son los otros".

Pero paradójicamente ahora traeré una comunicación en la cual dos personas viven juntas, y entre comillas, el infierno son los demás.

Esta comunicación científica presentada y desarrollada en Francia hace 101 años me parece un jalón científico de la psiquiatría de esa época, que anticipa la clínica de las Relaciones Familiares, y que articula con el motivo por el cual estamos hoy, acá reunidos, el estudio de la familia y en mi caso particular el de la Patología Familiar. Pienso que dentro de la forma de encarar el tratamiento de las enfermedades mentales, el hecho de tomar a la familia como un lugar donde se puede trabajar terapéuticamente es una etapa nueva y valiosa en los tratamientos psiquiátricos, y tomo esta comunicación científica de hace un siglo como algo avanzado de esa época, pues, en la misma, se plantea la relación de dos o más personas que conviven y experimentan la distorsión de la realidad de manera conjunta. La comunicación fue realizada por los Dres. Lasague y J. Falret, y la titularon "Folie à Deux ou Folie Communiqué" y consta en los Anales Médicos Psicológicos del año 1877, ya más de un siglo. Les relataré brevemente el comienzo y las conclusiones de este trabajo. Hay casos en que la *distinción del entendimiento* entre el demente y aquellos que viven en contacto cerrado con ellos no es definido; es para estas excepciones que está dedicado el Estudio.

En las conclusiones extractadas tomo estos puntos:

- 1) Una persona sana no se contagia de insania.
- 2) El contagio es por excepción.
- 3) Hay una persona activa y una pasiva, la primera crea la fantasía, la segunda frente a la presión, corrige, coordina el material delirante hasta ser una imaginación común. Luego es necesario distinguir el primero del segundo insano.
- 4) Vivir estrechamente y aislados de la influencia de afuera.
- 5) Existir la condición de probabilidad para ser comunicada a otro.
- 6) Se descarta la herencia en caso de marido y mujer.
- 7) Separar a los pacientes (principal indicación terapéutica).

8) El más pasivo es menos afectado, se recupera.

9) La insanidad puede extenderse a terceras u otras personas pero el tiempo que transcurre se puede aislar al insano y se pierden las falsas ideas en el medio ambiente.

Al ver estas conclusiones brevemente reflejadas del trabajo de Folie à deux nos dan una idea clara de la locura como un proceso psicológico de irracionalidad en la cual interactúan dos o más personas no resaltando las teorías y etilógicas vigentes de la época; es por este enfoque que considero este trabajo un primer o de los primeros antecesores de una óptica clínica en las relaciones familiares enfermas.

Al poner jalones dentro de la Historia de la Terapia Familiar en el país quiero mencionar al Dr. Enrique Pichon Riviere, en las ideas que desarrolló sobre el grupo familiar y el paciente psicótico, obra que conocí a través de la curiosidad que despertó en mí durante el aprendizaje del Psicoanálisis Guestráltico desarrollado por el Dr. Fernando Taragano, además quiero testimoniar mi agradecimiento a un profesional con el cual trabajé y estudié en mi etapa de la residencia en Psiquiatría y posteriormente, el Dr. Juan José Morgan. Nuestro trabajo se centró en el tratamiento de psicóticos y grupos de psicóticos y el abordaje de la familia de psicóticos, en la sala VIII, y con pacientes privados.

Con los Dres. J. García Badaracco, N. Proverbio y A. Canevaro y los terapeutas de la Institución Clínica Psiquiátrica nos unen 10 años de tarea que trataré de desarrollar en el aspecto de la Terapia Familiar.

Recordando nuevamente a la familia del paciente psicótico tengo bastante claro los primeros años del Hospital Neuropsiquiátrico de hombres, actual J. T. Borda, donde para mí el paciente psicótico era el psicótico y, la familia que lo internaba era lo no psicótico. Esa impresión no fue cuestionada por mí hasta que comenzó mi formación dinámica y mi tratamiento individual, mi contacto con la familia era breve, esporádico, en casos de enfermedades físicas, en crisis, vale decir que en esta época el concepto de que el paciente tenía la locura y nadie más era indudable. Mi búsqueda en esa primera etapa de las respuestas a mis interrogantes era una Semiología y un Diagnóstico, tratando de encontrar la última respuesta en el Laboratorio de Anatomía Patológica con una persona que me transmitía sus respuestas y sus preguntas sobre el funcionamiento

del cerebro y de la vida, hablo del Dr. Diego Outes, brillante neuropatólogo. Sin embargo, los datos de lesión cerebral en la Esquizofrenia todavía estaban sin respuesta y desde lejos veíamos trabajar en el hospital la comunidad de la Sala que dirigía el Dr. J. García Badaracco, y pienso que despertaba en mí una inquietud de algo que era diferente y peligroso para el concepto tan claro de que el paciente psicótico tiene que estar en el hospital y eso de conversar y reunirse era algo inentendible, pero que evidentemente despertaba un temor oculto a través de la ironía o el chiste.

Pienso ahora, que realmente, para algunas personas, fue inentendible pues luego de algunos años reunir brevemente algunos pacientes se lo calificó como Comunidad Terapéutica.

Ahora, fíjense Uds., luego de tantos años, estamos reunidos en una Sociedad de Terapia Familiar, donde yo pienso que la familia es la que tiene aspectos psicóticos que pueden ser más o menos graves y que el paciente es uno más de ellos, vale decir que el *Paciente es la Familia*.

Ahora me surge otro interrogante: ¿sirve para algo la Terapia Familiar? Los que sufren se alivian con esta técnica? se da una salida terapéutica más genuina a la enfermedad mental? O estamos tratando de desarrollar una conceptualización teórica para nuestro alivio y para poder sentir que hemos hecho algo, poner una nueva etiqueta o crearnos un nuevo sofisma, sin haber captado verdaderamente una faceta más de la compleja realidad en la cual vivimos? A estos interrogantes trato de darle una respuesta ahora. Espero que los próximos años nos den nuevos niveles de realidad que enriquezcan y afiancen nuestra actual experiencia.

Esta experiencia se basa en 10 años de Trabajo particular en mi consultorio y en una institución privada denominada técnicamente Comunidad Terapéutica Psicoanalítica y que incluye la terapia familiar y la terapia psicoanalítica individual en un contexto Comunitario de Estructura Multifamiliar (definición del Dr. J. García Badaracco).

La mayoría de las familias presentaban en su grupo un paciente psicótico en general con diagnóstico de esquizofrenia. En este punto creo necesario remarcar que el terapeuta que trabaja con psicóticos y fronterizos, con su familia en este caso, necesita de ciertos instrumentos o recursos terapéuticos que le permiten afrontar la

gravidad de estos cuadros, sino se corre el riesgo, que bajo, una bien intencionada omnipotencia fracasen o tengan que desarrollar en términos de porcentajes una mayor terapia biológica en el paciente internado y una mayor alianza sin condiciones con el grupo familiar, sin poder trabajar más profundamente por falta de continente emocional en el tiempo. De todos modos, esto también está relacionado con el N° de familias que se trabaja, el tiempo disponible del terapeuta, la capacidad emocional del mismo y su experiencia. Acá el Dr. A. Sicardi nos trajo un excelente trabajo donde el proceso terapéutico casi sin excepción, creí entender, pasó por su consultorio particular, pero creo que esto no es lo común, exagerando al máximo diré que llevar un paciente esquizofrénico a vivir a la casa del terapeuta, si lo hace es por una vez. Con esto me refiero al esfuerzo emocional que estos casos exigen.

Retomando el trabajo en la Terapia Familiar, pienso que es un recurso importante dentro de la Psiquiatría y al cual debe tener acceso y formación el terapeuta que desarrolla su quehacer dentro del marco de la Psiquiatría Dinámica y resultaría que además de importante, imprescindible en la Patología grave. Con esto también quiero puntualizar que el trabajo con familias de pacientes neuróticos también demuestra resultados satisfactorios. Esta línea ha sido desarrollada por un colega con el cual trabajamos en coterapias varios años, el Dr. J. Alonso.

La hipótesis teórica y la observación clínica que lo confirma y que ha sustentado mi trabajo a lo largo de este tiempo es el concepto de proceso terapéutico, desarrollado por el Dr. Jorge Gacía Badaracco, es un instrumento útil y válido para comprender el trastorno mental y sus tratamientos. Paso a dar una definición textual de proceso terapéutico (Rev. APA - Dr. J. García Badaracco). Por su parte el *Proceso Terapéutico* podría definirse como el conjunto de transformaciones que puede experimentar un individuo a través del tratamiento, pueden existir entonces variados tratamientos en cuanto técnicas de abordaje o recursos terapéuticos, pero el proceso terapéutico propiamente dicho, constituye necesariamente una unidad, que consiste en una sucesión de cambios que pueden presentarse o darse en realizaciones variadas, pero que tienen una coherencia interna y un sentido progresivo de desarrollo hacia una condición humana de mayor integración de la personalidad y mayor madurez y equilibrio emocional.

Luego de esta definición de Proceso Terapéutico que alguien puede suponer en un primer momento como fácil y simple pero que encierra la complejidad de un proceso conjunto en el cual está incluido el terapeuta y su desarrollo como terapeuta y como persona. El que ha visto desarrollarse un proceso terapéutico, puede tener una convicción cierta de que la enfermedad mental (estoy hablando de la esquizofrenia) puede desaparecer si uno puede proporcionar a la familia y al paciente los suministros psicológicos suficientes necesarios para su crecimiento. Es una tarea ardua, difícil, poco gratificante, pero que da frutos. Acá deseo referirme al terapeuta, si yo utilizo este esquema referencial de trabajo debo mencionar una variable básica, que es el clima emocional de trabajo en equipo, anteriormente mencioné la necesidad de ciertos instrumentos para una mayor operatividad, y el trabajo en equipo debe funcionar con el mejor nivel posible y así lo debemos tratar de lograr y mantener.

El terapeuta familiar, el terapeuta individual, el equipo terapéutico en suma sufre profundos ataques normalmente desde lo interno a lo externo, y dónde el terapeuta contraidentificado con aspectos parciales o dificultades personales no resueltas puede tender a sabotear inconscientemente o conscientemente este proceso terapéutico. Yo diría que es un capítulo esencialmente rico y necesario de mayor estudio y desarrollo este punto que encuadra y encuentra al terapeuta familiar con sus coterapeutas de equipo en una institución de estructuras como la que definimos anteriormente.

Searles refiriéndose a la sociodinámica de la Sala de Hospital dice que el paciente con un ego fragmentado tiende a originar en la Sala un proceso según el cual tanto la diferenciación como la integración subsecuente de los fragmentos dispersos del ego debe producirse en gran medida externamente en las personas de aquellos que lo rodean antes que estos procesos se produzcan en él. En otros párrafos dice: "La simbiosis del grupo constituida por el paciente, los diversos miembros del personal, y los demás pacientes, reproducen elementos propios de la simbiosis que se establece entre la madre y el niño que será esquizofrénico.

En esta relación grupal, los límites del ego son indistintos y los diversos participantes funcionan a medida que la ansiedad aumenta menos de una manera realmente interpersonal, que como un organismo biológico unitario.

Yo acá diría que el terapeuta familiar como miembro de un equipo terapéutico no está libre de las disociaciones que el paciente trata de provocar en los terapeutas. Y que además debe enfrentar con el grupo familiar del paciente también todas las tácticas defensivas del mismo, su contratransferencia debe trabajar sincronizadamente y en los dos niveles para no entrar en conflicto con otros miembros del equipo terapéutico de la comunidad.

Quiero recordar al hablar de coterapeutas que el abordaje de esta técnica psicoterapéutica esta ligada a un intercambio entre terapeutas que facilita el aprendizaje y la labor con la familia.

En las actas del primer congreso de Psicología del grupo familiar aparecieron varios trabajos a los cuales me referiré. El que trata sobre coterapia (Dres. G. Badaracco, A. Canevaro y Czertok) dicen: "Este nivel de exigencia es tan grande que a veces es muy difícil superar momentos de desesperanza y desaliento", en otro reglón acotan: "Podríamos decir que se ha sumergido en el grupo desapareciendo como observador pero da lugar a que el otro terapeuta se transforme entonces en el observador y el coordinador". "las intensidades de los conflictos se reducen a veces a quién enloquece a quién" o en "quién se queda con la locura de quién".

Esto se da en la Terapia del Grupo Familiar pero a través del tiempo y de una mayor experiencia el terapeuta familiar, pienso, desarrolla una mayor capacidad yoica, un observador que puede entrar y salir del clima de defensa confusional. Citando acá al Dr. Morgan dice: "Pensemos, siguiendo a Bion, en sus experiencias de grupos que estos transtornos de la comunicación tienen como objeto mantener la unión grupal manteniendo la confusión y evitando el conflicto que podría traer como consecuencia la destrucción del grupo".

Yo acoto que la confusión, confusión psicótica, que yo observé es también dada en un nivel contratransferencial y que está al servicio de que no se logre una capacidad de pensamiento e individuación del terapeuta que está viviendo el clima de la dinámica del grupo familiar. De esta manera no se plantea el conflicto. Si se lo logra englobar esto exige lo que mencioné hace un momento: la capacidad de entrar en el clima emocional familiar y poder observar. A través de la experiencia con familias hay más posibilidades de trabajar sin el coterapeuta mencionado anteriormente, pero por una mayor

capacidad emocional que creo que se logra tan solo a través de un profundo insight de las situaciones familiares personales, en la familia de origen y en la familia actual. Es muy conocido para nosotros la movilización y el mayor aprovechamiento del Psicoanálisis individual en las personas que realizan el aprendizaje de la coterapia de familia.

Al señalar las situaciones extremas en la cual están presentes ansiedades psicóticas profundas, el terapeuta se encuentra ante la disyuntiva de defenderse, de no ver, de no poder discriminar, entrando entonces peligrosamente en la posibilidad de quedar englobado o rechazado por la familia (concepto del cerco de goma desarrollado por Wynne) o de otra manera entrar en una alianza patológica en la cual queda paralizada su capacidad terapéutica sería a mi criterio una variación del fenómeno del cerco de goma (el trabajo de alianzas familiares: Dres. Canevaro, García Badaracco, Czertok) pone el acento en el paciente; yo creo que el párrafo dice: "Por el contrario las alianzas enfermas se revelan generalmente estereotipadas, fijas en los objetivos patológicos de negar la realidad y de mantener la omnipotencia aunque puedan cambiar los personajes que intervienen". Yo subrayo esto último, hablando de alianza con el terapeuta retomando la capacidad del terapeuta de salir de estas celadas, diré que todos estos momentos sutiles, a veces fugaces que determinan todo el pronóstico bueno o malo de una terapia familiar, y por ende de un proceso terapéutico.

El terapeuta familiar creo debe tener un entrenamiento psicoanalítico individual y como muchos pensamos un entrenamiento del futuro terapeuta con su familia real. Esta puesta de acento en el terapeuta es porque él es el instrumento determinado emocional e ideológicamente que podrá dar una salida, un movimiento de crecimiento familiar a niveles más maduros, más integrados en una paradójica mayor individualidad de cada miembro.

Expresa M. Bowen: "que un terapeuta no puede pedir que una familia haga cambios que él no ha hecho".

El terapeuta trabajará muchas veces con una familia de estructura narcisista en la cual el deberá prestarse, llamémosle de alguna manera con un objeto transicional estructurante; así Dr. García Badaracco habla de la familia como una estructura transicional para lograr una identidad, o la familia como objeto transicional como objeto estructurante de la personalidad. Creo que el terapeuta

también puede en determinada etapa ser el objeto estructural, transicional que promueva nuevos niveles de realidad en el grupo familiar.

Estas familias en las cuales los deseos y las defensas son tan importantes por su magnitud; en las que las necesidades corporativas y proyectivas se dan en niveles muy primitivos, en las que el monto de frustración y odio son intensos tan intensos como la necesidad de estar juntos. Este "cemento" de amores y odios teñidos eróticamente con fantasías incestuosas pero funcionando como un aparente grupo adaptado a la sociedad me remite a la idea de un falso self del grupo familiar, como existe un falso self de la persona, acá se estructuran roles, que permiten una socialización de una estructura que profundamente no se ha logrado, tienen roles manifiestos pero, a nivel no manifiesto, están sin un sustento estructurante real que sería la madurez de la pareja parental que forma el primer ciclo de la pareja de alianza que luego será familia de origen en la segunda generación. Todo esto se traduce clínicamente en nuestro consultorio por un grupo rígido, omnipotente, estereotipado con mucha dificultad del oír lo que no está en sus patrones de relación familiar, en su fantasía inconsciente y que me remite a revisar para entender mejor conceptualmente las ideas desarrolladas sobre la relación de objetos internos, su formación y la relación con los objetos externos. Tomaré acá algunos párrafos de trabajos sobre este punto, pueden ser extensos para algunas personas pero creo que es la mejor manera que puedo transmitirlos: Dres. García Badaracco y Zemborain dicen: en "Esclarecimiento del Edipo en pacientes psicóticos". "En dicho proceso terapéutico con psicóticos vemos que las cargas de objetos no son abandonadas ni pueden ser sustituidas por identificaciones. En algunos pacientes podemos decir que existen identificaciones primarias del niño con su madre que los llevan a quedar atrapados en un falso self (Winicott); por su parte un padre ausente no permite una identificación secundaria para la constitución del superyo así como tampoco identificaciones estructurantes del Yo".

En "Reacción Terapéutica Negativa y la influencia familiar" G. Badaracco y A. Canevaro dicen: "Por momentos la calidad de los objetos internos del paciente era similar a la de los objetos externos". En otro momento dicen: "Intensas ansiedades persecutorias provenientes de esos objetos (se refieren a objetos internos primarios y

fundantes) que en la Terapia Familiar hemos visto concordantes con actitudes reales de los objetos externos y no solamente provenientes de las fantasías de los pacientes. Las figuras reales, significativas en la vida de estos pacientes, es decir los padres o sustitutos se han comportado como objetos externos, castradores que de alguna manera han impedido una verdadera identificación del yo primario en los aspectos más evolucionados del yo secundario".

En resumen los objetos parentales reales dan por su comportamiento el crecimiento o la perturbación de las capacidades yoicas y en igual medida la mayor o menor perturbación de las fantasías que tendrán vigencia en cada uno de los miembros y los niveles de la fantasía grupal del grupo familiar.

Acá retomaré la familia dentro del proceso terapéutico en tratamiento de psicóticos. Los Dres. G. Badaracco, Canevaro y Proverbio hablan de la inclusión de la familia en el proceso terapéutico para que el paciente pueda desprenderse de sus objetos internos malos a través de la elaboración de sus relaciones de objetos, con los objetos externos reales.

Estos objetos externos reales corresponden a la familia real que es el lugar donde encontraremos características, particularidades, equilibrios que conforman e irán delineando el mundo interno y la calidad de sus objetos, de las personas que lo integran y que en última instancia serán los que favorezcan naturalmente o detengan la evolución de sus miembros; a una mayor madurez corresponderá un mayor enriquecimiento del grupo por los usos de la realidad que integre paulatinamente en su vida y en su constante desarrollo.

Dentro de los grupos familiares que detienen su crecimiento pienso que las observaciones de varios autores han sido coincidentes con lo que observamos en los tratamientos. Mencionaré a Wynne y su desarrollo conceptual de pseudo-mutualidad, no se puede crecer, desconfiando de lo que realmente se siente, Lidz con su idea de sesgo marital, como comenta el Dr. Morgan son familias de conceptualización aberrante. En la idea de cisma marital aparecen más claros los elementos de las lealtades y lo no resuelto de la pareja usando edípicamente a los hijos. De todos modos creo que lo más patológico de un miembro de un grupo familiar es que sea usado, de que no lo sepa conscientemente y que tampoco deba darse cuenta (fuente esta de análisis individuales de muchísimos años) al no darse

cuenta de su uso y como necesita que lo usen en el grupo no sabe discriminar lo que es realmente, lo que quiere ser, su identidad no se logra y termina unido al grupo en un papel adjudicado de antemano muchas veces desde el nacimiento, reviviendo en su persona conflictos del padre o de la madre con la familia original de ellos, también por falta de madurez yoica, de carencias para ver y afrontar conflictos que muchas veces no puede percibir que existen. En análisis individuales de padres que van a tener un chico se puede ver claramente cómo se juega el destino interno de este hijo para tratar de resolver una problemática de los padres. Y acá retornaríamos a la idea de objeto interno —identificaciones— crecimiento yoico natural en una familia normal, o desarrollo del Proceso Terapéutico de redesarrollo de las personas en un grupo familiar terapéutico.

Apuntes para una filosofía terapéutica del grupo familiar

DR. ALFREDO CANEVARO

Luego de la sesión anterior, (iban por la 6a. ó 7a) en la cual el hijo deja de encarnar a su abuelo materno y los padres, rompen un bloqueo emocional que los mantenía muy separados, se disponen en abanico frente a mí, muy expectantes. La joven esquizofrénica traduce ese clima, pidiéndome que les diga cómo son ellos, qué les pasa. Tengo una sensación de incomodidad, siento una especial exigencia de nutrirlos con algo que yo no tengo, de tener que fingir frente a ellos un conocimiento de ellos mismos que yo aún no tengo. Percibo que es importante que esto pase, que están en una relación de dependencia, frente al liderazgo terapéutico que antes no tenían, pero que sin embargo esa respuesta no sería adecuada, como cubriendo otra cosa. Entonces le digo a la paciente que prefiero que sea ella, quien conociendo más que yo lo que pasa, cambie de lugar conmigo y nos cuente cómo ve las cosas.

Al “darle la palabra” desarticulo una situación terapéutica y a la vez le permití a la paciente hablar desde un lugar de privilegio que antes no tenía. Me “pongo de lado” en ese momento, para

permitir que la atención se dirija a la paciente. Ella, superado el desconcierto inicial, comienza a situar el momento actual de su necesidad de la madre, pero refiriéndolo al pasado. Esta, como veremos más adelante, se siente exigida, "tragada" por su hija, y comienza a descalificar ese pedido, mostrándole que esa "avidez de madre" es un problema de insatisfacción consigo misma. (La madre estaba en análisis y muy probablemente trasladaba defensivamente una interpretación, que si bien en parte era cierta, en ese contexto descalificaba la auténtica necesidad de la hija. Esta, por no poder pedirle cariño en ese momento, lo convertía en reproche por el pasado. (Típico malentendido).

Sorpresivamente, el hijo, hasta ese momento aliado incondicional de la madre y denigrador de su hermana, con quién hacía años que no se hablaba, acerca su silla a la de ella y forma un bloque solidario uniendo sus demandas de afecto por la madre. Esto, de lo que el padre dirá más tarde que sucedió por primera vez, conmueve a la madre, quien enmudece y escucha hablar a sus hijos. Estos comienzan a recordar largos meses de soledad, criados por otras personas, lejos de los padres y se va creando un clima de tristeza, mechada sin embargo de una cierta candidez, producto quizás de oír a dos adultos revivir su pasado de niños.

La madre, de una actitud hierática, pasó a inclinarse en el asiento hacia sus hijos mostrando sumo interés por lo que ellos narraban.

Timidamente va respondiendo a algunos de esos reclamos, justificando su actitud, y mostrando ella misma su propia soledad de aquel entonces, y a la vez la alegría de ver a sus hijos unidos en este momento, como siempre los quiso ver. Recuerda sus tempranas pérdidas, su anhelo de que los hijos fueran más felices que ella misma (típica paradoja que recrea desencuentros, herencia psicológica). El clima va cargándose de emoción, en la que yo participo intensamente, sintiendo que finalmente, luego de tantos, se va produciendo un auténtico encuentro. Cuando oigo que la voz de la madre comienza a empeñarse y veo que los hijos están tomados de la mano, escuchando muy atentos, creo que llega el momento de intervenir antes de que se asusten de esas emociones y se retraigan. Le digo a la madre, que es evidente que ella tuvo miedo de cargar a sus hijos con el peso de su propia necesidad de cariño, pero que al desear que

fuera más fuertes que ella misma, se olvidó de que quién eran los niños. (Reunión de soledades que ya comienza a ser encuentro).

Le pido que abrace a sus hijos y que reclinen sus cabezas, descansando, sin palabras, los tres en los tres. Así lo hacen, sollozando, en un momento muy emotivo y se produce un "minuto de silencio". ¡Cuántos duelos juntos, pienso, en tanto procuro que no se perturbe lo que está pasando. Lo miro al padre y veo que está llorando, muy emocionado, pero paralizado, como quizás estuvo siempre en esa situación. Silenciosamente, sin que los demás lo adviertan, lo tomo de la mano y lo llevo a que él rodee con ambos brazos a su mujer y a sus hijos.

Todos le dan lugar y los dejo estar un poco así, yo también con mi garganta apretada, pensando que hubo que pasar mucho tiempo para que se de esto. Tolerar ataques, cuestionamientos, denigraciones. Sé que volverán a producirse después de esta sesión, que todavía hay mucho camino para recorrer, pero que a partir de este momento, la situación es otra.

Luego les pido que traten de quedarse con estas sensaciones, de no procurarse demasiadas explicaciones, y que nos veremos en la próxima sesión.

Quedo satisfecho, aún sabiendo que vendrán momentos difíciles, que estoy trabajando sobre terreno abonado por otros terapeutas y que quizás vengan otros, a quienes habré ayudado yo también de esta manera. Ya no soy tan omnipotente como antes, cuando creía que esto que hacía y que sentía era solo obra mía. Ahora me doy cuenta que representaba algo de ellos, que está ahí oculto y que a través mío se puede movilizar. Sé que estamos recién en el comienzo, pero quizás en el comienzo de algo que ya no será solamente "terapéutico", sino quizás que la vida corra, simplemente, y que esto que es de ellos, sea por ellos más utilizable.

Yo vuelvo a la teoría y ellos a la vida.

Esto es un relato parcial de una sesión, de un encuentro. A veces nunca se da, otras veces no pasa de esto.

Esta experiencia vivida puede ser comprendida desde distintos ángulos. Las teorías pueden ayudarnos a comprender más y mejor lo sucedido. Pero esto primero tiene que suceder, con nosotros o fuera de la sesión o del tratamiento, pero tiene que pasar. Si no, corremos el riesgo de enunciar algo que pertenece a nosotros, a

nuestra teoría, preanunciar algo que nunca pasará. O, en caso contrario, si asistimos pasivos a lo que sucede, puede ser que comprendamos luego, cuando ya sea tarde.

Para aclarar estos conceptos quisiera referirme a la etimología de 4 palabras que son: **TERAPEUTICA - ACTOR - ESPECTADOR - TEORIA.**

Terapéutico - Tomado del latín antiguo y derivado del adjetivo griego *therapeutikós* que significa propiamente "servicial, que cuida de algo o alguien" derivado de *therapéuó* - "yo cuido, especialmente hablando de enfermos y médico.

Actor - Del latín *actorem*, "el que obra". En su sentido más genuino, el actor es el agente que pone en comunicación al poeta dramático con su público. El origen del actor está en las danzas sagradas primitivas. El celebrante, que tiene algo de mago, realiza la danza sagrada para obtener algún fin concreto— ahuyentar espíritus malignos, expiar culpas, hacer rogativas, dar acción de gracias, etc. El primer actor de la historia es, por lo tanto, el hechicero, que se arroga y atribuye unas cualidades que en realidad no tiene, creando una nueva personalidad con la máscara, elemento de transmutación en la escena ritual.

Espectador - Del latín *spectatorem*, que mira algo con atención, derivado del griego *theoros*.

Teoría - Conjunto sistematizado de opiniones sobre algún tema determinado. Conjunto de leyes y reglas sistemáticas organizadas, que son la base de una ciencia y sirven para relacionar y explicar un determinado orden de fenómenos y del verbo griego *theoreo*: mirar, contemplar, asistir como espectador a, examinar, meditar.

Un delicado y sutil interjuego dialéctico une y a la vez separa estos elementos que forman dos pares antitéticos si se emplean simultáneamente. Cuando somos terapeutas, somos también actores, participamos de ese drama, obramos, con toda nuestra posibilidad de sentir y de accionar, de pensar en función de lo que nos está pasando. Cuando somos espectadores, también sentimos y pensamos, pero más en función de lo que vemos. Cuando teorizamos, puede ser sobre los recuerdos o sobre el trabajo de otros, pero en ese momento dejamos de ser terapeutas.

La ubicuidad de nuestro trabajo consistirá entonces en situarnos no sólo en saber *qué* y *cómo* vamos a hacer sino fundamentalmente *cuándo* lo vamos a hacer.

La terapia grupal y especialmente la de grupo familiar crea un espacio que favorece la actuación, por la regresión que pone en evidencia actitudes habitualmente disociadas y porque recrea situaciones conflictivas de intensa carga emocional. El trabajar con los mismos objetos reales externos que protagonizaron pretéritas conflictivas hace que el "calor de la transferencia" sea por momentos altísimo, y que comprometa la capacidad emocional y cognitiva del terapeuta. Enfrentado a ese sistema, no puede dejar de estar incluido en él y una actitud prescindente emocionalmente, sólo complicaría las cosas. El terapeuta tiene que tener la habilidad de estimular situaciones conflictivas latentes y a la vez "ponerse de lado" en la expresión transferencial, no para eludir la responsabilidad, sino para que los conflictos puedan resolverse entre quienes lo crearon, participando como conductor de ese proceso, ayudando a unos y a otros, a la libre expresión de sus efectos. La elaboración compartida posterior da lugar a un tipo de actitud más reflexiva, momento necesario de síntesis.

Estas vicisitudes tienen que tener un sentido y que sea el de permitir la elaboración de duelos no realizados y de conflictos que perturban no solo intrapsíquicamente, sino impidiendo un auténtico desprendimiento exogámico. Obviamente el logro exitoso no depende en forma exclusiva de la psicoterapia, pero éste puede poner en marcha recursos emocionales y cognitivos antes paralizados por los conflictos. El sentido totalizador de este encuentro del sistema con el de los terapeutas será quizás más comprensible si utilizamos una imagen que nos pueda ser útil. Si pensáramos, por ejemplo, que este grupo humano que viene a la consulta es una compañía teatral que nos va a re-presentar una obra, vamos a ser espectadores de muchas cosas. Ahí veríamos jugarse un drama, a veces una tragicomedia, en la cual los actores se mueven, representan papeles, juegan, intervienen con el público en función de la obra.

Podemos también intentar conocer el autor y la época en que fue el argumento, conocer sus versiones libres o fidedignas, detenernos en el texto o en el contexto.

Podríamos participar, hasta quizás dirigir, ¿pero en función de qué programa? Las obras pueden sucederse, los actores representar el mismo papel o cambiar. Hacernos vivir y recordar muchas cosas, pero cuando cae el telón ¿que pasa? ¿Cómo es la vida de esa troupe,

sus juegos de poder, sus alianzas y complicidades, su vida íntima, sus grandezas y mezquinidades? ¿Quiénes son ellos? Para saber eso, nosotros, espectadores, actores pseudodirectores, tenemos que avanzar un poco más y meternos entre bambalinas. ¿Qué diálogo sorprenderemos en esa troupe? ¿Qué sienten por ellos y por nosotros? Y volviendo a nuestras casas ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos, vivimos y recordamos? ¿Qué nos *han hecho* sentir, vivir y recordar?

¿Y no será también al revés? Nosotros como equipo exponiendo nuestra teoría y nuestros valores y a veces una declaración sesuda y doctrinaria de cómo deben ser los buenos padres y los buenos hijos según nuestra teoría, lecho de Procasto donde queremos acomodar los hechos.

Para mí, es con este estilo como me gusta imaginar un tratamiento y el terreno de la transferencia - contratransferencia donde se juegan los hechos, donde se re-presentan los dramas, donde se buscan las verdaderas personas (verdadero self) quienes tendrán una mayor o menor textura moral, emocional e intelectual, pero que así son.

Es en este respeto profundo por ellos cada uno aún en el drama más terrible y siendo o jugando papeles monstruosos, que deben ser tomados como parte de la función. Sólo así podrán ellos y también nosotros sacar provecho de ese encuentro.

Podemos detenernos en el diálogo, en las posturas, en las coaliciones, en las secuencias, etc., pero sin detenernos en la esencia profunda de este encuentro, habremos perdido de vista el sentido último de nuestra tarea.

Por eso, en el proceso terapéutico de un grupo familiar, yo quisiera que se pudieran tomar las distintas transferencias como una parte del rompecabezas. Esta transferencia idealizada, distorsionada, pero parte al fin, sin la cual no se completa el sentido de lo representado. Intento parcial, frustrado y frustrante de solucionar - repetir el pasado. Es como el relato de un espectador de un hecho que al mismo tiempo que lo relata se convierte en actor para el otro.

Transmisión a través de sí mismo. Grupalmente, el puzzle se completa y por cada integración de lo disociado se reviven emociones que enriquecen al grupo familiar, en tanto les permite comprender y reparar.

Esas emociones tienen mucho que ver con duelos no realizados -

tristeza - angustia - rabia - impotencia, que se convierten en la satisfacción - alivio - ternura de lo saldado. Es la diferencia entre las lágrimas amargas y las lágrimas dulces, como decía una paciente.

La fantasía del no-paso del tiempo, espacio mitológico de la inmortalidad, desesperado intento originador de las simbiosis que no se resuelven. Trampa compartida que intenta congelar el tiempo, retener el momento de fusión, anhelo siempre buscado que representa a la vez la inmortalidad y la muerte, porque en sí es un acto suicida. No-vivir la vida para retenerla, extraña paradoja nutrida por la omnipotencia, que es la matriz generadora de muchas psicosis.

El miedo a la vida, porque para vivirla hay que aceptar la muerte y ante ésta sólo hay un camino = la transferencia.

Por eso el bloqueo de esta trascendencia, en un grupo familiar, es el mayor castigo. Es la maldición que perpetúa la herencia psicológica de los desencuentros porque con una gama variada de matices, estos desencuentros se transmiten, quizás en parte, como la necesidad de hacer presente la incompletud como factor de búsqueda, la frustración como generadora de vida. Sin embargo el que se sacia, no pierde por eso el hambre, sino que la espera con mayor confianza. Con mayor seguridad. El que se sacia de vida, no teme la muerte. El que se sacia de amor, no teme al odio.

Por eso, conseguir ese encuentro grupal, esa comunión, fusión no simbiótica, sino re-unión que permite saldar el Debe y el Haber es la meta que debe perseguir toda terapia familiar.

Una vez lograda esa experiencia, todo puede ser posible, cualquier tema puede ser abordado, luego es sólo cuestión de tiempo. Es el momento clave en el que se resuelve el enigma, el puzzle, el teorema.

Por eso en la terapia familiar, el antes y el después de ese momento, puede definir dos espacios. Uno, el anterior, cargado de trampas, coaliciones múltiples, sabotajes, discusiones estériles, etc. Es, la etapa más difícil y muchas veces nunca superada de una terapia familiar. Ahí podemos ver la gama más variada de técnicas, que en el fondo intentan evitar una nueva frustración. Logrado lo anterior, llámese resolución de los Edipos cruzados, comunión o encuentro grupal, elaboración de los duelos, todo lo que viene es descenso de la montaña.

Todo encuentra su explicación. Pero para llegar a esto, hay que

poder despedirse. No se puede juntar nada que no haya sido previamente separado. No se puede separar nada que no haya sido unido previamente. Dialéctica extraña y trágica de la incompletud del ser humano.

Por eso, el momento del encuentro nutre para el momento de la despedida. La vida sigue corriendo, y éste es quizás el duelo más importante que todo ser humano tenga que hacer, para comprender y aceptar la vida misma.

Llegado este momento en una terapia familiar, podemos decir que una familia se ha curado. Entre la serenidad, la sabiduría, y ahí el terapeuta acompaña, como un compañero de ruta, tierno, emocionado, satisfecho, él también con facilidad de poder desprenderse de ese grupo. ¿Qué es él en ese momento? ¿Qué se transfiere sobre él? Patriarca, gurú, compañero de ruta, persona? Persona que vibre, sufre, piensa y acciona. No hay más misterios, hay gratitud.

Ese antes y después en toda terapia, ya sea en cada sesión, ya sea en cada grupo o secuencia de sesiones, ya sea en una visión longitudinal del proceso terapéutico, califica, diagrama todo el problema de la transferencia - contratransferencia. Es el hito que permite redimensionar todo el proceso.

ATENEO CLÍNICO

En este número de la revista, publicamos el Ateneo Clínico realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Familiar el 27 de junio.

Este ateneo, con el objeto de seguir abriendo puertas a todas las intervenciones posibles en el campo de la Terapia Familiar, reunió a tres terapeutas de niños que abordan su trabajo desde una perspectiva familiar, y que están ubicados en dos diferentes corrientes, la psicoanalítica y la interaccional.

¿Cuál es la problemática del niño? ¿Existe y es gestada en su subjetividad, o en relación con el entorno que soporta y que al mismo tiempo determina su estructura? En este último caso, el tratamiento de un niño ¿incluye necesariamente a la familia? Si es así, esto nos permite además, pensar en los problemas de la prevención, aunque la palabra no resulte muy adecuada. Prevención de un futuro... o es que ¿el futuro no está ya presente cuando se habla de los orígenes? Y hablar de orígenes nos remite necesariamente a los mitos? .

Podría decirse que lo que debiera ser dicho, queda olvidado detrás de lo que se escucha. Y precisamente lo que tenemos que buscar es lo que debiera ser dicho. Para ello el proceso terapéutico que la familia y el terapeuta recorren, permite tratar de encontrar los restos discursivos que conforman mitos, entendiendo por mito a ese discurso que sustentan los discursos posibles, es decir, aquellos que se generan alrededor de lo dicho.

En este ateneo se abordarán aspectos fundamentales de la perspectiva particular que la Terapia Familiar tiene en el tratamiento de infantes, como ser las especiales características del discurso de un grupo familiar cuando los niños aportan dibujos, juegos, infancias..., y en consecuencia las técnicas específicas que obliga a utilizar al terapeuta que se incluye en esta particular puesta en escena de la dramática familiar.

Stella Maris Molina y Rafael Skiadaressis

INTEGRANTES

Lic. María Elena Gandolla de Czertok
Dr. Isidoro Gurman
Dr. José Bechuk

Composición del grupo familiar:

Diana: 44 años; fue directora de escuela. Ahora es maestra de niños psicóticos.
Eduardo: 43 años, comerciante, viaja frecuentemente por razones de su trabajo.
Mario: 10 años; sexto grado; entró en el colegio con 5 años, tres días después de lo permitido, pues cumple años el 3 de julio, por influencia de D.
Mariana Gloria: 6 años; primer grado.

Historia de la familia:

Se conocieron porque los presentaron, él la invitó por teléfono a salir. El día que se conocieron se comprometieron; al año se casaron.

Ella no quería presentarle a su familia y él, un día, fue a buscarla y se metió en la familia.

Ella proviene de una familia católica, arraigada en la tradición. Existen personajes que tuvieron participación en la historia argentina. El casamiento no fue por la Iglesia "porque E lo exigió". Ella reza cuando E está fuera. E proviene de una familia atea.

Se casaron en 1965, en 1966 D se embarazó y en 1967 "nació Alberto". Luego cuenta que nació muerto. Hablan de Alberto como de alguien vivo entre ellos. El nombre de Alberto es el del abuelo paterno. Dice D: "no fue un embarazo entre E y yo, sino entre la madre de él y él; ellos eligieron el nombre y todo lo planificaron". "Yo miraba de afuera". A los seis meses se embarazó de M. Nació por cesárea. El nombre es de un general, tío de ella, "un gordo bonachón. "El era con mi abuela alguien gentil; siempre le traía un regalito."

Mariana Gloria es el nombre de la bisabuela materna.

Abuela materna: Betina.

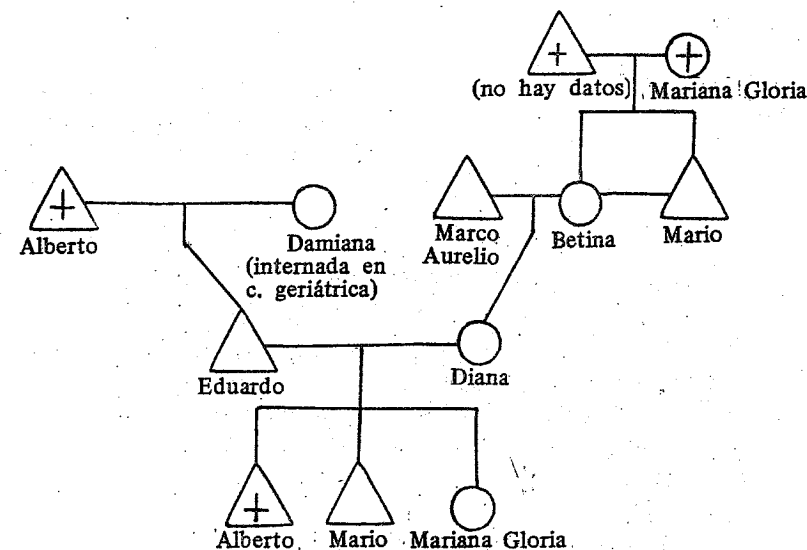
Abuela materna: Damiana, internada en clínica geriátrica hace 8 años; la internó D.

Abuelo materno: Marco Aurelio. **Abuelo paterno:** Alberto, murió en 1960.

Vivienda:

Viven en tres ambientes, a dos cuadras de la familia materna.

Esquema Familiar



GENOGRAMA

Motivo de la consulta:

Problemas en la escritura de Mario. Escribe juntando algunas palabras, a veces no cierra las letras. Las dificultades comenzaron en tercer grado; juntaba palabras y hacía cortes. Tenía una maestra que *"era un desastre."* Lo cambiaron de colegio. En este momento el maestro dice que tiene problemas de inhibición. Somatiza enfermedades. Hace poco, cuando E viajó, dijo que *"se quería tirar del balcón."*

Hicieron dos psicodiagnósticos previos; la devolución fue que era un chico muy sano. Ellos se sorprendieron con esto.

Registro de la entrevista diagnóstica familiar

Se presentan:

Eduardo: 43 años, padre de familia (E)

Diana: 44 años, madre de familia (D)

Mario: 10 años, hijo (M)

Mariana Gloria: 6 años, hija (M.G)

Se sientan: E, M.G, D y M.

T: La consigna es que estamos reunidos para poder hablar de las dificultades de M., y poder escucharlos a los cuatro juntos.

(Previamente hubo cuatro entrevistas a los padres y tres con M.)

M.G: No sé (haciendo la niña y hablando como si tuviera menos edad). Sólo papá y mamá saben de qué hablar...

D: No (en forma cortante) vos sabés, vos tenés que hablar de tus relaciones con M.

M.G: De eso me da vergüenza...

D: Pienso que tenés celos; Mariana es muy celosa...

M.G: Mario me enseñó a pelear.

D: Acordate (no se sabe muy bien a quién se dirige) cuando yo la tenía en brazos; él (en relación a Mario) la acariciaba y ella lo pateaba. Ella le pateaba la cabeza. Para mí ella es muy celosa. Y bueno, (dirigiéndose a M.) vos eras dueño de todo cuando ella nació. Dueño de todo. Ella tuvo que hacerse un lugar en la familia. Ella te mi-

ma, te trata bien.

M: (realiza un gesto de negación).

E: Ella te lleva el postre, te atiende, está mal que no te acuerdes.

M: Y... sí...

D: Ella te mima, te da lo mejor que te puede dar.

M.G: Es cierto.

T: Y a todo esto, ¿qué piensan los hijos de los padres?

D: Yo pienso que me identifiqué con ella y me rebelé de ser muy servicial con él (en relación a M.) A él le parece bárbaro, le gusta que lo atiendan. A él le encanta comer en la cama.

M: Cuando yo tengo ganas de comer en la cama, si no me atienden, me lo sirvo solo; además, a vos también te gusta que te sirvan en la cama (dirigiéndose a D)

E: En casa nos mimamos todos. A mí me gusta llevarle el té a él (M), a los chicos a veces a D. Además Mariana es muy servicial, le gusta atendernos; el otro día nos trajo el té a la cama. El otro día no me quería levantar para desayunar y Mariana me trajo el desayuno, me atendió. Ella es muy prolija.

D: (dirigiéndose a M) ¿y no te acordás? Y quién te atendió, quién te atiende cuando estás enfermo?

M: Vos.

D: ¿Y si yo no estoy?

M: La abuela (materna)

D: Y si no, M.G (M.G. comienza a dibujar) (Le ofrece a M los lápices y papel; M los rechaza).

D: Creo que tienen una relación normal. Se patean de vez en cuando. (M.G se enoja por lo que dice la madre) Pero se quieren mucho y se miman. (M.G. dibuja un mástil y algo que veo como una escuela).

T: ¿Qué pasa en la escuela?

M: Nada, ella está separada de mí en la escuela.

T: Están todos separados, como el dibujo que me hiciste de tu familia?

D: Hoy no fue a la escuela (en relación a M) porque tuvo un ataque de mimos. Le dolía a la noche un ojo. Esta fue una semana muy corrida para él: el diagnóstico, ir a lo de la kinesióloga... Y a la noche me dice (en relación a M): Mamá, quedate conmigo. Pero yo estoy cansada. Esto sucede después de las 10 de la noche. Me llama

cuando yo ya estoy acostada, en camión. Y le digo: "¿a vos te parece que te atiende poco? ¿no? ¿Con quién estoy más? ¿Con vos o con Mariana? A vos te llevo a lo de la kinesióloga, psicóloga, médico; te llevo, te traigo". M se queja de la abuela (materna). Dice "esa mujer", tiene celos de M.G. "Esa mujer le lleva mucho el apunte". No sólo de cuidados, porque él le dice a veces "a esta chica hay que comprarle algo..."

E: Y no será que M empieza a alejarse de nosotros y por eso dice que no le damos nada... M.G se siente más circundada por los mimos. El se forma, se va hacia el mundo.

D: Yo siento que lo que él dice (en relación a M) no está relacionado con la realidad. A él le compramos dos pares de zapatos juntos.

E: Es curioso, que el más cuidado se siente más solo. M.G disfruta más de las cosas, es más lógica. Por ejemplo, hoy fuimos al colegio, porque M no fue. Ella estaba más comunicada conmigo, más juguetona.

D: Y le pasa que, por ejemplo, el sábado tuvo un programa bárbaro y a la noche se queja y empieza a hinchar. Terminamos enojados con él y todo termina mal, lo retamos.

T: ¿Como si buscara el castigo de ustedes? ¿Y a alguien más le pasa esto entre ustedes?

D: A él le pasa (dirigiéndose a E) Busca la mosca en la leche. Esta es una característica de E. El siempre busca...

E: Lo mío está asociado a la idea de pérdida o de muerte. Me sucede en vacaciones, que no puedo disfrutar y recién lo hago al final....

M: Mi forma de ser no es que me venga caído de repente. Tengo cosas de papá y cosas de mamá, soy una mezcla de concreto. Creo que los dos no se unen, que son paralelas.

D: El (a M) es un poco así, insaciable. Ahora es más grande y pareciera que... con la comida, siempre fue muy tragón. Hay momentos en que lo puedo manejar mejor. A veces cuando E se va de viaje él está aburrido y quiere comer. Yo controlo eso cerrando la cocina con llave, pero con la abuela... comen todo el día. M.G no es así, es más medida para comer. Antes comían, juntos y ella se copiaba de M y comía más, igual que lo de él.

M.G: Pero ahora no, porque quería enflacar, ya no más.

D: Pero ¿lo hacías ¿no?

T: (M.G dibuja rayas encima de los dibujitos) ¿Qué hacés, M.G?

M.G: El arco iris.

T: Parece que son los tres que tenés encima de tu cabeza: mamá, papá y M.

E: Yo... este... pienso que en relación a lo que dice con respecto a la abuela, proyecta cosas, que no me puede decir a mí... ¿que teme herirme...

M: No me gusta herir a la gente.

D: No te atrevas a decírmelo a mí. Decís "esa mujer", en vez de decírmelo a mí. Y, sí, con respecto a mis padres, mi papá es una personalidad neurótica, incapaz de hacer daño a nadie. Vive para él, es autista. Por ejemplo, dice que quiere llevar los chicos al parque y viene y enseguida quiere ir: "vamos al parque", no puede esperar. Una vez los llevó y M.G se cayó de un árbol y como se cayó le pegó. Y, además, les dijo que no dijeran nada.

M.G: Pero no hay que ocultar cosas y les conté.

D: Cuando vino, porque estaba con culpa le dije: "Estuviste muy mal, lo menos que podés hacer es hablar con ella, pedirle disculpas" (En ese momento M empieza a dibujar).

D: A ellos les cuesta compartir.

T: Casualmente usted dice esto cuando ellos están compartiendo.

E: Justamente, yo fui un hombre solitario, me crié solo.

D: Yo nunca me sentí sola, pero no deseé tener hermanos.

E: (Interrumpe) ahora me gustaría tener realmente hermanos.

D: Yo nunca pido prestado. Cuando fui becaña tenía amigas y me obligué a prestar; ahora me nace ofrecer. Fantaseo con prestarle todas mis cosas a Mariana, todo lo que tengo se lo voy a dar.

T: Menos a E.

M.G: Ella tenía un corpiño y un hombre la miró.

D: (se ríe) Sí, un día que tenía un vestido transparente y otro amigo me miró... Además ella quiere un...

M.G: Sí, tenés un corpiño con bombacha de encaje... Y un hombre te miraba.

T: Terminamos.

PRODUCCION GRAFICA



Dibujo de Mariana Gloria

* La gradación de colores del arco iris dibujado por M.G.es: negro, marrón, verde amarillo, azul y rojo. Los círculos son azules.

Dibujo de Mario



DISCUSION

Lic. Czertok: A partir de los datos que surgen de la entrevista

diagnóstica del grupo familiar y de los fragmentos históricos que se nos han brindado de esta familia, vamos a intentar ordenarlos evolutivamente destacando los datos importantes de que carecemos para hacer una ficha familiar diagnóstica completa.

Eduardo, de 29 años que vive solo con su madre, y hace cuatro años que murió su padre y no tiene hermanos; es presentado a Diana de 30 años, también hija única de una familia religiosa y de larga prosapia en la historia nacional. Se comprometieron el mismo día que se conocieron y pese a la oposición de ella, él decide hacerse conocer por la familia. Un año después se casan; no fué un casamiento religioso, según lo decidió Eduardo, que es ateo y así lo aceptó Diana.

Aquí nos podemos plantear cuáles fueron las motivaciones de esta unión, si fue una elección madura o la idealización de un encuentro que encubriría una apremiante urgencia por encontrar una salida exogámica, en ambos integrantes de la pareja. La empresa matrimonial se instala con una transacción que es importante tener en cuenta, pues de alguna manera va a influir a lo largo de su historia.

La familia de D no sólo pierde a la mujer, a la hija que tiene que cambiar de apellido sino también a la prosapia.

Se casan solamente por el civil, es decir, este matrimonio se inicia con una deuda del marido, que de alguna manera va a tener que pagar. Más que un matrimonio parece un rapto impulsivo de mutuo acuerdo.

¿Como se siente D? ¿mal casada? ¿no casada? Se inicia acá una guerra religiosa, como todas las guerras, una guerra por el poder. Esto pone de relieve la importancia del conocimiento del sistema religioso, que funciona en una estructura familiar, así como es importante conocer ahora si los niños son o no católicos profanos. Cuando reza D ¿reza sola o hace partícipes a los hijos?

Un año más tarde D se embaraza y nace un niño muerto que lleva el nombre del abuelo paterno. D habla de este hijo como de alguien ajeno a ella. Lo planificaron entre él y la madre de él, "Ella miraba desde afuera"; sin embargo, actualmente hablan de Alberto como de alguien que sigue vivo entre ellos. Lo que sí sigue vivo entre ellos es la muerte de algo referido a la predominancia paterna.

Alberto sigue vivo como un constante reproche para el padre y la abuela paterna.

Seis meses después, otro embarazo y nace Mario, que lleva el nombre de un tío de D, un general bonachón y muy atento con su propia mamá, y cinco años más tarde, Mariana Gloria, que lleva el nombre de la bisabuela materna. Con este sistema de denominaciones originado en su propia familia, parecería que D busca preservar a sus hijos y reconciliarse así con sus ancestros en varias generaciones, hasta su bisabuela.

Esto plantea la necesidad de conocer más detalladamente la historia familiar de D para saber por qué necesita remontarse hasta la bisabuela materna ¿en busca de qué? ¿cómo está constituido el ideal del yo de D?

Sabemos que cuando M tenía tres años, la abuela paterna fue internada en una clínica geriátrica, que a los cinco años y nueve meses empieza la escuela primaria, en un momento en que suponemos que la madre estaba embarazada de M.G. A los ocho años y estando en tercer grado, aparecen las primeras dificultades: M escribe juntando palabras y sin cerrar las letras; es llamativo que estas dificultades se evidenciaron en un momento que la lecto-escritura ya debería estar bien lograda, y más si se piensa lo que pueden representar estas dificultades para una madre directora de escuela; también somatiza enfermedades.

Viven en un departamento de tres ambientes a dos cuerdas de la familia materna. Cuando E viaja, la madre de M y M.G, reza. Los chicos corren a la heladera y comen sin parar, se ponen gordos, aburridos, insatisfechos; la madre no puede manejarlos y sólo atina a cerrar la cocina con llave. En todo grupo familiar se ponen en evidencia infinidad de observables; nos toca en cada momento describir las que son más claras en función de nuestros propósitos terapéuticos en cada momento de la terapia o del diagnóstico como en este caso.

Para ello, parafraseando a Freud, es necesario reconstruir la historia verdadera de la familia.

¿Cómo se han ido organizando para lograr esta modalidad de estar juntos que es lo que observamos en esta entrevista de diagnóstico familiar. Eligió para empezar los viajes de E. Me pregunto cuáles son las fantasías que acompañan las ausencias del padre,

por que si bien las ausencias reiteradas perturban siempre el equilibrio de un grupo familiar, aquí esta situación es planteada con un matiz acentuadamente dramático, este es un papá que parece que se va a la guerra, no a trabajar. ¿Esto es algo que E induce? ¿Es un problema de D cuando se siente sola? ¿Qué es lo que no toleran los hijos? La ausencia del padre o la angustia de la madre?

Confrontemos esto con la entrevista. E en la entrevista parece no ser muy tenido en cuenta por nadie. Todo esto sería necesario indagarlo más; en la comprensión de esta situación está la clave que nos va a permitir saber por qué están como dice M "*juntos como dos paralelas*" "*que ni se unen, ni se separan*". Por ahora para mí es un enigma, voy a tratar de despejarlo; creo que no es suficiente el único diálogo de la pareja donde D dice que "*él busca la mosca en la leche*", "*él busca*" lo describe como un hombre insatisfecho, que busca no sabemos qué. E se describe a sí mismo como alguien que no puede gozar, "*goza al final*". No sabemos si es así porque sólo puede gozar poquito, o porque hay un lugar recóndito, secreto, donde él goza a solas, en sus ensoñaciones o en soledad o en otra compañía como pareciera que también ocurre con D, quien por su parte se describe como alguien que se priva hasta del descanso, para servir, complacer, guardiana del orden, de la salud, de la heladera; le reprocha a su hijo que no sea suficientemente agradecido. El debe ser el general gordo y bonachón que le hace regalos a la madre. Con respecto a la hija, el deseo de darle todo lo que tiene, está expresando un deseo de reencarnación donde satisfacer proyectos no realizados.

El tiene 43 años, ella 44, están en la crisis de la llamada edad media de la vida, con una hija de seis años que comienza la escuela primaria y un hijo de 11 años que entra en la pubertad, momentos claves en la elaboración de la identidad sexual. El motivo de consulta manifiesto, son los problemas de aprendizaje de M, y podríamos situar como motivo latente de consulta una crisis en este momento especial evolutivo de la historia de este grupo familiar.

Dr. Bebchuk: Yo voy a tomar un aspecto parcial. Pero a mí me resulta de importancia en el asunto lo que podríamos llamar diagnóstico versus terapia, o sea la entrevista diagnóstica y la entrevista terapéutica, hasta qué punto se pueden separar y hasta qué punto

son inseparables. Según Salvador Minuchin, en terapia familiar, el diagnóstico es la hipótesis de trabajo que el terapeuta desarrolla a partir de sus experiencias y observaciones relacionadas en su proceso de unión con la familia, o sea que el terapeuta trata de unirse al universo de la familia. Minuchin dice que: "*trata de fusionarse con la familia*". Por ejemplo, dice "*un terapeuta en ese proceso de unión, puede sentir el dolor de un hijo excluido*" o sea de lo que se trata en este proceso de unión, es de vibrar con las mismas emociones —digámosle así, y con los avatares de la familia que uno trata y el proceso de unión y de diagnóstico van juntos. Un objetivo del proceso de diagnóstico consiste en ampliar la conceptualización del problema que la familia trae, generalmente un problema centrado en un individuo que es el paciente identificado, o sea que la familia ha conceptualizado y encarado el problema de una manera tal, que en el diagnóstico debe ser ampliado para incluir las transacciones de la familia en su texto habitual. Si éstas pueden ser premisas del diagnóstico en la terapia familiar, yo me pregunto qué sentido puede tener la separación de entrevista diagnóstica y entrevista terapéutica.

Para Haley, el principiante tiende a centrar su interés en la valoración del problema familiar y en el diagnóstico, mucho más que en reunir información con vistas a la intervención que hará en cuanto pueda.

Por lo general tiende a manejar ideas sobre el diagnóstico en un lenguaje individual y prefiere definir la dinámica familiar con el mayor detalle posible. Por el contrario, el terapeuta experimentado, desea intervenir con la mayor rapidez posible para aprovechar la ocasión de producir un cambio. En cuanto comienza a comprender el problema, busca ya la forma de intervenir. En síntesis tiende a trabajar con un mínimo de información.

¿Cómo es el contexto del tratamiento? Hay diferentes familias en diferentes contextos. El terapeuta al contribuir a formar el contexto, es lógico que se incluya a sí mismo en la descripción de la familia, tal terapeuta supone que la forma de comportarse de la familia está influenciada por la forma en que él la trata y por lo tanto se incluye a sí mismo en la unidad de diagnóstico.

La evaluación de una familia consiste en saber cómo la familia responde a las intervenciones terapéuticas, o sea, que el diagnósti-

co concreto y completo sólo puede ocurrir como resultado de la acción terapéutica. Otra importante cuestión diagnóstica, reside en saber qué clase de situación está provocando la conducta sintomática. Finalmente, para el enfoque interaccional, el diagnóstico tiene que definir problemas solubles, que sean factibles de solución en términos operativos.

No sé si me adelanto, pero para mí, un problema macroscópico de esta familia es el problema de los límites generacionales, es decir, que en esta familia no hay una buena frontera entre la generación de los padres y la generación de los hijos y a su vez entre las cosas que son de los abuelos en relación a los padres de estos chicos.

Dr. Gurman: Una de las cosas que yo me planteo es la siguiente: Los padres de este chico, vienen a consultar por el chico, vienen a buscar tratamiento para el chico, no vienen a reunirse en familia, la reunión familiar es algo que sugiere el terapeuta —que puede aceptar o no este grupo familiar, aunque en este caso han aceptado puesto que tenemos este material.

Desde el punto de vista del material que a mí se me ha ofrecido, una de las cosas que me importa es el motivo de la consulta, y de acuerdo a mi experiencia, la terapia familiar sigue siendo una sugerencia del terapeuta más que algo buscado por quien viene a la consulta.

Este motivo de consulta plantea una discrepancia, entre lo que los padres ven —no sé si los dos o uno solo de ellos— y lo que anuncian que le dicen los terapeutas a los que ellos van a consultar.

Ustedes escucharon; hay dos psicodiagnósticos previos, dos terapeutas que decían “al chico no le pasa nada”, y lo que dice el maestro de este chico, “que tiene inhibiciones” y algo que agregan, a posteriori, “que este chico tiene somatizaciones”, no sabemos que son estas somatizaciones.

Los padres dicen que las dificultades empezaron en el tercer grado ¿y por qué? . Desde los padres, la respuesta que dan es que juntaba palabras y hacía cortes más allá del contenido y de la forma; están hablando de *uniones y separaciones* fuera de lugar, pero ¿por qué con respecto a Mario? ¿por qué él? El hijo está implicado en las uniones y separaciones de esta pareja y yo me vuelvo a preguntar, pero ¿por qué Mario?

Esta gente tiene la teoría de que “*las dificultades se deben a la maestra que era un desastre*”, y entonces lo cambiaron de colegio. ¿De qué modo enfocan lo que sería un problema mental?: a través de una modificación de persona y de lugar, es decir, se le cambia la maestra y se le cambia el colegio. Luego confirman que, cuando Eduardo viajó, Mario se quiso tirar del balcón.

Quiere decirse que traen este dato y después lo olvidan y digo yo ¿era un chiste que dijo el chico o una verdad?

El niño expresa a su modo y es el portavoz que anuncia las consecuencias de la separación, que tiene dos vertientes, sea hacia el mundo exterior o hacia ese otro exterior que es el propio cuerpo del chico.

De los datos familiares relevantes, podemos destacar que la madre se ocupa de niños muy perturbados en lo que hace al aprendizaje de los mismos, es decir, que el problema del aprendizaje es algo que a la madre le preocupa desde antes de nacer su hijo, ya que es su profesión.

Del padre sólo sabemos que es comerciante y que viaja por razones de su trabajo.

La fórmula que podemos destacar es: el padre se ausenta, la madre queda en conexión con los niños perturbados en el aprendizaje, luego: *separación es igual a dificultades de aprendizaje*, problemas del niño.

Luego nos enteramos que la madre en virtud de sus influencias, consigue que admitan al chico en el colegio, transgrediendo una situación oficial, una organización oficial es transgredida, lo que no se puede, y sin embargo, ella lo consigue. Y volviendo al comienzo de la pareja, que es lo imposible que ella quiso hacer posible a través del casamiento. Lo interesante es que con M.G no pasa lo mismo; se trata de dos historias, se trata de dos ciclos que pertenecen a momentos históricos diferentes. En la historia de la pareja, él se queja de que ella le ocultaba cosas, la familia, hasta que él consigue saberlo “metiéndose de prepo”. Ella hace cosas como rezar cuando él está de viaje, para así quedar bien con Dios y con el diablo. Eduardo dice que él no cree en lo que ella dice creer; él tiene dificultad para creer, es ateo. Por otro lado, algo que nace muere prematuramente, que es Alberto, y se lo trata de mantener

vivo, pero ¿qué es lo que se trata de mantener vivo?

En la sesión de grupo familiar, el único que habla de tener problemas con la muerte es el padre, es decir, quién trata de mantenerlo vivo. Diana dice que este niño era de E y de la madre de E; ella no tuvo nada que ver, ella no perdió nada. Luego viene el embarazo de M; él pierde, ella recupera. Mario y M.G tienen que ver con la familia de ella.

Luego sabemos de los abuelos paternos; el abuelo murió y la abuela Damiana está internada en una clínica geriátrica por obra de D. Podríamos decir que parecen la familia de los Césares.

La vivienda está ubicada cerca de la familia materna, a tres cuartos. En la sesión, se sientan los padres y creo que los hijos en el medio.

Comienza la sesión y MG dice: *sólo papá y mamá saben de qué hablar*"; D le dice que ella tiene que hablar, por ejemplo, de sus relaciones con el hermano. Parece un diálogo loco y MG dice que a ella le da vergüenza. Yo hago como hacía Freud con los sueños, proyecto la película al revés.

M.G dice que la mamá se muestra en bombacha y corpiño y a ella le da vergüenza hablar de esa situación. Luego se habla que el problema es una relación fraterna, donde hay un despojo: *"vos eras dueño de todo cuando ella nació"*, *"ella, M.G tuvo que hacerse un lugar en la familia"*, es decir, ella, Diana ¿está hablando de M.G a M o está hablando de aquella situación que la llevó a casarse?, ¿tal vez para continuar la progenie, la estirpe, el linaje de familia?

Hay, por otra parte, una contradicción; primero M.G pega patadas a M; luego lo mimó y lo trata bien, contradicción que se debe a que se establece un par de opuestos, los mimados y los que miman, y cuando esta oposición se establece, el padre aborda las diferencias y dice: *"todos nos mimamos de la misma manera"*. La madre parece vivir fuera del tiempo en un tiempo de historia gloriosa, es posible que se haya casado para perpetuar esta historia y para buscar un nombre.

Lic. Czertok: Creo que justamente en el momento en que la madre describe una escena en que Mario acaricia a la hermana y ésta lo patea, aparece la confusión y la indiscriminación de la madre.

Esto que parece un diálogo loco, es reiterativo a lo largo de toda esta sesión.

Pero yo quiero remarcar el contenido de doble mensaje que tiene esta situación: *"ella le pateaba la cabeza cuando él la acariciaba"*; se refiere probablemente a un sentimiento de que las caricias patean la cabeza y dificultan pensar; la madre le dice: *"ella te pateaba la cabeza cuando vos la acariciabas"*; *"ella es muy celosa, vos fuiste dueño de todo, ella te mimó, te trata bien, te lleva el postre, está mal que no te acuerdes"*. No sabemos qué es lo que ella quiere que el chico recuerde, si aquellas épocas felices en que él era dueño de todos los mimos actuales de la hermanita. Esto configuraría parte de un doble mensaje. El chico no sabe si tiene que querer o no a su hermanita, si la hermanita lo quiere o si igual que él, tiene que obedecer el mandato de la madre, si es amor o amenaza. Pero igual tienen que querer.

Un esquizofrénico —no olvidemos que D es maestra de chicos psicóticos—, entendería que su problema es éste justamente, el tener que querer en estas condiciones.

Si vamos a analizar las contradicciones flagrantes que hay en todo este relato, bueno, son inagotables; pero yo creo que los mimos están en esta primera parte de la sesión dramatizando el conflicto parental.

En realidad es D quien no puede dar bien amor a su marido. No está autorizada, pienso, a dar amor exogámico. Así induce a su hija M.G a una rebeldía que ella no pudo realizar con su propio padre. M.G se rebela contra el abuelo Marco Aurelio y lo denuncia cuando en el parque —*este señor que es incapaz de hacerle daño a nadie*—, le pega al caerse de un árbol. Podríamos suponer, también, que cuando M dice *"que se tiraría por el balcón"*, quizás esté hablando de los sentimientos de ella, que en el momento en que su marido se ausenta, ella se tira por el balcón, y reza. Habría que discriminar hasta qué punto este rezo es una defensa obsesiva, y yo creo que un punto de abordaje terapéutico sería trabajar con la pareja sobre esta prohibición exogámica.

Yo dejando de lado la comprensión del material que me parece que es bastante claro, lo que preferiría es hacer una serie de observaciones acerca de lo que sería el abordaje terapéutico.

Dr. Bebchuk: Traje preparadas algunas ideas acerca de una primera entrevista, pues, en realidad ésta no lo es puesto que antes hubo cuatro entrevistas con los padres y una con M. De manera que ya había un conocimiento previo, faltaba M.G en una primera entrevista.

J. Haley, describe cuatro partes o etapas, en una primera parte se llama la etapa social, que es el momento de los saludos y de acomodar a la familia; cuando la familia entra al consultorio, se pueden observar una gran cantidad de detalles: como entran, de qué hablan, como se mueven, como reaccionan los padres; si los ven a los hijos entrar de una manera o de otra, y de ahí ya se pueden ir obteniendo una serie de datos que el terapeuta guarda para sí; una vez que la familia está acomodada, se han presentado, viene lo que Matey llama la etapa del problema, es decir, pide que todos los problemas en la familia.

Ello se puede abordar de distintas maneras; acá, en esta sesión, la consigna inicial, dice: *"estamos reunidos para poder hablar de las dificultades de M y poder escucharlos a los cuatro juntos"*. No me parece una consigna muy acertada puesto que da por sentado que M es realmente el problema y que solamente la familia lo define así, sino que él o la terapeuta, acepta esta definición, tal vez existirían otras formas de poder iniciar una sesión de familia, por ejemplo, una forma podría ser en este caso: *"Yo los he visto con anterioridad; estuve hablando con varios de ustedes, pero pedí que venga toda la familia para escuchar las ideas de todos, acerca del problema"*, y otra posibilidad sería *"yo quise que toda la familia viniera hoy para poder tener todas las opiniones acerca de la situación"*.

Si el terapeuta pregunta *"¿cuál es el problema?"*, por lo general tendrá la respuesta de la autoridad en el problema, típicamente, la madre, quien ya se anticipa a esta pregunta y tiene preparado un enunciado, con las dificultades del chico, es decir, que esta pregunta encaja con las expectativas de la madre. Habría otra posibilidad, que el terapeuta preguntara *"¿qué es lo que desean de mí?"*. Esta pregunta torna la situación mucho más personal, y reduce la posibilidad de informar que trae la familia, también puede preguntar, *"¿qué cambios desean ustedes?"*, de esta manera enmarca la situación terapéutica en una situación de cambio, al responder los

co antes que en términos de lo que anda mal en él. Y otra forma de preguntar, sería: *"¿Por qué están ustedes aquí?"*. Esta forma de enunciarla da a la familia la oportunidad de enfocar el problema, o el cambio.

Tenemos que, en resumen, la pregunta del terapeuta puede ser general y ambigua; en este caso, los miembros de la familia tendrán un espacio mayor, para desplegar sus puntos de vista, o por el contrario, si la pregunta es específica, la situación va a quedar más enmarcada en un área de discusión, de la que la familia no va a poder salirse con facilidad. Estamos hablando acerca de la etapa del problema que es la segunda de las que Haley describe.

Entonces, en esa circunstancia, se pide el aporte de todos acerca de qué es lo que ven como problema en la familia, y se trata de que se siga un orden para que realmente todos den sus opiniones. Una vez que se ha terminado esta etapa, se pasa a lo que se llama la etapa de interacción, promoviendo que los elementos de desacuerdo que pudieron haber aparecido por las diferentes opiniones de cuál es el problema, se dé lugar a una interacción entre los miembros de la familia en cuyo caso el terapeuta se retira, deja de tener un papel más directivo en cuanto a que hablen y después otro, y deja que la interacción se dé más espontáneamente, pero tratando de que no se produzcan bloqueos en la comunicación en el sentido de que se arme una discusión entre dos, y no salgan de eso. Cuando ocurre algo así, hace intervenir a un tercero para que interaccione en la discusión acerca de cuál es el problema y ésta tenga fluidez y dinámica.

Digamos que el objetivo de esta etapa sería que todos interactúen con todos en el curso de la primera entrevista; digamos que hiciera que, en una grabación se vea como habla la madre con el hijo, la madre con la hija, la madre con el marido, y así cada uno con todos los demás y habría una etapa final, terminación de la entrevista que sería la etapa de la fijación de las metas: qué quiere la familia con la terapia. Estas son las ideas de Haley acerca del matrimonio.

Dr. Gurman: Yo quisiera decir cuál es para mí el problema de esta familia. A mi parecer, el problema lo trae muy claramente M.G que dice: *"hay que decir la verdad"*, *"no hay que ocultar"*.

En mi experiencia, en general, el 80 ó 90 por ciento de chicos traídos a la consulta por cualquier tipo de sintomatología, corresponden a desórdenes de problemática familiar.

Lo interesante es que, a nivel de la terapia, todavía seguimos con las concepciones de la filosofía antigua, que se tenían acerca de la teoría del peso; en ese sentido la familia ve el peso como noción, exactamente como los antiguos veían los objetos que caen. Si yo suelto este objeto, cae, el peso es la propiedad inherente de este objeto, es una cualidad propia del objeto. Llevó bastante tiempo hasta que Galileo enunció que el peso era una relación entre cuerpos que estaba en proporción a su masa; pero se asustó porque eso no era objetivable. Pensó que eso ¿dónde se observaba? ¿dónde se corporizaba? ¿dónde se materializaba esa fuerza? ¿a qué materia pertenecía? . Aterrado por una especie de concepción mística, dejó las cosas ahí.

Yo digo que esta familia trae una propiedad inherente de este chico, *"a este chico le pasa tal cosa"*.

Yo no sé cómo se puede citar a toda la familia a una entrevista; algunas veces lo hice, no es fácil y menos con gente tan sofisticada como la del caso. Si la gente tiene un poco de sofisticación intelectual, ya no es tan fácil. Hubo gente que me ha llamado y me ha dicho: *"Gurman, yo quiero que mi hija se atienda contigo"*, o me ha llamado el chico: *"yo tengo permiso de mi papá para analizar-me"*.

Es decir, que llegar a que la idea de peso es una relación, lleva bastante tiempo.

Respecto del problema de cómo dejar hablar en la sesión, yo pienso que lo que aparece como caos manifiesto, corresponde generalmente a un orden latente; yo creo que éste fue el gran descubrimiento de Freud; el descubrimiento de Freud es hablar de un orden del inconsciente.

Dicho orden no corresponde a ningún orden de la materia, es un espacio virtual teórico, que tiene una legalidad propia, legalidad que permite a través de conocer sus leyes, inferir cuáles son los derivados de lo inconsciente.

En tal sentido yo pienso que uno puede crear este espacio virtual teórico, para entender los fenómenos de una familia, es decir, en este sentido yo marcaría una diferencia en cuanto a la técnica del

grupo familiar, de no organizar, de no señalar quién hable, sino dejar que la cosa se vaya planteando en la medida que yo pienso que hay un orden que subyace y que en algún momento esto aparece como caos, y en su despliegue va a mostrar a qué orden obedece. Yo pienso que el orden al que obedece esta consulta es el orden de la ruptura de un ideal.

En general, la consulta viene y lo hace a través del chico, como decía Freud: **el chico es el heredero del bien, y es a través de él que los ideales se muestran o se muestran los fracasos de los ideales.** De lo que se trata es de un secreto, de un secreto relacionado con la ropa interior; es un secreto de la intimidad; es un secreto de la noche, es el chico que se despierta a la noche y ella va en camison. Uno tendría que preguntarse ¿es extraño que una mamá vaya en camison a ver a un chico de 10 años? ¿es extraño que un chico de 10 años se despierte a la noche y necesite ser consolado por la mamá? Y a su vez el papá dice: *"está grande"*, *"se nos va"*, *"él se está separando"*.

Es decir, ¿cuál es el secreto, este secreto de la noche, secreto visto por la chica, secreto que M sabe pero oculta y dice *"si papá se va, yo me suicido"*, pero ¿por qué? ¿por lealtad a quién? ¿él debe el silencio? . Es por eso que él funciona en dos paralelas, que es lo que le sucede a un chico que ha visualizado y ha visto las transgresiones y los adulterios de su madre. Yo quisiera que se pusieran por un momento en el pellejo de un chico de 10 años y una nena de seis que ven a su madre mirar a otro hombre y ven las miradas de otro hombre fijadas en la intimidad de su madre. Acá quedan dos cosas: o uno se vuelve tonto, se suicida, o uno, cuando vuelve papá del viaje ¿va y le cuenta o no?

Ahora, el problema por otro lado es cómo uno aborda técnicamente esto. Yo pienso, por ejemplo, que técnicamente, yo me manejo en entrevistas familiares básicamente con preguntas; por ejemplo, yo le hubiera preguntado a M.G por qué ella piensa que "papá y mamá saben"; ¿qué es lo que saben? , es decir, ¿a qué se está refiriendo ella? , o por ejemplo, me gustaría haber marcado la contradicción entre ella, que se levanta en camison a la noche a ver a este nene de 10 años, y él, E, que dice que *"este nene se está yendo"*. ¿Cómo es que pueden existir este par de opuestos?

Por otro lado, hay un escenario que ha estado detrás de esta fa-

milia que es la cama, cama donde se come ¿por qué se come en la cama? o los mimos tienen que ver con la comida, y M.G lleva la comida, y trae la comida y sirve la comida y los mimos a través de la comida y por otro lado, si ustedes miran los dibujos de M.G van a ver que es un gran cortinado de arco iris, donde uno piensa ¿y si se descubre el telón, qué pasa? van a ver que M.G dibuja como en las historietas, ovalitos, y a uno le dan ganas de preguntar a M.G ¿qué diálogos pondrías vos allí? ¿qué escribirías más allá de las iniciales? . Igualmente, M dibuja esos ovalitos y los llena de colores, y uno piensa ¿cuál es el relleno de esto? ¿qué es lo no dicho, qué es lo no hablado?

Lic. Czertok: A través de los dibujos, tenemos acceso a las representaciones imaginativas del niño, de su afectividad, de su madurez, de sus símbolos. A mí me resulta difícil hacer una interpretación directa de los dibujos. Me importa entenderlos en el contexto de la situación afectiva del niño, en el momento que los realiza y especialmente todo lo que podemos hablar con ellos acerca de los mismos.

Respecto al dibujo de M.G, lo que plantea es una incógnita que a mí me llevó bastante tiempo despejar: los nombres de ella y su hermano separados en letras y encerrados en pequeños círculos desordenados. Además, hay otro mensaje: aquí hay algo que te va a dar mucho trabajo descifrar. Lo mismo pasó con otro dibujo, el de Mario; es un dibujo sugerente, con un primer plano de formas indefinidas, aglutinadas, que parece que quieren mostrar y al mismo tiempo cubrir, tapar algo que está debajo o pueda emerger desde atrás.

Me gustaría saber si ustedes comparten esta impresión mirando el dibujo. Por un lado hay una actitud de denuncia, de revelar secretos en toda la conducta de M.G, y, al mismo tiempo, una actitud de cuidado y control, constante y llamativa en toda la entrevista. Cuando el padre comienza a hablar de lo mal que él se siente, sale Mario y dice: *"yo estoy así desde hace mucho tiempo, parado en el medio, haciendo que estas dos paralelas estén juntas, que ni se toquen ni se separen"*.

Y eso que dice también "es lo que hace todo el tiempo, un estar cuidando", que se reparten entre los dos hermanos durante toda la sesión.

Cuando nuevamente se habla de un tema que puede ser conflictivo, Mariana empieza a dibujar sus rayitas; luego, cuando la madre afirma que hay que decir las verdades y M.G acota que ella también cuenta todas las cosas, Mario se pone a dibujar ¿Y para qué dibuja en este preciso momento? Creo que para distraer la atención de la terapeuta, para que no intervenga y les haga preguntas.

Los chicos perciben de inmediato el interés que despiertan en todo terapeuta sus producciones: acciones, juegos, dibujos. Estos dos chicos están revelando por un lado y tapando por otro. Cuidando para evitar que pase algo que pudiera ser catastrófico. ¿Es por el temor de que los padres se separen y se desequilibre el inestable equilibrio emocional de sus padres, o es con el fin de conservar este funcionamiento familiar perverso que complace deseos narcisistas y edípicos?

También tenemos que considerar que esta es una entrevista caracterizada porque hubo ya anteriormente cuatro entrevistas con los padres, de las que los chicos ignoran seguramente todo lo que se ha hablado y tres entrevistas individuales de Mario con la terapeuta. Para M.G es el primer encuentro con la terapeuta y parece estar bajo el influjo del temor de que se le haga alguna acusación muy grave. Podríamos preguntarnos si esta rutina en el proceso de psicodiagnóstico que deja para el final la entrevista de **grupo familiar diagnóstico (EGFD)**, en la que se incluye el resto de la familia, básicamente los hermanos, si no influye generando un clima especial por los **distintos tiempos terapéuticos** de los miembros y sistemas involucrados en este momento familiar que estamos analizando. Nos preguntamos cuáles son las consecuencias de esta modalidad operativa; se impondría evaluarlas confrontando con la **entrevista de grupo familiar diagnóstico**, para establecer qué datos se ponen de manifiesto en cada ocasión, así como los efectos modificadores que pueden tener, sobre todo el proceso de psicodiagnóstico.

Una de las consecuencias que he observado en mi experiencia como terapeuta de niños, es que los sistemas que se incorporan en último término, básicamente, los hermanos son los **voceros de la transferencia**.

Vienen a denunciarnos el clima que el terapeuta ha creado en el seno del grupo familiar, y nos hablan de cómo se sienten todos y

de que hablan y se comunican entre ellos, mucho más allá de lo que se ha dicho, si la terapeuta ha inspirado confianza o miedo, seguridad o persecución, si ha creado tensión frente a la vigencia de viejos sistemas defensivos familiares que puedan ser amenazados, sin contribuir simultáneamente a un clima de comprensión terapéutica.

Así, hemos visto muchas veces ante la sorpresa de los padres, acercarse con un dibujo o hablar con espontaneidad a chicos que me habían descrito como tímidos, y he visto otros que en el hogar son muy comunicativos, quedarse inmovilizados, agazapados detrás de la silla o en el regazo de los padres; por eso me sorprendió la intervención de M.G, que pienso que es como un vocero de una buena relación transferencial que este grupo ha establecido con la terapeuta, pero tampoco tengo que dejar de ver que esto viene en medio de un clima muy paranoide de defensas y acusaciones, de alegatos, y que hay un pedido concreto de Mario. El pedido concreto que Mario le hace llegar a la terapeuta es que *cuide a sus padres*: *"Yo me cuido de no herir a nadie, por favor"* le está diciendo a la terapeuta, *"no los hiera y no arruine el trabajo que he venido haciendo desde hace tanto tiempo, manteniéndolos juntos, sin que se separen"*.

Yo creo que esto es algo que hay que evaluar muy finamente en términos del abordaje terapéutico que vamos a proponer y en la dosificación de la información que vamos a dar a los padres y a los niños. Ahí está un poco de la habilidad del terapeuta de niños, que tiene que tratar de encontrar el abordaje terapéutico adecuado para que esta familia no se vaya, no huya asustada y entonces condenemos al chico a una serie interminable de manoseos terapéuticos.

Es muy importante prever y comprender estas reacciones que pueden evitarse si uno se ocupa de la familia y posibilita que los padres evolucionen paralelamente con el niño. Trabajar con la familia no es simplemente una modificación de la técnica. Todo terapeuta de niños, cuando inicia un tratamiento individual, por ser esto lo más indicado o por que es la única alternativa posible, debe saber que queda incluido, quiéralo o no, en el sistema de los vínculos familiares.

Además, quiéralo o no, cumplirá una función educativa en el seno de ese grupo familiar.

Dr. Bebchuk: Los terapeutas que tenemos una orientación interaccional, tenemos fama de ser directivos. Es verdad: somos *más directivos*. En esta primer entrevista con la familia, por ejemplo, un terapeuta interaccional, después de preguntar qué piensan los hijos de los padres y sentir que la primera que responde es la madre, intervendría de alguna manera para enfatizar o invitar a alguno de los hijos a que recoja la pregunta. En algún momento de la entrevista, o más adelante, un terapeuta interaccional, si ve como yo veo que el punto por donde se puede empezar a efectuar la terapia es estableciendo una clara delimitación entre las generaciones, pondría a la madre y al padre sentados uno al lado del otro y a ambos hijos también, a su vez, sentados uno al lado del otro, sin decir demasiadas cosas, simplemente ubicándolos, haciendo una redistribución del espacio y diciendo sin palabras: *"este es el orden que debiera existir entre ustedes"*.

Y, así, con medidas de este tipo, trataría de ir formando esa frontera que existe en una familia de características normales, es decir, que hay algo que es el mundo de los hijos: se intercambian cosas, se piden favores, se sacan, se pelean, se vuelven a amigar y los padres a veces intervienen y muchas veces no intervienen. Más bien con el tiempo, los padres se dan cuenta que cuanto menos intervienen entre los chicos, ellos encuentran una forma de ordenarse, de equilibrarse y que al contrario, cuando las interferencias son más numerosas, los conflictos son más numerosos y no se sabe bien qué es lo que mantiene ese ritmo continuo de peleas, si el hecho de que alguno del sistema de los padres interfiere en el mundo de los chicos o el mundo de los chicos que llama al mundo de los padres a interferir, ¿por qué?

Como la interacción es circular, eso es algo que no se puede establecer: qué es lo primero y qué es lo que sigue después. Y aquí, en este tipo de cosas, abundan situaciones en las que la madre o el padre intervienen en cosas que son únicamente de los hijos y que con una simple medida continuada a lo largo de un tiempo de decirles: *"dejen que lo arreglen entre ellos"*, sea si Mario está en deuda con M.G o no, si ella lo mimó más o lo mimó menos. En fin, ellos pueden arreglar muy bien solos estas cuestiones.

La verdad es que ellos están cumpliendo una función en relación al conflicto que los padres tienen; y esa función que cumplen

ellos para de alguna manera tener unida a la pareja, está perturbando su propio desarrollo. Entonces debería establecerse una frontera generacional a lo largo del tiempo, delimitando el mundo de los hijos y el mundo de los padres, para que tengan una separación y al mismo tiempo una permeabilidad.

Pero en este caso, creo que lo que más necesitan es la separación que la permeabilidad. Es decir, los hijos están al tanto de muchos datos que, en una familia sana, los hijos no tienen acceso y menos a aspectos de la vida conyugal que los chicos de este caso sí tienen, y es eso, efectivamente, lo que les perturba.

Y una vez deslindados el mundo de los padres y el mundo de los hijos, sin apuros, y con medidas relativamente simples, sí se podría abordar —si los padres aceptan—, cuáles serían los desacuerdos, cuáles son los desentendimientos, cuáles son los duelos no realizados, en fin, todas las hipótesis que acá se vertieron y muchas que, luego con seguridad, después se confirman.

Pero una cuestión clave sería, por ejemplo, a los fines de la terapia, cómo unir inicialmente a estos padres para que, a partir de ellos mismos, sean los promotores de la frontera generacional dentro de la familia.

Vale decir, que si los chicos van a estar bien, si va a haber un mundo de los hijos separado de los padres, que los padres vean que es obra de ellos con la ayuda del terapeuta; que ellos tienen un mérito, que ellos tienen logros y sobre la base de ese logro y de lo que significa ese esfuerzo de la alianza terapéutica en caso de que se vaya produciendo y los padres vean que tienen una capacidad directiva sobre los hijos, que tienen una capacidad educadora que puede dar resultados, tal vez en esa circunstancia los padres puedan estar más dispuestos a abordar con la terapeuta sus dificultades del pasado, del presente y toda una serie de cosas que indudablemente están ocurriendo entre ellos y que son las que dan origen a las perturbaciones en los chicos.

Lic. Czertok: ¿Y si los padres no quieren?

Dr. Bebhuk: Eso es muy importante. Aquí no sabemos. Pero en la entrevista Haley, propone que haya una etapa de fijación de metas. Supongamos que se establece la frontera generacional y se re-

marca ese resultado de una forma tal, que a los hijos les resulte difícil por más que sean incitados, puesto que no es fácil resistir a esa incitación por parte de los padres a volver al rol anterior. Pero, supongamos que se establece esa frontera generacional; ahí habría que hacer un nuevo contrato y decirles: *"Bueno, el chico va mejorando, ¿ustedes se contentan con esto o quieren ir más allá?"*

Por razones de ética, obviamente, no podemos, pero tendríamos que decirles: *"Ustedes nos trajeron a sus hijos; ellos están progresando. Si ustedes quieren que continúen así, tal vez tendríamos que ver otras cosas, pero ustedes deben decidir."*

Lic. Czertok: Yo me preguntaba otra cosa; me refería a que, manifiestamente, ellos quieren que el chico supere sus dificultades, sus síntomas, pero lo que necesitan inconscientemente es que sigan funcionando de la misma manera —dentro del grupo familiar— y no tienen ningún interés en establecer estos límites generacionales.

Por un lado, el padre dice *"Bueno, no hay más remedio, Mario se va"* y por otro lado se organiza todo el movimiento envolvente, que esta sesión se está haciendo sobre la nena. ¿Cómo los dos la están cercando, compitiendo, inclusive, por la posesión de Mariana. que va a venir a ocupar dentro de poco tiempo el lugar que está ocupando Mario ahora? Pero yo no sé si ellos quieren modificar esto...

Dr. Bebhuk: Es un a priori decir que no, como es un a priori decir que sí. No sabemos. Por eso, justamente, a mi juicio en esta sesión falta una acción terapéutica que diagnostique eso y que ponga a prueba esa situación.

Lic. Czertok: Yo diría que casi está puesta a prueba, porque en el momento en que se establece un subsistema que es la relación de Mario con su terapeuta individual; *"Mario se va" dice el padre*, y hay todo un manejo seductor del padre con M.G y de la madre también, que se quiere como reencarnar en ella, y no sé cómo eso se va a poder modificar con directivas, esa sería mi duda. Es decir, que si alertados sobre tu propósito, no se van antes de que puedas actuar, como dije, esa sería mi duda.

Dr. Gurman: Yo lo que pensaba es —como si uno nunca pudiera salir de los viejos problemas de la psicoterapia, como si se replantearan en cada nuevo nivel lo mismo— Freud se planteaba, si no usaba la hipnosis o la sugestión porque no tenía capacidad hipnótica de sugestión; y a veces pienso si a uno, como psicoanalista, le piden que decida, entonces los deja hablar ya que les cuesta tomar decisiones, pero de todos modos, pienso que la discrepancia que marcaría con B, sería que esta familia necesita un orden, lo tienen, lo importante es cómo mostrarles este orden. A esto yo me refería cuando decía que hay que tener un espacio virtual teórico desde el cual uno pueda mostrar, por ejemplo, que se trata aquí de un problema de poderes, de quién mimar, quién es mimado, quién tiene, quién es despojado. Esta diferencia de poderes obedece a una situación de un orden que los establece de esta manera; no es necesario imponer un orden, sino que esta familia que está organizada así, tiene un orden.

Yo plantearía la diferencia entre suponer que uno tiene que marcar una frontera o hacer una operación, que es la de levantar aquellas situaciones que obstaculizan o dificultan, que esta familia observe a qué orden obedece. Yo pensaba que, ni bien la terapeuta da una consigna, por ejemplo, que los chicos hablen de los padres, la madre la trasgrede, la madre es la permanente trasgresión. Y entonces uno tendría que pelearse con la madre, y decirle en un momento dado: *"pero, señora, cállese la boca."*

Dr. Bebhuk: Muchos terapeutas lo hacen. Y muchos de los que lo hacen, tienen éxito.

Dr. Gurman: Yo me preguntaría qué quiere decir éxito. Yo pensaba que una cosa es el abordaje técnico y otra cosa es pensar que eso es lo que cura; es decir, yo puedo hacer un abordaje técnico así, más sutilmente, más groseramente, depende de las modalidades personales, pero el problema de esta gente —digamos— tiene una legalidad que le es propia, no es que yo vaya a imponer un orden.

Dr. Bebhuk: Yo diría que la familia nuclear moderna está constituida por dos generaciones: padres e hijos, y la tarea socializadora de la familia requiere una consistente autoridad bipersonal, pa-

dres que trabajen en equipo, una parte importante del trabajo en equipo, gira alrededor del mantenimiento de los límites entre una generación y la otra. Por lo general se observa, que si uno de los padres tiene una vinculación disfuncional con su propia familia de origen, esto puede traer una violación de las fronteras generacionales en el otro extremo de la familia. La dificultad o la imposibilidad de mantener vigente una frontera entre personas de diferentes generaciones, se traduce en el hecho de que los hijos tienen acceso a la vida conyugal de los padres. Esto comporta dos consecuencias: el hijo desempeña una función determinada en la relación entre los padres, y segundo que dicha función perturba y trava el desarrollo infantil. En una pareja conflictiva, las demandas relacionales insatisfechas tienden a desplazarse hacia los hijos, y estos son inducidos a satisfacerlas.

Dada dicha situación, queda infringida la frontera generacional y resentida y desvirtuada la autoridad de los padres. En un sistema familiar funcional, la díada de los padres permite el acceso de los hijos a ambos, pero los excluye simultáneamente de las relaciones conyugales. Es como si los padres definieran las relaciones con los hijos de esta manera: *"así es como los vemos, necesitamos de nosotros y nosotros dispuestos a proveerlos"*. Las necesidades que los hijos tienen de los padres, pueden ser de distinta índole: *afecto, juego, contacto corporal, límites*. Si la pareja parental requiere a los hijos para la satisfacción de necesidades conyugales, entonces los límites generacionales quedan imprecisos; la definición vigente en este caso es *"así es como los vemos"*, *"necesitamos que ustedes nos provean"*, pero en este caso Mario dice *"que no la va a herir, que no tiene capacidad de herir a la hermana"*.

Cual es la función de los límites generacionales, la función de los límites consiste en proteger la diferenciación del sistema, por ejemplo, cuando se forma una pareja nueva: el matrimonio debe sustituir determinadas disposiciones sociales que se abandonan para la formación de la nueva pareja, la creación de un nuevo sistema social significa la creación o consolidación de un límite alrededor de la pareja, la inversión en el matrimonio se obtiene a expensas de otras relaciones; el grado de inversión en el matrimonio puede depender de cuanto ha sido lo que se abandonó.

Si un sistema o un subsistema tiene límites claros, se preserva

de la interferencia de otros subsistemas; los límites del subsistema conyugal deben funcionar para proteger a la pareja de la intrusión por parte de los niños u otros miembros adultos de la familia extensa.

También el subsistema fraterno necesita una frontera protectora a los fines de que dentro del mismo, puedan desenvolverse las funciones específicas relacionadas con la cooperación, la competencia, la derrota, o sea, aprendizajes imprescindibles para las relaciones con pares, en este caso lo que vemos es que cada uno de los miembros de esta pareja no pudo hacer la ruptura con su familia de origen y no pudo invertir en la constitución de su propia pareja lo suficiente como para satisfacer dentro de ella las necesidades relacionales. Esto trae aparejado el hecho de que a su vez, esa falta de delimitación con lo que podríamos llamar el extremo superior, lleva a una falta de delimitación, a una falta de claridad en la frontera en el extremo inferior.

Dr. Gurman: Pareciera ser que por tradición, por gloria de la historia, se necesita tener una familia, un nombre e hijos; sin embargo, aquí está claro, este ideal es trasgredido; lo denuncia la hija.

Es decir, que esta familia no pasará a la historia si M.G es la que hace la historia, porque hay historias hechas por distintos historiadores, pues está la historia oficial y la no oficial. Freud decía que la historia oficial del neurótico era la del YO oficial frente a la cual se ponía el retorno de lo reprimido. Aquí tenemos la voz de lo reprimido en la voz de M.G que habla de pronto como si se le destapara la boca y surgiera una especie de vómito, porque, tanto es así que sobre el final, uno se preguntaría ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho al principio lo que dijo al final?

Pero por algo lo dijeron al final, cayó el telón, arco iris se enciende y aparece restituido el arco iris de colores, es decir, el ideal narcisísticamente sostenido por la familia, que es aquel sostenido por ellos mismos ante los demás como historia oficial.

Pero si toda familia pone una historia oficial para sus miembros, glorificada, magnificada, embellecida, enaltecida, hasta que un suceso rompe con ésta, entonces se signa al culpable y se lo señala como alguien que no respeta esa historia.

Esta familia viene porque la historia es respetada, todos son mimados, se tienen que mimar, todos son buena gente, todos son maravillosos, ella reza cuando el marido no está; el marido vuelve, salvo que hay un nené que grita "*si papá se va yo me mato*" y una nena que grita "*un hombre te miró cuando estabas en corpiño*".

A eso es lo que yo llamo ideales narcisísticamente valorados, que inducen a la represión en la medida que no la hay, sino construcción de un ideal y el retorno de lo reprimido que aparece a voz en cuello sostenido por alguna de las figuras de la familia.

Lic. Czertok: Yo me pregunto cuál sería el proyecto de tratamiento. No es fácil encontrar la fórmula adecuada. En primer lugar, uno de los peligros es la conraidentificación con la familia. Una situación en la que el terapeuta se ve impulsado a hacer, a pensar, a sentir incluso como un miembro más del grupo familiar.

Lanzarse demasiado pronto por el camino de lo manifiesto de la sesión, nos impulsaría a movernos por zonas muy peligrosas. Es preciso comprender el mensaje atente de las estructuras en juego y comprender a cada uno de los miembros en particular, con sus respectivas demandas y sus cantos de sirena.

En algún momento hay que trabajar con la pareja sola, sin incluir a los chicos. Dejarlos afuera consecuentes con un proyecto terapéutico que va más allá del momento circunstancial de la sesión, de la urgencia terapéutica, de la ansiedad personal por los síntomas que han traído al niño a la terapia. De todos modos, el terapeuta debe conservar una capacidad de maniobra que le dé libertad de movimientos, dentro de un plan básico, previamente planificado en lo posible, pero que le permita tentar caminos.

Ello es algo difícil de programar pero que se impone. Creo que incluso, a veces es la única manera de poder mantener un tratamiento. Para empezar, el compromiso de un terapeuta de niños, es básicamente para con los niños. Es el compromiso de agotar todos los medios para que esa función que ha comenzado a través de él por la consulta indirecta acerca del síntoma que en este caso es una dificultad de aprendizaje escolar, llegue a buen término. Muchas veces hay que hacer marchas y contramarchas.

A veces la familia no llega preparada para comenzar un tratamiento individual y mucho menos con un tratamiento familiar.

Entonces hay que tratar de comenzar con el tratamiento individual del chico, y, mientras tanto, ir captando a los padres y convirtiéndose en aliado de una madre que, como ésta, es una madre difícil, que empezó con una celotipía con la suegra, que dice que la maestra de tercer grado es un desastre, que además está acostumbrada a estar en el pedestal de maestra directora y de religiosa devota. Tenemos que ser precavidos para no agregarnos a la serie de fracasos terapéuticos que arrastra este grupo familiar. Sería necesario movernos en forma concordante con la mamá, dejando un poco que vaya para donde ella quiera. Dar y darnos tiempo para aumentar la chance que ella ofrece a los distintos terapeutas involucrados en tratamientos anteriores (de un año, de seis meses y brusca interrupción).

Preveo como la problemática más seria; el abandono del o de los tratamientos en este grupo familiar y la consumición del terapeuta, a la manera de los hipocondríacos. Lo ideal sería lograr que el proceso terapéutico incluyera en algún momento el tratamiento individual de la madre.

DIALOGOS

Abrimos una nueva sección de la revista dónde publicaremos en cada número un reportaje a destacados terapeutas familiares. En esta sección transcribimos las entrevistas realizadas por el Dr. ALFREDO CANEVARO con los Dres. DAVID RUBINSTEIN y GERALD ZUK en julio de 1978 en la ciudad de Filadelfia acerca de las corrientes en Terapia Familiar. Ambos formaron parte de un equipo pionero en el Eastern Pennsylvania Psychiatric Hospital (Filadelfia), junto con Boszormeny, Framo y otros, donde desarrollaron investigaciones muy importantes en una línea de orientación psicodinámica con familias con miembros psicóticos internos. Hace algunos años el equipo se disolvió, continuando sus integrantes sus desarrollos personales, en el mismo ámbito de la ciudad de Filadelfia, y enfatizando la tarea docente.

En el próximo número se publicaran las entrevistas con los Dres. IVAN BOSZORMENYI-NAGY de Filadelfia y MARA SELVINI-PALAZZOLI de Milán.

Dr. Canevaro: Bueno, Dr. Rubinstein, sería interesante conocer su idea personal sobre las grandes corrientes de terapia familiar en Estados Unidos; y en todo caso saber de dónde nacen teóricamente. Y saber, por ejemplo, si podemos hablar de la escuela de Filadelfia o en todo caso de la zona este de Estados Unidos, o si hay diferentes escuelas. Bueno, más o menos así sería la pregunta.

Dr. Rubinstein: En primer lugar, yo no creo que exista una escuela de Filadelfia. En realidad existen varias escuelas. En Estados Unidos han habido una serie de desarrollos teóricos, dependiendo de dónde y que clase de background ha tenido el líder de la corriente teórica. Originalmente hubo una conversión del modelo psicoanalítico, especialmente con el intento de estudiar la fenomenología y la psicodinámica de la esquizofrenia. Que, como usted recordará, principalmente fue estudiada por los psicoterapeutas psico-

análíticos que trataron, en la cuarta década de este siglo, de entender cómo las relaciones entre el hijo esquizofrénico y la madre esquizofrenogénica podía crear la fenomenología esquizofrénica. Entonces hubo toda una serie de postulados teóricos e hipotéticos que hubo que investigar. Empezando con Frieda Fromm Reichmann, que creó el término de madre esquizofrenogénica, con Lewis Hill, que publicó aquel pequeño librito sobre psicoterapia del paciente esquizofrénico basado en algunos conceptos de Freud sobre las neurosis narcisistas, Freud siempre estableció alguna relación entre el trauma oral y la neurosis narcisista y describió el proceso primario, y estableció que en la esquizofrenia o en la psicosis, y en general, en las neurosis narcisistas tan primitivas existía una fijación en la fase oral. El postulado que se estableció fue que el paciente esquizofrénico estaba fijado en la fase oral, o había regresado a una fase oral. Logicamente, la conexión psicodinámica era que tenía algo que ver con la relación madre-hijo, en las primeras fases del desarrollo psicosexual.

Dr. Canevaro: Y, además, creo que fue el precursor en realidad de la teoría de las tres generaciones, que desarrolló Bowen.

Dr. Rubinstein: Sí, sí. Pero no fue Bowen. En el artículo que escribimos para el libro de psicoterapia intensiva familiar, nosotros anotamos, que antes de Bowen hubo otros autores que escribieron sobre eso.

Dr. Canevaro: Fue Lewis Hill.

Dr. Rubinstein: Sí. No fue Bowen. Bowen ha tomado la idea, pero originalmente fue Lewis Hill el que escribió sobre las tres generaciones.

De modo que empezamos en aquél entonces, en el año 50, a pensar psicodinámicamente en estudiar las relaciones entre madre-hijo y ver qué clase de conexión entre los dos había existido. A través de todas esas cosas que hicimos, lo único que se logró fue, si no explicar el concepto de esquizofrenia, sí lograr hacernos conscientes de la existencia de una relación. Y lo que hicimos fue, poco a poco, desarrollar un nuevo modelo conceptual, el modelo

conceptual de la interrelación. Concurrió aquello con el progreso, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo del concepto de Sistemas, que se estudió en física, en bioquímica, etc. Se nos ocurrió entonces aplicarlo a las relaciones sociales. Es decir que la psiquiatría tomó esa nueva contribución de la filosofía de la ciencia y la aplicó hacia la creación de nuevos modelos psicodinámicos. De modo que coincidieron dos corrientes: una, el intento de los psicoterapeutas de explicar el origen de la esquizofrenia, y segundo, la contribución, después de la Segunda Guerra Mundial del desarrollo del concepto de sistema y su aplicación a las relaciones interpersonales.

Dr. Canevaro: Uno partía del individuo hacia el grupo, y el otro...

Dr. Rubinstein: ...del grupo hacia el individuo, en base a teorías interrelacionales. Y por eso se crearon los nuevos conceptos sobre teoría familiar. Pero, fundamentalmente, la raíz era la coincidencia de dos corrientes filosóficas: una, la corriente filosófica psicodinámica o psicoanalítica, y la otra la corriente filosófica sobre el desarrollo de la teoría de sistemas, con un esfuerzo de explicar la conducta humana.

Dr. Canevaro: El problema es que se parte ...uno parte de la monada, la teoría psicoanalítica o psicodinámica, y la teoría sistémica, no. Ese es un problema, también de distintos niveles.

Dr. Rubinstein: Son dos niveles distintos, sí. Pero aunque no explicamos el desarrollo etiológico exacto de por qué tenemos pacientes esquizofrénicos, sin embargo, lo que sí creamos es el concepto de sistema, y lo adjuntamos al concepto psicodinámico que teníamos y creamos un nuevo concepto, que es el sistema psicodinámico familiar. Nos pasamos aquí como diez años en este instituto tratando de aplicar esos conceptos al tratamiento de pacientes esquizofrénicos. Y me acuerdo de haber pasado horas y horas viendo pacientes esquizofrénicos y sus familias, tratando de entender más. Al mismo tiempo, ese tipo de desarrollo filosófico llevaba otra corriente consigo, que es el desarrollo del mismo concepto de sistema aplicado al desarrollo de computadoras y

cálculos balísticos, etc. y toda la nueva teoría de información. Esa nueva rama de teoría de la información también vino y se aplicó a la psiquiatría. Y fue Bateson, que en aquél entonces estaba interesado en estudiar la comunicación en seres infrahumanos, como por ejemplo en los dolphins...

Dr. Canevaro: Los delfines.

Dr. Rubinstein: Sí, los delfines. Le interesaba estudiar cómo los delfines se comunicaban unos con otros. Y utilizó los conceptos filosóficos de la teoría de la información para aplicarlos a la comunicación de los delfines. Entonces se le ocurrió a él tratar de ver cómo eso se aplicaba a la esquizofrenia... cómo el esquizofrénico procesaba información y cómo personas cerca del esquizofrénico procesaban información de vuelta, y creaban un sistema de información unos con otros.

Dr. Canevaro: El fue gestor intelectual, un poco, de esa corriente. Jackson la aplicó...

Dr. Rubinstein: Fue el factor fundamental. Gregory Bateson fue el cerebro detrás de este concepto. Entonces creó un proyecto de investigación que fue auspiciado por la Veterans Administration y por el Mental Research Institute más tarde. Y trajo consigo a algunos psiquiatras. Y uno de los psiquiatras fue Jackson; otro fue Jay Haley, que no es psiquiatra pero era un ingeniero que se dedicaba a ingeniería de comunicación, que en aquél entonces no sabía nada de psiquiatría. Y trajo consigo a otra gente que entonces se unieron a Bateson para estudiar ese proyecto, sobre el proceso de información en pacientes esquizofrénicos. Y él se mantuvo a la cabeza de eso unos cuantos años; después se desanimó, se fue a continuar estudiando sus delfines en Hawai. Pero el que se quedó a cargo de ese proyecto entonces fue Don Jackson. A partir de eso entonces se creó la corriente de la teoría de la comunicación en la familia, que no es más que una teoría basada en cómo el individuo procesa una información de unos hacia otros. De modo que tiene usted ya dos corrientes; una es la que está enraizada en las teorías psicodinámicas, con todos los conceptos de psicodinámica

y sistema familiar y la otra es la gran corriente sobre el proceso de la información y comunicación interpersonal. Tiene usted las dos corrientes.

Al mismo tiempo, en la parte este de los Estados Unidos, algunos psiquiatras que también estaban interesados en estudiar la esquizofrenia, se dedicaron a observar a la familia como una unidad terapéutica. No solamente para hacer observaciones sino también para tratar de aplicar algunas teorías psicodinámicas a la unidad familiar. Y entonces trataron de utilizar algunos conceptos de la psicodinámica individual de la monada y utilizar el mismo concepto aplicado al grupo, al grupo familiar. El mismo concepto fue utilizado para varios niveles. Por ejemplo, el concepto del yo, que es fundamentalmente el concepto de la monada, del individuo, de la psicodinámica del individuo, basado en un modelo freudiano, trataron de aplicarlo al grupo familiar como si existiera un yo familiar. Ese grupo estaba liderado por Bowen, en Washington. Quiere decir que ese grupo teórico, lo que hizo fue aplicar algunas teorías psicodinámicas, principalmente basadas en la psicología del yo aplicarlas al grupo familiar, como si se pudiera transponer Bowen, en aquél entonces, también en el año 50, habló del yo diferenciable, o del yo indiferenciable.

Dr. Canevaro: La masa del ego indiferenciado...

Dr. Rubinstein: La masa del ego indiferenciado o no diferenciada. Tratan de explicar la fenomenología esquizofrénica, como si la familia que tuviera un ego no diferenciado pudiera explicar la existencia de un paciente esquizofrénico. De modo que tomó el concepto de psicología del yo que en aquel entonces empezaban a desarrollar en el terreno psicoanalítico, en el año 50, todo el concepto de psicoanálisis del yo. Empezaron a desarrollarlo y lo aplicó en la teoría familiar. Tomó otro concepto, que es el concepto de la transmisión de la irracionalidad de generación en generación, como si la irracionalidad se aprendiera; uno aprendiera de los padres, de los abuelos cómo ser irracional. Lo cual fue un concepto prestado también.

Dr. Canevaro: De Lidz.

Dr. Rubinstein: De Lidz, que fue el que originalmente empezó con ese concepto en Yale, con su grupo. Lidz y Fleck y colaboradores han publicado ahí un trabajo sobre la transmisión de la irracionalidad en la familia. Lo cual, en realidad, no era puramente un concepto psicoanalítico, era un concepto mezcla de psicoanálisis y mezcla del *learning theory*, de teoría del aprendizaje, que en aquel entonces también empezaba a desarrollarse. La teoría del aprendizaje empezaba a desarrollarse alrededor de la década de 1950 también para explicar la conducta humana. Lo que dió lugar, con Wolpe y sus predecesores al concepto de la *Behavior therapy*, que la conducta humana es aprendida. Lo cual data todo hacia atrás desde los psicólogos conductistas, que empezaron en el año 20, pero fue redescubierta alrededor del año 50 por este grupo de psicólogos. Pero ahí es mezclado, que la conducta humana es aprendida, que la irracionalidad se puede aprender. Pero aunque Lidz y colaboradores son psicoanalistas, lo que hicieron fue tomar algunos conceptos de los conductistas. Bowen tomó la misma idea que Lidz estaba desarrollando y la prendió con el otro concepto, el concepto del yo y de la psicología del yo, y creó una nueva corriente teórica, basada en estos dos pivotes conceptuales: uno, la psicología del yo aplicada a la familia; y segundo, que las generaciones, de una a otra, aprenden estilos conceptuales.

Dr. Canevaro: ...Las tres generaciones...

Dr. Rubinstein: En aquel entonces, en el año 50, con Bowen estaba trabajando un hombre, que era Lyman Wynne, que se interesó en esto, y entonces trató de explicar y probar —con investigaciones psicológicas— que uno podía demostrar que en cada paciente esquizofrénico había una generación anterior de predecesores que eran también irracionales, y que pensaban en una forma irracional; y ese fue el famoso trabajo que hizo Lyman Wynne (con Margaret Singer) sobre el Rorschach en familias esquizofrénicas. Haciendo predicciones Wynne y Singer sobre el tipo de estilo cognitivo que, existía en los padres y los hijos esquizofrénicos.

Bueno, ya tiene usted tres corrientes: la corriente psicodinámica, la corriente del proceso de información o comunicación y la corriente de la psicología del yo y la posición del yo en el territorio

familiar. Hay un tercer concepto al que Bowen ha contribuido que es el concepto de que cada persona establece una posición *yoica*, una posición del ego, en su territorio familiar. Que es solamente una derivativa de la *psicología del yo*. Y todos los terapeutas que tienen una tendencia a ser psicoterapeutas con orientación *yoística* tenderían a mantener que el paciente tiene que establecer y hacerse consciente de las fracciones de su *yo*. Y ésa es la cosa que aplicó también Bowen a su corriente teórica.

Ackerman, que era un psiquiatra infantil, vino a la puesta —en aquel entonces también, porque era fundamentalmente un psicoanalista, y muchas de las cosas que estaba trabajando él con psicoanálisis y psicoterapia de niños trató de aplicarlas psicoterapéuticamente, psicodinámicamente a la familia. Pero por estar insatisfecho y por una serie de problemas políticos que tuvo con el grupo psicoanalítico al que él pertenecía, entonces se separó y se convirtió en psicoanalista familiar. De modo que ya tiene usted tres corrientes con cuatro líderes.

Dr. Canevaro: Y a todo esto, el psicoanálisis ¿cómo veía ese desarrollo El Psicoanálisis ortodoxo.

Dr. Rubinstein: Ah, enseguida empezó a decir que todo eso era absurdo. Que eso no significaba nada; que siempre la psicoterapia debía ser conducida a través de un individuo y no a través de la familia. Y que toda presencia del individuo con la familia, lo único que hacía era contaminar la transferencia necesaria en que el análisis se basaba. El, clásicamente se ha basado en el concepto del desarrollo de neurosis transferencial o una psicosis transferencial; y que la resolución de la neurosis transferencial era uno de los ingredientes necesarios para el éxito de la psicoterapia, del psicoanálisis. Y cómo podía desarrollarse una neurosis transferencial, que era un fenómeno de una persona hacia otra persona, cuando existía todo un sistema familiar? No se podía. De modo que, automáticamente, se dividieron los campos. Porque inclusive los terapeutas familiares que tenían una base psicoanalítica no acentuaron el concepto del desarrollo de la neurosis transferencial en la psicoterapia de familia, sino que solamente utilizaron conceptos para investigar la génesis de los trastornos familiares. Pero no para desarrollar una neurosis

transferencial del grupo familiar. Por el contrario, consideraron que el desarrollo de la neurosis transferencial en psicoterapia familiar es una complicación que uno debe tratar de evitar; crea un problema. Lo cual no es cierto en la psicoterapia individual. En la psicoterapia individual se busca el desarrollo de una neurosis transferencial y la resolución de la neurosis transferencial.

Dr. Canevaro: Lo que pasa es que en el grupo vemos otro fenómeno, ¿no? Como la transferencia se puede dar...

Dr. Canevaro: ... de una relación a otra. Esa fue una contribución que hicieron los psicoterapeutas familiares: demostrar que el fenómeno transferencial que clásicamente se consideraba exclusivo del fenómeno terapéutico, del concepto terapéutico, también existía en el sistema familiar, entre persona y persona. No era solamente exclusivo, entre el paciente y su terapeuta.

Dr. Canevaro: Y con la misma persona con quien habían existido conflictos anteriormente.

Podía ser reprojectado sobre la misma persona.

Dr. Rubinstein: Seguro, Entonces, tiene usted todas estas corrientes ya existentes a fines de la década del 50.

Dr. Canevaro: Perdón. Y todavía el psicoanálisis continúa en su rechazo de la terapia familiar?

Dr. Rubinstein: Sí, aunque usted notará algunas revistas como el *International Journal of Psychoanalysis* y el *American Journal of Psychoanalysis*, en las que hay algunos artículos publicados que ya utilizan conceptos de psicoterapia familiar.

En esas corrientes que yo estaba describiendo, hubo una serie de desarrollos a partir de ese punto. Uno de los desarrollos fue Jackson, por ejemplo, que desarrolló sus ideas y que estudió la familia como un sistema homeostático, y se dedicó a estudiar la familia como sistema homeostático, gobernado por reglas que controlaban las producciones interfamiliares. Además dio lugar a algunos de los miembros de ese grupo que estudiaran simplemente

la fenomenología comunicacional, la fenomenología de cómo procesar la información en la familia, y cómo se establecían esas reglas. Ese fue el interés principalmente de Jay Haley, cómo se establecían las reglas y cómo se procesaba la información entre una persona y otra, y cómo las reglas gobernaban también ese proceso de información. Desafortunadamente, Jay Haley nunca creó técnicas, sino que se dedicó a observar la fenomenología familiar.

Dr. Canevaro: Es lo que ahora reivindican algunos europeos, tomando ese basamento teórico y creando técnicas, como en el caso de Selvini-Palazzoli en Milán, que se apoya teóricamente en Haley, pero crea técnicas que ella dice, son de un resultado sumamente positivo.

Dr. Rubinstein: Sí, excepto que Jay Haley basó algunas de sus observaciones en un clínico que es poco conocido, que practica hipnosis terapéutica.

Dr. Canevaro: Erikson.

Dr. Rubinstein: Erikson! Y que trabajó con la paradoja. Entonces mucho de lo que Haley habla es copia de Erikson. Erikson le dio a Jay Haley ideas para crear sus teorías, basadas en las experiencias clínicas que había tenido. Y entonces Jay Haley creó sus hipótesis y sus teorías. Pero al mismo tiempo Mara Selvini-Palazzoli, utilizó la teoría de Jay Haley lo que hizo fue volver otra vez a la técnica, pero las técnicas a las que ella llega son muy parecidas a las que usa Erikson.

Dr. Canevaro: Y usted qué piensa de esas técnicas?

Dr. Rubinstein: Yo creo que son útiles. Yo decía que algunas de las corrientes se habían desarrollado, como por ejemplo Don Jackson, Jay Haley, y entonces Salvador Minuchin tomó el mismo concepto de Gregory Bateson sobre la familia como un sistema, y en vez de estudiar el proceso de información o de estudiar el grupo como un grupo homeostático lo que hizo fue considerar el punto de vista estructural. Y pensando que cambiando las relaciones en

la estructura, o cambiando las posiciones dentro de la estructura, era suficiente para cambiar la sintomatología ¿Entiende?

Dr. Canevaro: Sí, sí. Es un fenómeno que clínicamente se observa.

Dr. Rubinstein: Pero es que todos estos tienen razón, porque es como el elefante, ¿no? Cada uno trata de describir al elefante de acuerdo con el pedacito del elefante que está observando. De modo que tiene a Salvador Minuchin, Jay Haley, y Don Jackson agrupados bajo la bandera de la teoría creada por Gregory Bateson.

Dr. Canevaro: Y Minuchin intenta por lo menos diferenciarse, ¿no? Tomando ciertas cosas del estructuralismo, incluso Levi-Straus, y explica ciertas cosas que pareciera ser en algo distinto a lo que dicen los comunicólogos.

Dr. Rubinstein: Sí, pero en realidad lo que hacía era estudiar la estructura del sistema. Y cambiar las posiciones dentro de la estructura del sistema, para entonces cambiar la sintomatología, o la conducta humana.

Dr. Canevaro: Solamente que él se introduce mucho más adentro del sistema con el joining, ¿no? Pareciera ser.

Dr. Rubinstein: Ese fue un desarrollo de esa corriente. Después tiene usted el desarrollo de la otra corriente, empezando con Ackerman con la psicodinamia, con Bowen la psicología del ego y las posiciones del ego dentro de la familia, y entonces usted tiene el desarrollo de otra serie de conceptos, también basada en psicoanálisis, que es las relaciones objetales, las relaciones del objeto. Que fue desarrollada poco a poco por Nagy aquí en el Instituto.

Dr. Canevaro: ¿Boszormenyi - Nagy?

Dr. Rubinstein: Sí. Y este desarrollo lo que ha hecho es llevarlo al concepto de las relaciones entre personas. Entonces él trató de aplicarlo al concepto de las relaciones objetales y demás, y el con-

cepto de análisis existencial, a las relaciones familiares y entonces dieron con el concepto de la relación intergeneracional.

Dr. Canevaro: Usted se adscribe de alguna manera a la corriente que sintetiza Boszormenyi-Nagy? Usted piensa personalmente que...

Dr. Rubinstein: No.

Dr. Canevaro: ¿Cómo podría definirse?

Dr. Rubinstein: Por eso veía que en Philadelphia había dos corrientes: una la de Salvador Minuchin, que está basada principalmente en la teoría estructural de la familia, y la de Boszormenyi-Nagy que está basada en la corriente puramente psicoanalítica, con relaciones objetales, análisis existencial, relaciones intergeneracionales, etc. Vengo yo y digo que todas estas corrientes tienen quizás un poquito de la verdad. Que uno no puede pretender explicar el fenómeno familiar solamente en base a una de las teorías. El fenómeno familiar es mucho más complejo que todo eso, y es necesario crear una corriente teórica integrativa, porque no deja de ser cierto que cada una de estas teorías, usando técnicas, pueden en algunos casos resolver los problemas. Pero que los problemas que clínicamente observo en la familia son mucho más complejos, que puedan explicarse solamente por el simple proceso de información o que puedan explicarse solamente por las relaciones intergeneracionales, o que puedan explicarse solamente en base al yo diferenciado o no diferenciado, o que puedan explicarse en base a la estructura del sistema. Y cada una de ellas es un poquito la verdad. Es más: además de todo esto, lo que no se ha hablado suficientemente es sobre otras cosas más. Por ejemplo, la cultura de la familia. Que cada familia tiene una serie de reglas culturales y de sistemas culturales, que la familia como agente de esa cultura, sigue. Y que los roles dentro de la familia están muy controlados por la cultura a la que la familia pertenece. Segundo concepto, de que la familia sigue un proceso de desarrollo, que nunca se mantiene estática. Y que la familia, a través de los años cambia, de acuerdo con las reglas preestablecidas por la cultura a que pertenece. Y que la familia después del segundo tercer año de haberse creado, el

D. Rubinstein, Gerald Zuk y Alfredo A. Canevaro

bloque familiar, es distinta a la familia 10 años más tarde, 15 años más tarde ó 20 años más tarde. Porque es un proceso formado de una dinámica que le está...

Dr. Canevaro: ¿Con estadios evolutivos de esa familia?

Dr. Rubinstein: Que continúan apareciendo pre-determinados por las reglas impuestas por el contexto cultural y que la familia sigue. La familia se guía por esta serie de reglas culturales que no se han analizado suficientemente. Que son reglas que tienen que ver con las relaciones de poder de un miembro a otro miembro. Que la familia, como organización dinámica, tiene una serie de roles de poder asignados por la cultura: la posición del padre, como posición de poder; o la posición en una familia de esquizofrénicos, en la que el paciente esquizofrénico o la familia esquizofrénica sigue la regla del poder que es anormal. Normalmente, las reglas del poder en una familia, siguen el proceso secundario. Siguen reglas del proceso secundario, establecidas por Freud. En la familia esquizofrénica, las reglas del poder siguen el proceso primario.

Dr. Canevaro: A la persona que acusa más capacidad de regresión.

Dr. Rubinstein: Es la persona que controla a la familia, lo cual es una inversión de lo que habitualmente se conoce en las familias normales. Por ejemplo, en algunas familias la posición matriarcal es importante, es la que crea el poder. El poder lo hemos definido como la posición desde la cual la persona establece las reglas de conducta. Las reglas de conducta son las que le dan el poder a la persona. Si yo le digo a usted cómo debe conducirse en mi presencia y establezco las reglas en nuestras relaciones, yo tengo el poder. Si en otro momento usted es el que establece las reglas de conducta, usted es el que tiene el poder. El poder puede cambiar de una persona a otra. Generalmente en familias normales, el poder se mantiene en ciertas personas y se cambia de acuerdo con ciertas reglas, de una persona a otra, de acuerdo con ciertas circunstancias. En una familia patológica, las reglas no son tan predictibles, siguen siempre procesos más y más primarios.

Dr. Canevaro: Usted vería alguna conexión entre esa condición regresiva y el "intento" de cambiar la estructura rígida familiar? Podríamos pensar que el esquizofrénico utiliza su regresión para intentar cambiar el sistema rígido, distorsionado?

Dr. Rubinstein: Yo creo que el paciente esquizofrénico trata de encontrar alguna forma de claridad, alguna forma de organización dentro de la desorganización en que se encuentra. Como las reglas que aplica son reglas del proceso primario, entonces el resultado es caótico. Y como el paciente esquizofrénico es el que es asignado a tener el poder en la familia, debido a ese proceso primario, entonces encuentra una doble responsabilidad: de hacer sentido de un proceso caótico, cuando no puede hacerlo, y de utilizar reglas del proceso primario, que no puede organizar nada. Y todavía crea más confusión a sí mismo y a la familia.

De modo que, en mis conceptos teóricos, primero acepto cada uno de estos que me han precedido. Parte de ellos dicen la verdad, es cierto, no lo puedo negar. Pero trato de desarrollar un poquito más, de introducir nuevas corrientes teóricas. Y trato, como por ejemplo el concepto del poder, el concepto de la existencia de patrones programados entre personas. Es decir, que dos personas o tres programan su conducta. Como, por ejemplo, en este artículo de las diadas depresivas, o en el otro artículo de las relaciones narcisista. Las personas empiezan un *script*, un guión, y siguen un guión en su conducta habitual. Mientras más regresiva es la conducta entre dos personas, más constreñido el guión, más pobre, es decir, que tiene pocas variantes. Y se reduce casi a una repetición uniforme, que se repite. Cada tres minutos se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo.

Dr. Canevaro: ...estereotipada...

Dr. Rubinstein: Sí. Mientras menos regresivos, más neuróticos, más normales son las relaciones, entonces más rico es el guión, más variantes se pueden introducir. Pero siempre hay un guión que las personas siguen. Entonces la familia se construye como unidad, se organiza como unidad, basada en estos guiones. Que están predispuestos, pre-escritos por la cultura, por las relaciones de poder y por las necesidades individuales.

Dr. Canevaro: ¿Qué tiene que ver el inconsciente individual en ese cuadro?

Dr. Rubinstein: Bueno, porque en las necesidades individuales, por ejemplo en las necesidades narcisistas individuales, el inconsciente juega un papel enorme. Y entonces el individuo crea parte de su guión en base a sus necesidades individuales. Y viceversa. El sistema que ya crea un programa, un guión debido a su cultura, el sistema familiar, también contribuye a crear las necesidades individuales. Así que en un sistema siempre las corrientes van en doble sentido. Por ejemplo, en el artículo que escribimos sobre relaciones narcisistas, yo trato de mostrar que el narcisismo no es un concepto individual solamente que el narcisismo es un concepto diádico. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la corriente psicoanalítica clásica el narcisismo es la relación que hace un individuo con su objeto, para suplir la autoestima, mejorar la autoestima, o corregir la autoestima del individuo. Y las relaciones objetales son las que están continuamente alimentando la autoestima del individuo. Pero la realidad es que el objeto es siempre otro individuo, generalmente es otro individuo. Entonces me pregunté yo, ¿qué pasa en los patrones que se establecen entre dos individuos? En qué uno es objeto del otro? Entonces el concepto de narcisismo en vez de ser el concepto de un individuo, se convierte en un patrón de conducta entre dos individuos. Y el narcisismo se convierte en un proceso narcisista entre dos personas.

Dr. Canevaro: ¿Qué sería una repetición de una relación primitiva de objeto internalizada?

Dr. Rubinstein: Exactamente. Entonces, en el artículo describimos que los padres, o la madre, la madre fundamentalmente, crea una relación narcisista con el hijo infántico, con el hijo recién nacido. Pero esa relación narcisista es una relación normal narcisista, es saludable. Porque el recién nacido necesita la relación narcisista para poder crear un concepto del yo. Y para crear un concepto suficiente del yo que sea saludable. Pero si la relación narcisista predomina y prevalece por encima de todos los otros aspectos de la relación madre-hijo, entonces se convierte en patológica. Enton-

ces el hijo se fija en una posición narcisista convirtiéndose en un objeto en el mundo narcisista de la madre. Entonces, en ese sentido, se va creando, internalizando, el inconsciente, amoldándose el superyó narcisista, el yo narcisista en todas las funciones defensivas patológicas narcisistas del individuo, del niño a medida que va creciendo. De modo que la relación, el programa, el guión creado madre-hijo, lo único que hace es ayudar a esculpir, a esculpir el inconsciente del hijo. Pero el hijo con su inconsciente crea patrones, a los cuales se acostumbra, que aprende y que repite con la madre más tarde. Y que si no es con la madre, entonces busca otros medios, otro individuo, que también está en una posición narcisista, con los cuales pueda repetir sus patrones.

Dr. Canevaro: Ahora, ¿qué papel tiene el padre en esa relación?

Dr. Rubinstein: O también la relación entre madre y padre, cuando son patológicamente narcisistas, lo que hacen es crear un molde para el hijo, que es también narcisista. Eso también lo discutimos en el artículo. De modo que tiene usted el concepto de la creación de patrones familiares, de guiones, que sirven para moldear la estructura familiar. El concepto de las relaciones de poder en la familia. El concepto de la transmisión... de la familia como agente de la cultura. Todo eso yo creo que es importante tenerlo en consideración cuando uno trata una familia. Además de todas las distintas corrientes. Entonces, si integramos todo eso se crea una corriente teórica. Esa nueva corriente teórica yo la llamaría **teoría integrada**. Porque ninguna de éstas de por sí es cierta. Se crea un nuevo nivel conceptual. El nivel conceptual que tiene en cuenta, que la familia, como sistema, es una nueva fenomenología teórica. Entonces creó lo que se llama la **psicoterapia integrativa de la familia**.

Dr. Canevaro: Usted es optimista con respecto a ese esfuerzo epistemológico?

Dr. Rubinstein: Quizás no lo veré en mi generación. Pero hasta ahora hemos podido escribir varios artículos orientando distintos conceptos. Tenemos el artículo sobre patrones culturales, tenemos

el artículo sobre las diadas depresivas, usando la depresión como modelo para estudiarlo. Y tenemos el artículo sobre narcisismo. Lo que me doy cuenta es que quizás es un esfuerzo enorme tratar de integrar todo eso en una nueva concepción. Pero es que también me resulta difícil esclavizarme a un solo concepto y considerar que eso me va a resolver todos los problemas. Como que en mi clínica yo veo pacientes, seres humanos de todas clases, con toda clase de niveles culturales, con toda clase de problemas clínicos. No puedo utilizar una sola técnica: tengo que usar la técnica que sea la más adecuada para el tipo de paciente que estoy viendo. Y usar el enfoque teórico que sea más adecuado para el tipo de paciente que estoy observando. Y por eso tengo que crear una integración.

Dr. Canevaro: Es interesante cómo coincide esto con una visión desde el fenómeno clínico. Usted recuerda en la introducción a la revista ¿la ha leído?; más o menos es similar el intento. Por lo menos el intento de comprensión. Porque, evidentemente, partimos desde la misma base de una experiencia clínica. Que es fundamental redefinir el fenómeno de la terapia familiar desde la experiencia clínica hacia la teoría, y no al revés. Es decir, no tomar el lecho de Procusto de cada teoría para intentar poner la terapia familiar adentro de esa teoría, sino al revés. Y es muy lindo ver la coincidencia. Porque creo que parte del fenómeno clínico y no de la teoría. Que es lo que uno en general no encuentra hablando con gente de distinta extracción teórica. Más bien se observa...

Dr. Rubinstein: Ahora por ejemplo, es que no es posible. Estoy muy interesado en estudiar los esquizofrénicos y lo que rodea al paciente esquizofrénico: la familia del esquizofrénico. Todavía estoy muy interesado. Y estamos observando. Tenemos tapes. Hacemos tapes, entonces en mis propios tapes observo a la familia. Pero una de las cosas en que me estoy interesando más y más es el fenómeno del narcisismo en la familia. El narcisismo normal y el patológico en la familia. Lo cual es una corriente que existe en psicoanálisis, tratar de observar el narcisismo individual. Yo trato de aplicar el narcisismo a la familia y tratar de derivar, trasladar, traducir conceptos psicoanalíticos individuales a conceptos de sistema familiar. Aunque se podría interpretar que mi corriente es psico-

analítica, porque utilizo también el concepto de los patrones de conducta, patrones de dos personas que las siguen. Por ejemplo, este artículo le permitirá ver un trabajo que hicimos previo a éste, que es el análisis de la conducta humana, conducta verbal y no verbal, en la interacción cara a cara entre dos personas analizando cinco minutos de una entrevista. El artículo se publica con un antropólogo. No tiene nada de psicoanálisis ahí, es puramente observación de conducta. Tratando de estudiar las entonaciones de la voz y cómo un entrevistador y un entrevistado crean un sistema, automáticamente, en que se monitorean, se influyen mutuamente en el sentido de la voz. Y utilicé ese mismo sistema para demostrar cómo una persona depresiva, con su coactor...

Dr. Canevaro: ...sù partenaire...

Dr. Rubinstein: Sí, con su partner, también se influye mutuamente con la voz y su conducta no verbal. Y el uno al otro se influyen, como en el electroencefalograma. Yo no sé si usted tiene experiencia con neurología. Pero en el electroencefalograma usted puede guiar el ritmo alfa cerebral de acuerdo con los estímulos fóticos, y se puede crear lo que se llama el "alfadrive". Bueno, en la conducta humana es igual. Uno puede influir una persona a otra. Eso no es psicoanalítico, eso es puramente conductista. De modo que mi corriente no se puede clasificar como psicoanalítica. Aunque no niego que tenga mucha influencia psicoanalítica, porque utilizo un modelo analítico, pero también utilizo un modelo conductista, también utilizo el modelo antropológico, comunicacional y el proceso de información. ...como se crean los patrones y guiones entre dos personas.

Dr. Canevaro: Y este esfuerzo teórico, usted piensa que es aceptado por la mayoría de los clínicos e investigadores en la terapia familiar?

Dr. Rubinstein: Yo no creo, porque estoy empezando. Este es un proceso que me demorará por lo menos 10, 20 años en desarrollar.

Dr. Canevaro: Es decir, usted piensa que la próxima generación de terapeutas de familia tendrá una teoría más integrada?

Dr. Rubinstein: Creo yo. Pero debe ser más integrada. Por eso la he llamado *integrative* o *integrated family therapy*.

Dr. Canevaro: Es muy lindo oír esto porque en general, quizás, y volviendo al narcisismo, cada terapeuta, cada investigador tiene su carril y de ahí no sale. Y el esfuerzo de integrar esto es un esfuerzo titánico quizás, pero necesario. Que aparentemente pareciera que coincide con otros desarrollos, otros intentos en otra parte del mundo, también. Parecería que Skinner, un inglés, pretende también integrar, partiendo desde el *group analysis*, algo parecido. Entonces ¿Es usted optimista acerca del futuro?

Dr. Rubinstein: Definitivamente. Perdón. Usted me preguntaba si existe una escuela de Filadelfia. No existe una escuela de Filadelfia. En este momento, yo diría que existen por lo menos tres corrientes. La que está encabezando Salvador. Está Nagy con su grupo. Y, modestamente, estoy yo, con una serie nueva de conceptos sobre cómo integrar todo lo que estamos perdiendo por todos lados.

Dr. Canevaro: Pero, de cualquier modo, Filadelfia sigue siendo un centro importante de terapia familiar.

Dr. Rubinstein: Muy importante.

Dr. Canevaro: Y así, como última pregunta, ¿Cómo ve los desarrollos futuros de esta, llamémosla, nueva disciplina científica? Usted piensa que con los años va a ser mucho más expandido el uso de la terapia familiar?

Dr. Rubinstein: Sí. Pero no solamente debido a los desarrollos teóricos. La expansión es debida a una serie de otros factores, de los que tendríamos que hablar otra hora. Que tienen que ver con la política y la economía. Y no solamente con la contribución de la terapia familiar a la explicación de la conducta humana. Quedan

toda una serie de otros problemas políticos y económicos en las relaciones profesionales.

Dr. Canevaro: Lo dejaremos para un próximo diálogo.

Dr. Rubinstein: Todo eso... Hay un trabajo que fue presentado en el último Congreso Mundial de Psiquiatría que es un artículo sobre, no psicoterapia familiar, sino sobre psiquiatría familiar. Que es otra serie de conceptos. Ese también es un concepto de integración en psiquiatría.

Dr. Canevaro: ¿Algo así como el concepto del viejo médico de cabecera?

Dr. Rubinstein: Del médico de cabecera, pero que sea el psiquiatra de cabecera.

Dr. Canevaro: Es un trabajo que usted presentó en el Congreso de Hawai.

Dr. Rubinstein: Sí. Seguramente va a ser publicado ahora.

Dr. Canevaro: Bueno, entonces queda abierta la posibilidad de un nuevo diálogo sobre el desarrollo de la terapia familiar. Le agradezco mucho.

A continuación incluimos una entrevista conducida por el Dr. Alfredo Canevaro con el Dr. Gerald Zuk, el 5 de julio de 1978, en la ciudad de Filadelfia (USA) sobre TERAPIA FAMILIAR: su pasado, presente y futuro.

Dr. Canevaro: — ¿Qué piensa usted con respecto al campo de la terapia familiar?

Dr. Zuk: —En los Estados Unidos de Norte América, nosotros hemos atravesado diversas fases; tres pienso yo. El campo tiene sólo 25 años. Yo diría que está en su adolescencia. En la década del 50 hubo una concentración en trabajar con esquizofrénicos. Pienso que estaba estrechamente relacionada en el tiempo con el trabajo comenzado en la década del 40 con esquizofrénicos en psicoterapia individual, por ejemplo, el hermoso trabajo de Harry Stack Sullivan.

La promesa de terapia familia en la década del 50 fue, que pudo identificar y tratar la familia *esquizofrenizante*; pero la promesa no fue cumplida a pesar de los marcados conocimientos y algunos éxitos terapéuticos. Personalmente, yo nunca fui entusiasta con respecto a la noción de la familia *esquizofrenizante*, la cual era una unidad específica de familia que, por presión socio-psicológica podría producir un chico, quien probablemente se volvería esquizofrénico. Yo pensé que más que esto era necesaria la concurrencia de la interacción de muchos hechos —comprendiendo constitución, fisiología, traumas accidentales, más la tensión socio-psicológica. Hubo algunos estudios destacados innovadores en el intento de la década del 50 de probar la existencia de la familia *esquizofrenizante*; como por ejemplo, aquellos del grupo de Yale de Lidz y Fleck por Bowen y posteriormente Wynne en el Instituto Nacional de Salud Mental, cerca de Washington DC, y el Grupo de Palo Alto en California encabezado por Don Jackson. El grupo de Palo Alto fue responsable por lo que —en mi opinión— fue el concepto más significativo de los años 50: el doble vínculo. Comprensiblemente, pero erróneamente, el Grupo de Palo Alto creyó que el doble vínculo era una completa explicación de la esquizofrenia. Por supuesto no fue así, pero de todas maneras fue una excelente contribución. La gran diferencia en esquizofrenia, fue la introducción de psicotrópicos efectivos en la década del 50. En otras palabras, el mayor avance

fue en drogas más que en tecnología psicoterapéutica. Las drogas produjeron un mayor cambio de actitud hacia los esquizofrénicos tanto en los profesionales de la salud mental como en el público en general. Las tendencias hacia la des-institucionalización, la salida de pacientes de los hospitales psiquiátricos y la reducción de la necesidad de hospitalización, ha sido uno de los cambios profundos en la salud mental de los EE.UU en la última década y media. Las drogas han hecho posible el manejo de muchos individuos perturbados sin concurrencia al hospital.

Dr. Canevaro: —Ustedes tienen ahora un gran problema con los llamados ghettos de psicóticos...

Dr. Zuk: —Sí, ha habido un clamor de algunas comunidades donde los pacientes hospitalizados fueron dados de alta a lo mejor prematuramente o sin servicios de apoyo para comprenderlos desde los períodos iniciales.

Dr. Canevaro: —Piensa usted que los familiares de esos pacientes no estaban preparados o a lo mejor ellos no tienen familias que los reciban?

Dr. Zuk: —Ambas cosas. Había falta de preparación de las familias a las cuales los pacientes iban a volver. Los pacientes sin familias accesibles eran trasladados a pensiones rápidamente. Esto fue fatalmente lo que produjo un alto porcentaje de reincidencia: los pacientes regresaron y fueron devueltos a la institución. Recientemente, en un estado, California, yo tengo entendido que hay un movimiento de funcionarios para restablecer algunas de las facilidades del hospital de salud mental estatal. California fue el líder de la des-institucionalización, pero descubrió que había que aflojar el paso.

Dr. Canevaro: —¿Usted piensa que los hospitales de salud mental están bien preparados para trabajar con familias?

Dr. Zuk: —El hospital estatal no es particularmente un buen ambiente porque el sistema hospitalario (incluyendo el emplazamiento), no es conducente a la participación de la familia. La receptivi-

dad de familias de parte del staff del hospital de salud mental, no es alta. La mejor manera para las familias de ser involucradas, es en la comunidad.

Dr. Canevaro: —¿En el centro comunitario de salud mental?

Dr. Zuk: —Sí, pero no justamente en el centro comunitario de salud mental. Nosotros deberíamos tener otra clase de facilidades accesibles a las familias, también otra clase de instituciones. Nosotros tenemos algunas ya, tales como las agencias de trabajo social, las cuales brindan servicios familiares, y muchos de los llamados centros de crisis (un mayor desarrollo en los servicios de salud mental en USA en la década pasada) brindan importantes servicios familiares. El sistema del hospital estatal aquí continuará hasta que disminuya. No desaparecerá, como algunas personas piensan que debería, porque nosotros todavía necesitaremos los hospitales estatales para servir a poblaciones de pacientes. Habrá probablemente siempre algo como el hospital estatal, pero la estructura (física y administrativa) será diferente.

Yo pienso que las plantas enormes y físicamente impersonales desaparecerán para ser reemplazadas por unidades más pequeñas, interconectadas, algo así como nuestros complejos suburbanos.

Dr. Canevaro: —¿Estructuras multifamiliares?

Dr. Zuk: —Sí. En los suburbios las casas de departamentos son generalmente de dos o tres pisos y las unidades están interconectadas. Yo sospecho que los hospitales psiquiátricos estatales en el futuro serán semejantes y no de 20 pisos como ahora.

Dr. Canevaro: —Usted sabe que nuestra clínica en Buenos Aires funciona como una estructura multifamiliar y los resultados son muy buenos.

Dr. Zuk: —La arquitectura afecta a la gente, a lo mejor más de lo que ellos creen. Toma tiempo recuperarse de la inmediata reacción de impersonalidad que la gente experimenta al encontrarse en la mayoría de los edificios públicos.

Dr. Canevaro: —¿Piensa usted que este hospital del futuro será capaz de hacerse cargo del grupo familiar?

Dr. Zuk: —Sí; pero volvamos al problema de la historia de la terapia familiar, del cual nos hemos desviado. Yo mencioné que en la década del 50 el énfasis fue la esquizofrenia. A principio y a mediados de la década del 60, nosotros tuvimos el desarrollo del concepto de comunidad de salud mental, y la terapia familiar se adaptó fácilmente a este concepto. El staff de los centros tuvo que ocuparse de problemas no típicamente asociados con la destreza psiquiátrica. Los problemas maritales, por ejemplo, y la fuga de adolescentes, así como los chicos que trabajan poco en el colegio; y la juventud y los adultos que abusan del alcohol y otras drogas. Muchos de estos casos desafían a la nomenclatura tradicional para las enfermedades psiquiátricas. Estos casos fueron observados por terapeutas de familia, quienes también empezaron a adquirir mayor experiencia, con un campo mucho más amplio de tipos familiares. Yo quiero significar que nosotros empezamos a ver familias de diversos orígenes étnicos (en USA, por supuesto, hay un enorme campo), y todas las formaciones religiosas, los factores socioculturales que afectan profundamente el curso y el resultado de la terapia familiar.

Dr. Canevaro: —¿Usted quiere decir que la terapia familiar se abre a la comunidad?

Dr. Zuk: —¡La comunidad entera, sí! . Nosotros tuvimos que aprender a comprometer familias recalcitrantes, porque encontramos que había un alto porcentaje de abandonos prematuros de tratamiento. Algunas veces, esto se debía a la técnica terapéutica deficiente, pero también a que muchas familias dan pocas oportunidades para facilitar un compromiso emocional profundo con el terapeuta.

Dr. Canevaro: —¿Menos que con las familias psicóticas hospitalizadas?

Dr. Zuk: —Sí. Con un miembro psiquiátrico en el hospital, el

terapeuta tenía una especial ventaja para fortalecer la cooperación familiar. Con el "paciente identificado" ambulatorio, no había tal control. Nosotros tuvimos que desarrollar formas de comprometer familias, y mucho de mi trabajo hasta hace tres o cuatro años, se concentró en cómo conseguir que las familias vuelvan al consultorio cuando tienen poco interés en sentarse y hablar durante una hora. Yo me sentí mal al principio, pensando que tal vez por mi culpa yo estaba perdiendo un gran número de familias de pacientes externos, y que realmente mi torpeza era un factor. Pero más tarde comprendí que una parte muy significativa del problema pertenece a la estructura familiar. Más precisamente, el problema tiene que ver con los valores familiares. Algunas familias tienen por ejemplo, poca confianza en el valor de la charla. Sentarse y hablar con alguien completamente hábil en el lenguaje durante una hora, es una exigencia difícil. Nosotros tenemos que desarrollar mejores métodos para manejar familias que no están articuladas. E incidentalmente, no todas esas familias provienen de la clase baja; hay familias de la clase media que no son muy articuladas, aunque de una manera distinta.

Dr. Canevaro: —Utiliza usted otras técnicas que descansan menos en el lenguaje?

Dr. Zuk: —Bien; yo pienso que puedo, pero no de la misma manera que otros colegas. Por ejemplo, yo no uso psicodrama o baile o música, aunque esto tiene un lugar en terapia familiar como en otras terapias. Personalmente me sentiría incómodo aunque pienso que yo uso mucho más la *comunicación no verbal* para influenciar familias. Lo que nosotros aprendimos en la década del 60 es que la terapia familiar para la mayoría de nuestras familias, es básicamente un método a corto plazo. Corto plazo significaría que la mayoría de las familias terminan después de 6 meses o menos de encuentros semanales. La terapia a corto plazo ha probado ser exitosa, especialmente con familias pobres, pero también muchas familias de clase media la toleran muy bien y obtienen beneficios de ella. La década del 60 mostró también la importancia de la intervención de la crisis. Los defensores del trabajo a largo plazo sufrieron un revés en esta década, aunque ellos continuaron hacien-

do interesantes contribuciones en el campo de la teoría con casos seleccionados. El cambio de personalidad no es un objetivo para la gran mayoría de los terapeutas de familia que trabajan hoy. Nosotros aceptamos objetivos más modestos, tales como: perfeccionamiento del funcionamiento, deducción de los síntomas, disminución de la tensión. Por supuesto, a nosotros nos complace cuando un miembro adquiere conocimiento y lo usa constructivamente. En cuanto a lo que a la década del 70 le concierne, yo veo aparecer un nuevo problema y pienso que esto tiene que ver con el éxito de esta disciplina. Lo que pasó en los últimos años es que un gran número de profesionales de la salud mental y paraprofesionales están interesados en adquirir competencia en terapia familiar.

Dr. Canevaro: —Tengo entendido que hay alrededor de cuarenta mil en USA.

Dr. Zuk: —Yo no sé el número exacto. Eso debería ser una aproximación del número seriamente interesado en el campo, eso es, siguiendo seriamente la literatura y persiguiendo algún nivel de instrucción. Yo diría que el número de ellos completamente preparados para la práctica independiente es substancialmente menor, pero igual serían unos cuantos miles.

Dr. Canevaro: —¿Varios miles?

Dr. Zuk: —Varios miles, a lo mejor unos cinco. Ahora nosotros tenemos conferencias a cada momento del año en USA y en el extranjero, y mesas de trabajo. Los primeros textos están apareciendo en el campo (no completamente satisfactorios porque nosotros somos todavía jóvenes, demasiado jóvenes para un mejor tipo de texto). Estamos rezagados en evaluaciones profundas de las teorías prominentes existentes. Esto es la más seria deficiencia, porque hay demasiadas teorías y demasiadas técnicas, que gozan de popularidad pero no han sido vigorosamente chequeadas. Y es por eso que la persona joven que ingresa en el campo, tiende a estar un poco confundido. La necesidad más apremiante es la de aplicar standards precisos de evaluación. Hay cierto peligro también en la proliferación de los institutos y asociaciones de entrenamiento en terapia

familiar, los cuales están creciendo rápidamente ahora, ya que eso tiende a distraer la atención de la necesidad apremiante de una mayor y más adecuada evaluación e investigación. Los centros de entrenamiento, en general, no hacen investigación ni evaluación. Sobre aquellos individuos que han hecho los más grandes aportes en este campo, hay una responsabilidad especial para evaluar tan objetivamente como sea posible sus criterios, pero ha habido un desgano para hacer esto exhaustivamente. Tal vez esto es natural. Yo no estoy en contra de la producción de terapeutas de familia en gran cantidad, pero sí estoy en contra de la desproporción con los que están interesados en ensayar hipótesis, teorías, conceptos y técnicas. Si mis colegas terapeutas de grupo de USA me perdonaran, yo les diría que espero que la terapia familiar pueda evitar el dilema del grupo terapéutico debido, en mi opinión, principalmente a la rápida producción de terapeutas de grupo sin un crecimiento concomitante en la teoría, técnicas, investigación y evaluación.

Nosotros debemos hacer lo posible por conservar un balance creativo entre las dos fuerzas: el desarrollo de los practicantes competentes, y el desarrollo y comprobación de la teoría y el método.

Esa es la razón por la cual yo estoy encantado con su nueva revista en Argentina y en el desarrollo de nuevas publicaciones en USA, tales como mi *International Journal of Family Therapy*.

Dr. Canevaro: —Es una ardua tarea.

Dr. Zuk: —Así es; todos nosotros sabemos lo ardua que es. Pero es algo absolutamente necesario: la expansión de publicaciones que alienten la teoría, la investigación y la evaluación de métodos.

Dr. Zuk: —Yo lo acepto como una realidad en USA. La *Terapia familiar* es practicada por profesionales de todas las disciplinas de salud mental, pero nosotros también tenemos un gran número de terapeutas muy capaces no entrenados originalmente en salud mental, tales como clérigos y un número substancial de los llamados para-profesionales, algunos de los cuales no deben, incluso, haber ido al colegio secundario ni a la Universidad pero que obviamente tienen buenas aptitudes para el trabajo, que están sumamente motivados y aprenden rápidamente con una supervisión compe-

te motivados y aprenden rápidamente con una supervisión competente en las facilidades de la salud mental.

Dr. Canevaro: —¿Usted piensa que estamos asistiendo a una nueva revolución en el mundo psiquiátrico?

Dr. Zuk: —La terapia familiar ha contribuido a una nueva forma de pensamiento sobre la causalidad en las enfermedades psiquiátricas, y es un acercamiento innovador en el tratamiento de problemas que son o deben ser específicamente psiquiátricos. No es revolucionaria en el sentido que quiera destruir la institución de la familia simplemente porque la interacción familiar es a menudo una contribución directa a la enfermedad psiquiátrica, no es anti-familia o anti-psiquiatría. La mayoría de los terapeutas de familia que yo conozco están a favor de la continuación de las familias, matrimonio y así sucesivamente, a pesar del hecho que ellos deben lidiar con familias y matrimonios caóticos y desorganizados. Nuestra orientación general, yo pienso, es la de preservar la familia. Debe haber unos pocos que opinen de manera diferente. Yo diría que básicamente nosotros somos trabajadores relativamente conservadores, que creemos profundamente en la necesidad de la continuidad de la vida familiar. Yo no trato de imponer mis valores sobre las familias que veo, porque sé y reconozco que si tratara de hacerlo, a menudo sería rechazado. Yo realmente trato de trabajar con las intenciones positivas y los valores positivos y constructivos. Creo que para ser un terapeuta eficaz debo trabajar dentro de la estructura de valores de la familia y no tratar de imponer mi propia tendencia.

Dr. Canevaro: —¿Qué es lo que ve usted para la terapia familiar en el futuro? ¿Cómo la compararía con la terapia individual?

Dr. Zuk: —Nosotros sabemos que es efectiva en un número substancial de casos. La mayoría de los terapeutas de familia creen que ella es una fuerza poderosa para usar, no justamente cuando la terapia individual ha fracasado o como un aditamento de ella (aunque puede ser usada así). Es un tratamiento de elección cuando la familia puede ser movilizada a participar con el llamado paciente identi-

D. Rubinstein, Gerald Zuk y Alfredo A. Canevaro

tificado en un tratamiento continuado de fondo. Yo creo que esta clase de "cura" debería ser comparada favorablemente con las otras psicoterapias más conocidas; y digo esto, reconociendo la deficiencia de los estudios comparativos de evaluación.

Dr. Canevaro: —Muchas gracias, fue muy interesante.

LIBROS

TERAPIA FAMILIAR INTENSIVA

Ivan Boszormenyi - Nagy y James L. Framo

Editorial Trillas, México, junio de 1976; 569

páginas. Traducido por Francisco González

Aramburo.

Continuando con el comentario de este sustancioso libro que avanza en la consideración de los tópicos más inquietantes para los terapeutas del grupo familiar, luego de los primeros capítulos teóricos y técnicos de la terapia familiar y sobre la génesis de la enfermedad emocional de la familia, entraremos ahora a temas más específicos como indicación y contraindicación, transferencia y contratransferencia, mistificación de la experiencia y enfermedad mental, aportes interdisciplinarios de dos observadores antropólogos

posibilidades de investigación sistemática de la dinámica familiar y por último, la opinión de un psicoanalista individual con amplia experiencia en el tratamiento de la esquizofrenia, sobre la terapia familiar y el fenómeno de las relaciones familiares.

En el Capítulo 7 LIMAN C. WYNNE nos introduce en el tema de las indicaciones y contraindicaciones de la terapia familiar. Ante todo nos dice que resulta adecuada en general para el esclarecimiento de las dificultades en las relaciones familiares con respecto a

los patrones de transacción inmediatos y actuales en las interacción recíproca de los miembros de la familia, a los cuales cada uno contribuye colusiva o abiertamente, especialmente cuando todos tienen un interés vital y continuo, tanto a nivel consciente como inconsciente. Es decir, que la terapia familiar resulta indicada en todos aquellos casos en que la problemática envuelve a los miembros del grupo familiar. El grado de involucramiento puede evaluarse mediante entrevistas familiares diagnósticas.

Wynne menciona sólo dos contra-indicaciones generales:

1) Cuando se establece una relación terapéutica intensa con un paciente, sin haber existido contacto previo con su familia, tanto el terapeuta como el grupo familiar encontrarán dificultades si se intenta cambiar el foco de atención dirigiéndolo hacia los patrones generales de la familia y a los problemas compartidos.

2) Tampoco es indicado emprender la terapia familiar cuando las sesiones de evaluación indican que el problema no tiene significado emocional y conductal, ni consecuencia actuales para los miembros de la familia.

En cambio, particulariza situaciones familiares concretas donde resulta indicada la terapia familiar intensiva:

—Cuando surgen problemas a raíz de la separación de los adolescentes de su familia en relación a consolidación de la identidad, como ser, episodios esquizofrénicos, actuaciones rebeldes o delictuosas, incapacidad de liberarse de una relación simbiótica; la terapia familiar resulta adecuada cuando los padres comparten la ambivalencia y confusión del adolescente o cuando

existen relaciones simbióticas mutuamente intrusivas.

—Cuando existe intercambio de disociaciones en el sentido que la concepción fija que cada persona tiene de la otra es intercambiada inconscientemente por una concepción fija que de ella misma tiene la otra persona. Son procesos profundamente inconscientes al servicio de que cada individuo pueda proyectar y lidiar con ideas y sentimientos que de otra manera le resultarían intolerables.

—En los casos de caos cognoscitivo colectivo y distanciamiento errático en donde todos los miembros de la familia parecen estar atrapados en esta comunicación caótica, que es el "síntoma" de su patología familiar. Les ha sido imposible apartarse de este caos, comentarlo, interrumpirlo de algún modo útil. Tienen estilos muy erráticos e inestables de relacionarse y de establecer la "distancia" adecuada entre unos y otros.

—En las familias con un distanciamiento fijo con amenazas y episodios violentos. Estas relaciones familiares se caracterizan por una fijeza implacable de la distancia en las relaciones afectivas así como por una perseverancia rígida en la organización de los pensamientos y de las percepciones.

—En los casos donde existe una comunicación amorfa, vaga, no dirigida; especialmente en las familias de los llamados esquizofrénicos simples, pero ese tipo de comunicación no es solamente privativo de estas familias.

Entre los factores que afectan la implementación de estas indicaciones menciona:

—La disponibilidad física y psico-

lógica para tratarse de la constelación familiar necesaria, es decir de aquellos que mantengan una red de relaciones continuas y significativas emocionalmente.

—La fase del proceso psicoterapéutico total en que se emprenda la terapia familiar conjunta.

—Las características de los terapeutas de familias disponibles.

Los casos de indicación específicamente señalados corroboran el concepto de Wynne de que la problemática a tratarse en la terapia familiar intensiva debe ser aquella que involucra inmediata y actualmente a todos los miembros incluyendo las dificultades de consolidación de la identidad de un individuo cuando estén relacionadas con dificultades familiares.

En el Capítulo 9 CARL A. WHITAKER, RICHARD F. FELDER y JOHN WARKENTIN se refieren a la "contratransferencia en el tratamiento familiar de la esquizofrenia" como al necesario involucramiento afectivo del terapeuta en el proceso de curación que asume características muy particulares de intensidad y de riesgo en la terapia familiar.

Cuando acepta a la familia como paciente, el terapeuta comienza a poner al descubierto los residuos inmaduros de su propia persona. El terapeuta debe poner en juego aquellos patrones defensivos interrelacionados firmemente, que estuvieron asociados con su propio ambiente familiar original y no sólo los relacionados con sus padres considerados individualmente.

Definen la contratransferencia como los sentimientos deformados del terapeuta. No sólo los contrasentimientos que surgen en él respecto de los senti-

mientos de transferencia procedentes de la familia que es su paciente, sino también aquellos que provienen de los subgrupos que existen dentro de la familia y además aquellos que surgen en el terapeuta y tienen que ver con su transferencia directa.

Los autores señalan acertadamente que a pesar del empleo convencional del término contratransferencial, tal vez la mayor parte del afecto deformado que se observa en el terapeuta debería denominarse transferencia pues está volviendo a vivir las primeras experiencias de su vida en un sentido que le resulta imposible en su análisis o aún en su hogar actual. "Tiene la idea de que esta familia es la suya, la tentación de entregarse al acting out es prácticamente irresistible". "Todo terapeuta es desde el punto de vista dinámico, el producto de las deformaciones de otra familia, su propia familia de origen".

Los patrones más comunes de contratransferencia que viven los terapeutas en la terapia familiar intensiva pueden ser:

—La identificación positiva con el paciente.

—Asexualizar al hijo esquizofrénico esquivando cualquier afecto sexual de contratransferencia.

—El terapeuta puede tender a volverse autodestructivo, como si aceptase el código del paciente, que lo lleva a ser víctima, tal como el paciente lo es para la familia.

—El terapeuta puede desarrollar patrones de contratransferencia que tienen que ver con su propia identificación con la madre.

—La contratransferencia puede generar patrones negativos de tensión en el terapeuta; tal vez simplemente

estorben su función o puedan desarrollarse hasta tal punto que lo resuelva mediante una explosión de afecto en el ambiente familiar.

—Puede pasar de un bando a otro en virtud de una especie de transferencia alternante, que no solamente lo impide percatarse de su involucramiento, sino que tampoco le permite ser un buen terapeuta.

Tiene que estar "en" la familia y sus subgrupos, pero no debe ser "de" la familia y sus subgrupos. Debe estar a disposición de cada persona de la familia, pero no pertenecer a ninguna; debe pertenecerse a sí mismo. Para mantener su condición de entidad separada, a lo largo del proceso terapéutico, el terapeuta tiene que evitar no sólo el problema de contratransferencia consistente en un involucramiento excesivo, sino también el problema del aislamiento. Como prototipo, tiene que ser parte del grupo, tiene que estar envuelto, pero no obstante, debe procurar que no se lo traguen las arenas movedizas.

Para ayudar a resolver la contratransferencia recomiendan las técnicas siguientes:

—Mantener una visión general de la familia.

—Fluidez y fuerza para entrar y salir de la situación familiar.

—Abandono deliberado de la iniciativa en las sesiones; esta clase de retirada es a veces, muy claramente, un rechazo de toda la situación y, como tal, puede provocar patrones de tensión que luego tendrán que atenderse.

—Retirarse hacia su relación con otro terapeuta del equipo o con el coterapeuta.

La familia es más poderosa que el

terapeuta. En entrenamiento le permitirá participar de la situación familiar y en su modificación sin verse aplastado por su fuerza y sin tratar de utilizar al grupo para sí mismo.

En el Capítulo 9 RONALD D. LAING aborda un artículo teórico que titula "Mistificación, confusión y conflicto". Partiendo del concepto de Marx, cree que es posible su aplicación al campo de la interacción recíproca de personas y específicamente a las relaciones familiares. Llama a la mistificación a una de las maneras de lidiar con las contradicciones en la familia. Se refiere no sólo al "acto" de mistificar, en sentido activo, confundiendo, ocultando, enmascarando lo que ocurre, sino también al "estar" mistificado, en sentido pasivo, que es el sentimiento de estar confundido o enredado, que no necesariamente se experimenta como tal. Puede o no inducir conflictos secundarios y éstos pueden ser reconocidos o no por las personas afectadas. El sentimiento de confusión y la experiencia de conflicto son diferentes de la mistificación como acto o como estado. Los efectos enmascaradores de la mistificación tal vez no eviten el conflicto, aunque sí impedirán que se vea con claridad cuál es el motivo del mismo. La persona mistificada está confundida por definición; pero tal vez no se sienta así; no advierte el conflicto auténtico, pero puede o no experimentar un conflicto intra o interpersonal auténtico.

La mistificación implica la acción de una persona sobre la otra, es transpersonal. Debe diferenciarse de los mecanismos de defensa y de las diversas formas de "mala fe" en el sentido de Sartre. Llega a su extremo culminante

cuando induce confusión en el otro en que respecta a la totalidad de su experiencia (memoria, percepciones, ensueños, fantasías, imaginación), de sus procesos y acciones. Su experiencia y sus acciones se interpretan por lo general sin referencia a su propio punto de vista. Existe una incapacidad radical de reconocer la propia percepción de sí mismo y la identidad que sí mismo se le atribuye. No sólo su identidad y percepción de sí mismo quedan confundidas, sino que sus percepciones de los demás, de cómo lo experimentan y actúan con respecto a él, y de como cree que piensan que piensan él, etc., están necesariamente sujetas a mistificaciones múltiples a un mismo tiempo.

La función de la mistificación parece consistir principalmente en el mantenimiento del status quo, de los papeles estereotipados. Parece ser una técnica muy desarrollada en familias de esquizofrénicos.

Laing opina que antes de emprender una acción atinada, hay que desmistificar las cuestiones. El eje de orientación de investigadores y terapeutas consiste en establecer cuáles son los ejes de orientación y las cuestiones para cada miembro de la familia, explícitas e implícitas. A fin de reconocer personas y no meramente objetos, tendrán que darse cuenta de que el otro ser humano es otro centro de orientación hacia el mundo objetivo. Teniendo en cuenta que la mistificación activa consiste en difrazar o enmascarar la praxis y/o los procesos de la familia, en confundir las cuestiones y tratar de negar que lo que es la cuestión para uno mismo tal vez no lo sea para el otro, la cuestión esencial del terapeuta

y, al mismo tiempo, su salvaguarda, es presentar las perspectivas de cada uno, incluyendo las propias, en lo que hace a la situación compartida y luego comparar las pruebas de la validez de los diferentes puntos de vista que existan.

En el Capítulo 10 ANTHONY F. C. WALLACE y RAYMOND D. FOGELSON, dos antropólogos, observadores que participaron del programa del Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, llamaron "Lucha por la identidad" al contenido manifiesto de los conflictos verbales de la terapia familiar que conforman una disputa acerca de qué clase de persona es cada uno de los participantes; cada persona desempeña alternadamente los roles de agresor y defensor, acusando a veces al otro de poseer alguna característica indeseable, otras veces defendiéndose de toda crítica a su propio carácter. Parece tratarse de algo más que de expresiones de deseos libidinales; aunque dependan de ellos para su origen, se convierten en procesos transaccionales cuasiautónomos. La tendencia de los participantes a defenderse de las acusaciones de que no valen nada, remite a que lo está en juego es la autoestima.

La formación de la identidad depende tanto de la autoevaluación, como de la comunicación interpersonal. Los individuos emplean técnicas para reducir la disonancia entre la identidad real y la ideal y para elevar al máximo la disonancia entre la identidad temida y la real; en la medida en que los mecanismos de defensa internos no basten, el individuo tiende a actuar exteriormente para obtener de los demás una comunicación que reduzca o aumente la disonancia.

Sócialmente la lucha por la identidad

parece estar regulada como una negociación entre las partes que conduzca a una estructura de equivalencia, en cuyo defecto la tensión excesiva causará trastornos psicosomáticos, daño cognoscitivo y emotivo, retraimiento social o violencia destructiva.

En las sociedades primitivas se evita la confrontación directa de identidades. En todo caso se permiten luchas formalizadas por la identidad acompañadas de una etiqueta altamente ritualizada.

En la sociedad moderna la cultura autoriza esta lucha entre las partes contendientes ante un tribunal, entre psicoterapeuta y paciente y de algún modo en la familia nuclear. Además algunas situaciones son redefinidas como juegos, entrenamientos, competencias deportivas, bromas.

En la lucha latente por la identidad, en contraste con la lucha manifiesta, los participantes no pretenden ni desafían abiertamente de manera verbal; más bien alimentan pretensiones privadas y menosprecios silenciosos por los otros. Las luchas manifiestas nacen de la situaciones de lucha latente. A juicio de los autores, el problema técnico de la terapia familiar consiste en hacer manifiesta la lucha latente por la identidad, resolviéndola antes de que la lucha misma destruya a la familia y dañe a uno o más de sus miembros. El terapeuta interpretará y pondrá las reglas que circunscriben el conflicto y definen los canales de expresión permitidos. El mismo grupo tiene que llegar a un arreglo conveniente para todas las partes por acuerdo mutuo de identidades o, no siendo posible, por acuerdo para disolver el grupo.

Los modelos que existen en la

sociedad contemporánea para este proceso son el método de la conferencia y el psicoanálisis.

En el Capítulo 11 JAMES L. FRAMO aborda el problema de la "Investigación sistemática de la dinámica familiar. Su postura es que solamente un conocimiento prolongadamente íntimo de la familia, basado en la observación de teorías y una investigación sistemática, nos permitirán hacer descubrimientos realmente importantes acerca de la dinámica familiar. A pesar de los intentos realizados en investigación de pequeños grupos y algunos directamente con familias, todavía subsisten muchos problemas y cuestiones fundamentales con respecto a la investigación sistemática, como ser las ventajas y desventajas de los informes directos e indirectos que dan los miembros de la familia acerca de sí mismos; cómo llegar hasta el corazón emocional del proceso familiar; la resistencia de la familia a revelar su funcionamiento interior ante extraños; los problemas de observación directa, muestreo y medición de la interacción bajo la influencia de un observador; la cuestión del contenido manifiesto en relación al latente; el problema de los metamensajes y las dificultades que presenta el penetrar los aspectos inconscientes y transaccionales del sistema familiar.

Las familias no son cualitativamente semejantes a otros grupos con los cuales se intentó comparárlas; la investigación familiar deberá orientarse al sistema y no al individuo; no se podrá confiar en lo que dicen los miembros respecto a sí mismos o de otros miembros en cuestionarios; aparte de la observación directa, el uso de otros métodos puede dar resultados engañosos; el prestar

atención solamente a los niveles patentes de la interacción revela muy poco del funcionamiento interior de la vida familiar.

Cuando se pregunta cómo revelar la dinámica profunda de la familia, dice que en el caso de los individuos, se pone de manifiesto en los pensamientos marginales, en los deslices verbales, los sonrejos, los momentos en que se está desprevenido, los bloqueos, el hablar demasiado, las ideas "tardías" que rápidamente se niegan, y en todos los signos clásicos de la resistencia. En el caso de las familias, se descubren, en gran parte, en las resistencias del sistema, en la renuencia a sacar los "trapos sucios", la protección de los intereses creados, las fidelidades, las alianzas secretas, la charla vacía o en la estridencia empleada como defensa familiar. Dentro de ciertos límites, pueden descubrirse dimensiones importantes hasta en la conducta manifiesta, cuando se contemplan patrones o estructuras totales. A causa de la resistencia a la revelación y al cambio y debido a la amenaza de pérdida de relación, la información más importante y significativa acerca de las familias es la más difícil de obtener.

Nos encontramos lejos de la manipulación experimental de las variables importantes de la vida familiar en toda su complejidad y magnitud, aunque algunos aspectos quizá puedan enformarse bien en el laboratorio. Fenómenos transpersonales, como las situaciones de doble ligadura, la colusión inconsciente, pseudomutualidad, sistemas de fantasías inconscientes compartidos, complementariedad de papeles, estructuras de sentimientos interconectados requieren aún una auténtica

exploración sistemática. Inclusive se puede cuestionar la validez de ciertos estudios de la interacción porque en definitiva no nos dicen mucho sobre la misma. A medida que el conocimiento de la dinámica familiar sea más claro, disminuirán los intentos de investigación de pseudoproblemas.

La situación de tratamiento familiar es la mejor aproximación posible a la dinámica familiar; en el transcurso del desarrollo de los sentimientos de transferencia, las variables significativas de la dinámica familiar surgirán espontáneamente, mientras se observa la interacción a largo plazo entre los miembros de la familia.

En el Capítulo 12 HAROLD F. SEARLES vierte su opinión crítica como psicoanalista individual sobre "Las contribuciones del tratamiento familiar a la psicoterapia de la esquizofrenia".

Nos advierte sobre el peligro de simplificar la lectura del discurso del grupo familiar obviando la diferencia entre procesos intrapsíquicos y procesos interpersonales.

Nos dice que los miembros de la familia del esquizofrénico ignoran la existencia de este reino de contenido intrapsíquico proyectado (e introyectado), desconocen también la existencia de fronteras entre lo intrapsíquico y lo auténticamente interpersonal, ignoran que no están reaccionando primordialmente ante las otras personas del grupo como reales sino como si fueran personificaciones de imágenes de sí mismos reprimidas y proyectadas. El terapeuta es el que tiene que estar alerta entonces a la presencia de estos reinos separados. La terapia familiar ofrecería la posibilidad de una confrontación del mundo

interno y externo correctora de las deformaciones de las introyecciones y proyecciones de la constitución del mundo interno que inciden en las relaciones interpersonales.

En estas familias particularmente, la cuestión de la "membrecía" no es algo biológicamente dado, sino que ha de mantenerse sólo a través de la simbiosis familiar. Al paciente desde siempre se le ofrecieron sólo dos posibilidades: participar de la simbiosis familiar o perder su membrecía en la familia y ser tratado como si estuviese "loco". Mucho antes del comienzo de su psicosis, el paciente se ha debatido bajo la amenaza crónica de expulsión psicológica de la familia, en caso de que decidiese no cumplir su papel de personificación de los aspectos parciales rechazados de las personalidades de sus padres y de otros miembros de la familia.

TENDENCIAS EN LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

Bertalanffy, L. von., Ashby W. Ross, G.M. Weinberg y otros.

Selección y prólogo de George J. Klir. Alianza Editorial. Madrid. 1978.

Cuando en el amanecer de la historia las fuerzas caóticas e incomprensibles que gobernaban un mundo hostil e incontrolable pudieron ser definidos y clasificadas, surgió una nueva forma de pensamiento que hoy llamaremos Ciencia. La previsibilidad de ciertas regularidades posibilitaron pensar el mundo empírico como un orden o kosmos inteligible y por ende controlable por el pensamiento y la acción racional.

Desde este punto de vista la historia de la Ciencia puede realizarse

El análisis individual deja un sector de sentimientos orientados a la familia como totalidad comparativamente inexplorado, reprimido, y, según Searles, tiende a hacer su aparición en forma de reacciones de contratransferencia cuando tratamos de llevar a cabo la terapia familiar.

Este capítulo nos presenta un punto de vista orientado mucho más hacia lo intrapsíquico que hacia el sistema familiar en sí. Y nos deja muchos elementos para pensar acerca de las características peculiares de la terapia familiar.

Este libro es realmente uno de los escasos materiales en lengua castellana que nos ofrece un panorama, en extensión y en profundidad, sumamente rico de los desarrollos de la terapia familiar en la actualidad.

Stella Maris Molina

a partir de sistemas más o menos lógicos de definiciones y clasificaciones que caracterizan determinados períodos de su evolución. Tal punto de vista y tales sistemas, sin embargo, pertenecen a períodos mucho más recientes. La Ciencia surgió sin que quienes la hicieron posible tuvieran mayormente conciencia de lo que la define y sin que la distinción de sus límites con otros modos de pensamiento fuera considerada imprescindible. Es en esta trayectoria donde se inscribe la noción de *sistema*.

regulaban su crecimiento.

Esta postulación es fundamental ya que permite resolver el problema planteado por la contradicción entre entropía y evolución. En un sistema cerrado el grado de entropía crece positivamente. La existencia de procesos irreversibles —propio de los sistemas cerrados— acarrea una constante y progresiva destrucción del orden. En los sistemas definidos como abiertos, puede pensarse el desarrollo en la dirección de un incremento del orden y la organización.

De aquí que el modelo propuesto desde una teoría de sistemas abiertos permita pensar conjuntos como el que constituye un grupo familiar en los cuales la patología no necesite ser definida como producto o consecuencia de procesos entrópicos.

La búsqueda de un marco teórico para el estudio de procesos reversibles condujo —de manera a veces independiente— al sorprendente hecho de que en diferentes campos aparecieron puntos de vista semejantes. La necesidad de tomar en cuenta conjuntos de variables en interacción —sobre todo en los casos donde se hacía evidente que el estudio de los elementos no permitía explicar el comportamiento del conjunto—, y la imperiosidad de contar con modelos que hagan posible el análisis de fenómenos que se encuentran en una relación dinámica con el contexto en el que ocurren, condujo a un fructífero intercambio entre físicos, químicos y biólogos. Intercambio que se tradujo en replanteos epistemológicos y en la aparición de nuevas disciplinas de las

Si bien el uso de la noción de sistema es muy antiguo —Von Bertalanffy la remonta a Aristóteles— su definición e inserción en un campo teórico continuó siendo hasta hace muy poco una cuestión intrascendente sin que, quienes la utilizaron tuvieran idea de sus alcances.

Es muy reciente la intención de incluir el concepto de sistema en forma rigurosa y radical en el terreno del pensamiento teórico y más aún el intento de aplicarlo al estudio y la investigación en el ámbito de las ciencias biológicas y culturales.

El problema radicaba en la imposibilidad de dar cuenta de sistemas definidos como "abiertos", esto es, aquellos en los que el grado de entropía parecía disminuir con el desarrollo de los procesos que permitían su subsistencia. En otros términos, donde la "organización" del conjunto se mantenía en virtud de la existencia de procesos de intercambio, alcanzando lo que se dió en llamar "equilibrio dinámico".

Hasta donde llegan nuestros conocimientos, fue R. Defay quien planteó por primera vez la posibilidad de encarar en forma científica el estudio de los sistemas abiertos, y fue en el campo de la termodinámica ("Introduction a la thermodynamique des systems ouverts" Acad. Roy. de Belgique, Bull. des Sciences, 1929). Unos años más tarde —en 1932— Ludwig von Bertalanffy introduce el mismo concepto en biología, enfatizando la necesidad de una extensión de la teoría físico-química de los sistemas abiertos si se quería dar cuenta la supervivencia de los organismos vivos y de las leyes que

cuales la ecología, la cibernética, la teoría de los juegos y la teoría de la información, no son sino algunos ejemplos. Pero, lo que conviene destacar aquí es que la misma tendencia pudo ser registrada en relación a la aparición de teorías gestálticas y estructurales en el campo de la historia, la psicología, la antropología, la lingüística, la economía, etc.

Estas investigaciones convergentes permitieron arribar a la conclusión de que existen modelos, principios y leyes aplicables a sistemas diferentes con independencia de la naturaleza particular de sus componentes. Pareció legítimo postular la posibilidad de desarrollar una teoría válida, no ya para una determinada clase de sistema, sino una teoría cuyos fundamentos tuvieran un grado tal de universalidad que pudieran ser aplicados a los sistemas en general.

Y son estos los fundamentos de la llamada "Teoría General de los Sistemas", (o Teoría de los Sistemas Generales, como en algunas traducciones se la denomina), cuyo germen puede rastrearse en una tesis doctoral que en el año 1925 redactara un flamante biólogo alemán: Ludwig von Bertalanffy. Ha pasado ya medio siglo desde entonces. La bibliografía sobre el tema es a esta altura abundante y diversa, pero, sus versiones españolas hace poco han comenzado a aparecer. La Editorial Alianza ha logrado reunir en un volumen diez trabajos que constituyen actualizaciones del estado de la teoría en los diferentes campos en los que ha sido desarrollada.

La selección y el prólogo ha sido realizada por George J. Klir, quien

ha intentado una integración de los enfoques surgidos en las últimas décadas tendiente a la formalización de la teoría. Su visión de la teoría general de los sistemas es descripta en el Capítulo 7 ("Sobre un enfoque de la teoría general de sistemas") por Robert A. Orchard, pero en el prólogo, bajo el título de "Teoría polifónica general de sistemas" intenta una puesta al día de las diferentes tendencias, las innovaciones que esta teoría ha introducido en el terreno de la ciencia contemporánea desde su aparición, y el lugar que en su marco cada una de las versiones le adjudica: de esta manera, en tanto para Mesarovic y Wymore (cuyos trabajos no figuran en esta compilación) es una teoría formal edificada jerárquicamente a partir de la definición axiomática de relaciones arbitrarias en una colección de conjuntos abstractos, para Klir es una profesión y una ciencia en construcción. Bertalanffy (en el capítulo 1) y Churchman (en el epílogo) la conciben como una *forma de pensar* que ha logrado definir un nuevo paradigma científico en contraposición al paradigma newtoniano imperante hasta fines de siglo. Weinberg (en el capítulo 4) la considera una *manera de mirar al mundo*, una herramienta educativa tendiente a lograr una simplificación óptima de su complejidad. Esta perspectiva es compartida por Ashby (en el capítulo 3) quien, al igual que Klir, ven en ella fundamentalmente una metodología. Löfgren (no incluido en esta compilación), partidario de la importancia de la formalización de la teoría general la define, partiendo de la lógica matemática,

como un metalenguaje.

Es que esta concepción que surgió en Alemania en la década del 20 como un mero punto de vista "organísmico" en el intento de ofrecer un programa y un método de investigación para lo que von Bertalanffy llamó "sistemas del organismo", se ha abierto hoy en un amplio abanico cuyos alcances pueden ser caracterizados como una revisión de su significado inicial y sus perspectivas.

Según el mismo Bertalanffy, los actuales desarrollos comprenden tres campos de investigación: a) el estudio de los sistemas matemáticos, tendencia que está representada en la presente selección por los trabajos de Anatol Repoport ("Los usos del isomorfismo matemático en la teoría general de sistemas") y Preston C. Hammer ("Las matemáticas y la teoría de sistemas");

b) el estudio de la tecnología de sistemas, esto es, "los problemas tecnológicos que surgen en la tecnología y sociedad modernas" (computación, automatización) y su aplicación a la resolución de problemas sociales, ecológicos, psicológicos, etc. Los trabajos de Ashby ("Sistemas y sus medidas de información"), Gerald M. Winberg ("Una aproximación por computadora a la teoría general de los sistemas") y John H. Milsum ("La base jerárquica de los sistemas generales vivientes"), son representativos de esta tendencia;

c) estudios acerca de epistemología de sistemas, que apuntan a "La reorientación del pensamiento y de la

concepción del mundo según el nuevo paradigma científico de "sistema". Corresponden a desarrollos dentro de esta tendencia los trabajos de L. von Bertalanffy ("Historia y situación de la teoría general de sistemas"), Walter Buckley ("La epistemología vista a través de la teoría general de sistemas"), Robert A. Orchard ("Sobre un enfoque de la teoría general de sistemas") y C. West Churchman ("Epílogo. El futuro del pasado. Estimación de tendencias según la teoría de sistemas").

En síntesis, "Tendencias..." constituye una puesta al día de los desarrollos más recientes de una joven ciencia cuyos límites son difíciles de circunscribir, pero cuyos alcances parecen estar lejos de ser intrascendentes con relación al futuro de la ciencia contemporánea.

Por su impacto en el campo de la psicopatología y en el terreno de las teorías acerca de las relaciones familiares y su terapéutica, este libro —de no fácil lectura— viene a sumarse a una escasa lista de traducciones de textos no circunscriptos a las áreas más matemáticas de esta teoría. Quizá la lectura previa de otra excelente versión del mismo von Bertalanffy (Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica. México. 1978) pueda ayudar a los lectores interesados y no iniciados en la comprensión de los desarrollos que "Tendencias..." propone.

J.C.N.
Julio de 1979

CONGRESOS

Terceras Jornadas de Terapia Familiar en Lyon - Francia

Desde el día 16 al 19 de mayo la Asociación Lyonesa de Terapia Familiar desarrolló estas jornadas que se caracterizaron por una excelente organización, cuyo comité ha sido dirigido por el Dr. Yves Colas.

Su sede de trabajo fue la Universidad Jean Moulin, annexe de la Doua, en la ciudad de Lyon, Francia. Las mismas se caracterizaron por una nutrida concurrencia de profesionales de diferentes ramas de la salud mental aproximadamente unas trescientas cincuenta personas.

Prosiguiendo la línea de las Segundas Jornadas de Terapia Familiar, concurrieron nuevamente varios animadores anteriores a los cuales se sumaron nuevos especialistas de diferentes puntos de Europa -Francia, Suiza, Italia, Noruega, Yugoslavia (cuyo representante no pudo hacerse presente)- Bélgica, y como figura especialmente invitada la Dra. Kitty Laperriere (USA).

Se pudo ver allí como la Teoría de los Sistemas y la Teoría de la Comunicación tienen un predominio en el enfoque terapéutico de los animadores, varios de ellos con una formación previa en distintos centros norteamericanos, tales como el Ackerman Institute, Child Guidance Clinic of Philadelphia, Escuela de Palo Alto, el Servicio que dirige el Dr. Boszormenyi-Nagy en Philadelphia. Se puede ver de esta manera un intercambio importante de especialistas americanos con los profesionales que dictaron sus diferentes "ateliers". En estas

jornadas lyonesas de Terapia Familiar, como figura principal disertó para todos los concurrentes la Dra. Kitty Laperriere, Directora de Enseñanza del Ackerman Institute (New York) tocando puntos generales e informativos de la Terapia Familiar, abordaje y técnica y formación del terapeuta familiar.

Dentro de los temas abordados por los especialistas mencionará "Ateliers" sobre parejas, Formación de Terapeutas, Intervenciones paradójales, Familias simuladas y Formación de Terapeutas, comunicación no verbal, crisis en la familia, Teoría de la comunicación y Teoría de los sistemas.

Mencionaré al Dr. Reinaldo Perrone, psiquiatra argentino radicado en St. Etienne (Francia) que trabajó en su Atelier sobre la Función del Síntoma dentro del Sistema Familiar, y al Dr. Luc Kaufman, Profesor Asociado, Coordinador de Terapias de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Laussane (Suiza), el cual trabajó sobre Terapia Familiar y el Hospital Psiquiátrico.

Para concluir este breve comentario mencionaré que en la última jornada la atención se centró sobre la formación de la Sociedad de Terapia Familiar Francesa y la publicación de una revista de la especialidad en lengua francesa, quedando todos estos proyectos en estudio para ser concretados en próximas reuniones.

Dr. Luis A. Albormoz

Segundas Jornadas Rosarinas de Terapia Familiar

En la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina), los días 5, 6 y 7 de julio de 1979 se llevaron a cabo las "II Jornadas Rosarinas de Terapia Familiar".

El propósito que guió la realización de las mismas fue el de que sirvieran para que se visualizase el "momento conceptual" que atraviesa el "ambiente psicoterapéutico" argentino respecto de la noción de grupo primario o familiar.

Asimismo, resulta claro el por qué se vio la necesidad de concertar un encuentro de esta naturaleza, como lo expuso el Coordinador General (Dr. Fidel Lebensohn) en sus palabras inaugurales.

Con el fin de mostrar el desarrollo de las Jornadas exponeremos el Programa al que acotaremos con notas con las que se pretende señalar cuáles fueron los momentos privilegiados de las mismas.

Comisión Organizadora:
Coord. Gral. Dr. Fidel Lebensohn.
Dr. Rubén Makiniştian
Dra. Elena K. de Lebensohn
Dr. Samuel Katz
Dr. Ernesto Rathge
Dr. Abel Specter
Dra. Alicia Beatriz de Palou
Dra. Berta Benitez de Nale
Dra. Laura Grinberg de Ottado
Dra. Ma. Cristina Cassani de Joaquín
Dr. Carlos Mahuad

Día 5: 9 hs. Panel "Terapia de Pareja"
Dra. Celia Elzufan
Dr. Luis Juri
Dr. Fidel Lebensohn
Dr. Juan Carlos Nocetti
Moderador: Dr. Abel Specter

Secretaria: Dra. Berta Benitez de Nale

14,30 hs. Ateliers:

"Terapia de Pareja. Método de trabajo": Dra. Celia Elzufan; "Pautas de interacción en la pareja": Dr. Luis Juri; "Una pareja en transacción psicótica": Dra. Elena K. de Lebensohn y Dr. Fidel Lebensohn.

18 hs. Mesa Redonda A

Coordinador: Dr. Carlos Mahuad
"Terapia de pareja: experiencia de una pareja en coterapia": Dra. Elena K. de Lebensohn
"El proceso terapéutico": Dr. Eduardo Mandelbaum

Mesa Redonda B

Coordinador: Dr. Ernesto Rathge
"Aspectos teóricos del encuentro de la pareja desde el psicodrama psicoanalítico": Dra. Raquel H. de Augustovski y Dr. Roberto Yañez
"El síntoma revalidado": Dr. Rubén Makiniştian

Comentarios

La labor del Panel quedó sintetizada en lo que se planteó como sustrato a partir del cual justificar la labor terapéutica: "escuchar con el corazón" y "atender la solicitud de efectividad terapéutica, planteada por los pacientes". Sustrato que se consolida a partir de los planteos de los panelistas y la respuesta con la que el público asistente correspondió a aquellos, interpretándose la validez operativa de la propuesta común de solventar las necesidades

de los que consultan a través de la contextualización diádica y sistemática de sus problemáticas.

Se hace manifiesto entonces que es necesario valorizar términos como el de "relación" e "identidad", ya que ambos refieren al individuo asociado. Nociones éstas que nos orientan hacia la investigación de las prácticas terapéuticas que sean realmente efectivas, cualquiera sea el referente teórico que las inspire: "la búsqueda del cambio" o "hacer consciente lo inconsciente"

Día 6: Panel: "Familia e instituciones Asistenciales"

Dr. Isaac Abecasis

Dr. Jean Cosme Brisou

Dr. Alfredo Canevaro

Dr. Wilburg Grimson

Dr. Reynaldo Perrone

Moderador: Dr. Samuel Katz

Secretaria: Dra. Laura Grimberg de Ottado

14,30 hs. Conferencia: "El lugar que ocupa el padre en el proceso de separación": Dr. Jean Cosme Brisou

15,30 hs. Ateliers: "Retrabajo en grupo operativo del material clínico de un hipertenso esencial": Dr. Isaac Abecasis; "Supervisión clínica": Dr. Alfredo Canevaro; "Supervisión clínica": Dr. Fidel Lebensohn; "Familia e instituciones": Dr. Reynaldo Perrone; "El tratamiento familiar del paciente esquizofrénico en una comunidad terapéutica": Dr. Juan A. Yaría.

18 hs. Mesa Redonda A

Coordinador: Dr. Abel Specter

"Familia, equipo e institución" Dr.

Eduardo Mandelbaum

"Algunas consideraciones acerca de la psicopatología y abordaje en las relaciones narcisísticas de la pareja":

Dr. José Silberstein

"Patología de la familia y la institución": Dra. María Cristina Cassani de Joaquín

Mesa Redonda B

Coodinador: Dr. Fidel Lebensohn

"Atención de la familia del paciente internado en terapia intensiva. Evaluación de nuestras dificultades": Dr. Claudio Goldini, Dra. Ana Chimenti; Lic. Mónica Moldaver (Hosp. Fernández de Bs. As.)

Comentario

Surgen, en principio, dos líneas bien definidas: la sistémica y la intrapsíquica. En primera instancia, la dinámica de la discusión lleva a concluir en la imposibilidad de amalgamar ambas corrientes. Sin embargo, el reprocesamiento de esta última conclusión, mediante una fructífera interacción entre los panelistas, permite rescatar el que, más allá de los conceptos específicos y de las referencias teóricas de cada uno, lo que interesa subrayar es lo que dió coherencia al trabajo ya que representó el punto de confluencia o, si se quiere, de coincidencia, y que puede expresarse así: "Se cura por lo que se es".

Día 7: 8,30 hs. Panel: "Familia: Niñez y Adolescencia"

Dr. Jean Cosme Brisou

Dra. Raquel Hojman de Grimaldi

Dra. Estrella Joselevich

Dr. Reynaldo Perrone

Ottado.

"Grupo de padres": Dra. María Cristina Ravazzola

"La familia en el psicodiagnóstico de niños y adolescentes": Dr. Rolando Gianzone

"La familia del disminuido mental":

Dra. Mirta Granero

"Interacciones familiares patógenas": Dra. Nélida Saporiti.

Comentario

Este panel, por ser el último, mareó un interrogante que si bien muestra dos posiciones teóricas que son, en la práctica, antagónicas, la Terapia familiar como único abordaje en el tratamiento de niños y adolescentes por un lado, y la Terapia familiar como una técnica más en el tratamiento de niños y adolescentes, por el otro, nos remite, repensándolo, y mediante una vuelta más de la espiral dialéctica, a un cierre de las Jornadas que representó, a la par, la apertura a futuras posibilidades. ¿Qué es Terapia Familiar?

Dra. Anny Speier

Moderador: Dra. Berta Benítez de Nale

Secretaria: Dra. Alicia Betria de Palou

12 hs. Conferencia: "La familia en la psicoterapia grupal de adolescentes": Dr. Luis Frydlesky

15. hs. Ateliers: "Un niño que va a morir": Dra. Raquel Hojman de Grimaldi; "Modelo de trabajo": Dra. Estrella Joselevich; "Trabajo institucional en familia con niños y adolescentes": Reynaldo Perrone.

18 hs. Mesa Redonda A

Coordinador: María Cristina Cassani de Joaquín

"Aspectos técnicos de la terapia familiar con niños": Dra. Berta Benítez de Nale

"Familia y modelos de identificación patológica": Dra. Alicia Betria de Palou y Dra. Laura Grimberg de

III Congreso Internacional de Terapia Familiar

Tel Aviv - Israel - 1 - 5 julio 1979

Organizado por la Asociación Israelí para la Terapia Marital y Familiar.

Temas principales del Congreso:

Evolución de la terapia familiar en el mundo.

El problema del individuo en el sistema familiar.

El terapeuta familiar como persona.

Problemática y tratamiento de la pareja.

Intervención en la crisis.

Terapia familiar en la esquizofrenia.

Intervinieron entre otros: Maurizio Andolfi, Israel Charny, Samai Davidson, James Framo, Florence Kaslow, Walter Kempler, Peggy Papp y Robert Riroka.

INTERNATIONAL OF FAMILY THERAPY (IJFT)

A principio de este año comenzó la publicación de una nueva revista sobre Terapia Familiar cuyo director, Gerald Zuk, es uno de los pioneros de este desarrollo científico en USA.

Reproducimos la presentación de la revista, hecha por su director, junto con nuestros deseos de que los objetivos científicos anhelados se conviertan en realidad.

La misión especial de una revista es la de expandir y comprobar teorías, métodos y aplicaciones en el campo de estudio. IJFT no es órgano oficial de ninguna asociación profesional y está libre de presiones que pueden estar asociadas con tal afiliación. Siendo una publicación nueva, no tiene aún suficiente background, pero, el lector tiene acceso a las experiencias profesionales del editor y los miembros del consejo editorial. El editor está largamente identificado con un particular punto de vista en el campo de la especialidad, pero hay razón para pensar que cualquiera sea su experiencia personal estará equilibrada por la presencia del consejo de numerosas personas con diferentes puntos de vista.

Tres tipos de artículos recibirán prioridad en la publicación:

- 1) Artículos que sistemáticamente evalúen los efectos de la terapia familiar.
- 2) Artículos que intenten explicar la patología familiar en términos de crisis en el ciclo vital o condiciones cambiantes en el vecindario, comunidades o instituciones sociales y,
- 3) Artículos que analicen las interconexiones entre los sistemas individual, familiar y social, intervención terapéutica o prevención.

La publicación buscará, alentará y publicará contribuciones originales, pero deberá también tomar conocimiento de las tendencias de la especialidad que pueden no ser originales y que sean probablemente de corta vida.

Como publicación internacional, se esforzará en obtener contribuciones originales del pequeño pero creciente número de trabajadores en terapia familiar fuera de USA, y, también, de tanto en tanto, traerá breves informes sobre adelantos y actividades en Terapia Familiar dentro y fuera de USA.

Información sobre la Sociedad Argentina de Terapia Familiar

Primer Aniversario de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar

El 16 de junio próximo pasado se cumplió el primer aniversario de la fundación de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Con tal motivo se realizó en su sede provisoria —Gorostiaga 1731— una mesa redonda sobre el tema “Razones y consecuencias clínicas y teóricas de la terapia familiar”. Expusieron en esa ocasión sus ideas miembros de la Comisión Directiva: los Dres. García Badaracco, Rafael Skiadaressis, Oscar Czeretoc y Juan Yaría y los licenciados Stella Maris Molina y Juan Carlos Nocetti. El debate que a continuación se desarrolló estuvo coordinado por el Dr. Alfredo Canévaro, quien hizo referencia a la trascendencia del evento. Se sirvió finalmente un vino de honor en el que fueron recibidos los nuevos socios de la institución.

Ha sido este un año fructífero para la Sociedad. Luego de reuniones de intenso trabajo donde fueron redactados el Acta de Fundación y los estatutos, designados los primeros miembros de la Comisión Directiva y creadas las primeras comisiones de trabajo, la Comisión en pleno se abocó a la organización de varias actividades científicas. Una de ellas, en respuesta a una demanda del equipo de Terapia Intensiva de un Servicio Hospitalario, se relacionó con problemas que surgían en respuesta a una moderna orientación que tomaba relación con los familiares de los pacientes internados como aspecto fundamental del proceso terapéutico. Se estableció un rápido contacto entre el Servicio y un equipo de interconsulta designa-

do por la Comisión, contacto que finalizó con la entrega de un informe conteniendo un diagnóstico de la situación y algunas de las vías de posible solución de los conflictos. Con motivo de las Segundas jornadas Rosarinas de Terapia Familiar, pudimos enterarnos, en virtud de la presentación de un trabajo de los miembros del Servicio mencionado, de las favorables consecuencias de esta mediación. Deja este contacto un saldo positivo para ambos y abre el camino para futuros encuentros de este tipo.

Una segunda actividad científica realizada durante los meses de noviembre y diciembre de 1978 consistió en una serie de conferencias bajo el tema “Actualizaciones en Terapia Familiar”. El programa que se logró confeccionar en esa oportunidad reunía a los siguientes profesionales miembros de la Sociedad: El Dr. Alfredo Canevaro, quien tuvo a su cargo la apertura del ciclo y cuyo trabajo “Apuntes para una filosofía terapéutica del grupo familiar” le dio digno broche final. El Dr. García Badaracco disertó sobre el tema “La inclusión de la problemática familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico”. “La elaboración del fenómeno psicótico en el marco de la terapia familiar” fue el tema abordado por el Dr. Juan Yaría, en tanto el Lic. Juan Carlos Nocetti se refirió a “La estructura de las relaciones de parentesco en el marco de una terapia familiar”. Los “Aportes de E. Pichon Riviere a la terapia familiar” fueron

consignados por el Dr. Alejandro Sicardi y los Dres. Skiadaressis y Kligman compartieron el desarrollo del tema "Familia e intersubjetividad". Finalmente el Dr. Luis Albornoz hizo algunas "Reflexiones sobre la terapia familiar". El evento tuvo lugar en la Sociedad Científica Argentina, cuyo salón Ameghino fue colmado por un público deseoso de ponerse al día en una disciplina que va ganando profesionales orientados hacia un camino novedoso y promisorio.

Aprovechando la momentánea presencia del Dr. Isidoro Berenstein en Buenos Aires durante el mes de diciembre, pudo intercalarse en el programa una conferencia que sumó su valioso aporte a estas "Actualizaciones...". En esa ocasión, el Dr. Berenstein abordó el tema "Contexto de la Terapia Familiar", al que siguió un prolongado debate.

Ya sobre el final del año la Sociedad Argentina de Terapia Familiar comprometió a través de varios de sus miembros su participación y auspicio a las Segundas Jornadas Rosarinas de Terapia Familiar y al VIII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo.

Marzo marcó el comienzo de un nuevo año de trabajo. Se abrió una primera conscripción de socios cuyo número alcanza en este momento a más de un centenar. Se estableció una fecha fija de reuniones científicas: los miércoles a las 21 horas. Va ser cubierta por conferencias, mesas redondas, y, una vez al mes, un Ateneo cuyo contenido, al igual que el del ciclo de conferencias mencionado, se irá publicando en la Revista Terapia Familiar.

El primero de estos Ateneos, llevado a cabo el día 27 de junio tuvo como tema central la terapia familiar con niños y contó con la presencia de la Lic. Mariel Czertok y los Dres. Isidoro Gurman y Bechuk.

El miércoles 25 de julio tuvo lugar una conferencia del Dr. R. Perrone, quien se refirió a su modalidad de trabajo con familias en el Hospital Saint Etienne de Francia.

Están previstas para lo que resta del año varias reuniones más, entre ellas: el 1º de agosto el Dr. Tisminetzky disertará sobre "Terapia familiar desde el punto de vista de los interaccionistas". El día 8 de agosto el Dr. Marcos Bernstein abordará el tema "Psicopatología de la vida cotidiana familiar en el grupo familiar". A ellos les sucederán en fechas todavía no fijadas los Dres. Santiago Korin, Saúl Fuks, el Lic. Luis J. Jury y otros.

Durante el mes de agosto y septiembre darán comienzo tres de los seminarios previstos para el presente año. Uno de ellos a cargo de los Dres. Czertok, Kligman y Albornoz sobre el tema "Nociones básicas teórico prácticas de la terapia familiar", otro sobre "Teoría y práctica de la terapia de las relaciones familiares", un seminario de 4 clases dictado por el Lic. J.C. Nocetti, y otro del Dr. J. Bechuk sobre "Ciclos de la vida familiar".

Estos seminarios constituyen el preámbulo al lanzamiento de una escuela de formación para terapeutas de familias cuyo proyecto se encuentra en estudio para el año próximo.

Finalmente, se han concretado dos invitaciones, la de los Dres. Rubinstein y Zuk de Filadelfia, EEUU.

respectivamente quienes, durante la segunda semana de octubre y la primera de diciembre, dictarán conferencias, seminarios, ofrecerán superviciones, actuarán en vivo durante sesiones de terapia familiar y mostrarán video-cassettes con sesiones por ellos mismos grabadas. Esta actividad estará en parte dirigida con exclusividad a los socios de la institución y, en parte dirigida al público profesional en general.

La actividad de los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar no ha finalizado aquí. Han logrado concretar la realización de un fichero a doble entrada en el cual el interesado podrá consultar acerca de toda publicación nacional o extranjera por autor o por tema. Se ha suscripto además a la publicación Current Contents cuyos recortes permitirán la puesta al día en cuanto a la bibliografía de temas afines a la especialidad.

TERAPIA FAMILIAR Y TERAPIA BREVE

Curso intensivo de tres semanas en castellano

Coordinadores del Curso:

Dres. Carlos Sluzki y Paul Watzlawick

Durante este mes de agosto de 1979, se está desarrollando este curso para especialistas de habla hispana en una prestigiosa institución de USA, que contribuyera al desarrollo de los modelos comunicacional y sistémicos en psicoterapia, y que generó el enfoque interaccional en terapia familiar.

Es un curso intensivo, con presentación de material en video-tape, entrevistas de familias hispano-parlantes, y supervisión de material propio.

La inscripción al curso incluye la

participación en la Cuarta Conferencia Don Jackson, hecha en memoria de uno de los pioneros fundadores del Mental Research Institute, que nuclea la presencia de importantes especialistas en el campo de la terapia familiar, como Murray Bowen, Mara Selvini-Palazzoli, Margaret Singer, y Carl Whitaker.— Para enviar correspondencia a: Curso Intensivo en Castellano; Mental Research Institute.—555 Middlefield Rd.—PALO ALTO - California 94301 — USA.

No podemos dejar de consignar que la concreción de esta variada gama de aspiraciones y proyectos no fue sino el producto de un silencioso pero tenaz esfuerzo de un grupo de profesionales que, miércoles tras miércoles, durante un año de trabajo, han dedicado esfuerzo y tiempo a la realización y consolidación de una institución que aspira a ser un centro de información y un núcleo de agrupamiento y pertenencia de todos los que de una u otra manera orientan su quehacer profesional hacia el campo de las terapias familiares y matrimoniales.

participación en la Cuarta Conferencia Don Jackson, hecha en memoria de uno de los pioneros fundadores del Mental Research Institute, que nuclea la presencia de importantes especialistas en el campo de la terapia familiar, como Murray Bowen, Mara Selvini-Palazzoli, Margaret Singer, y Carl Whitaker.— Para enviar correspondencia a: Curso Intensivo en Castellano; Mental Research Institute.—555 Middlefield Rd.—PALO ALTO - California 94301 — USA.

CONCURSO ANUAL DE
TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR

La Revista Terapia Familiar instituye un concurso de trabajos teóricos, clínicos o de investigación que signifique un aporte relevante, al desarrollo del conocimiento y de la práctica de nuestra disciplina.

Las condiciones son las siguientes:

- El concurso se realizará anualmente;
- Los trabajos podrán ser presentados individual o grupalmente, pudiendo tratarse de terapeutas familiares o de equipos interdisciplinarios residentes en el país.
- El jurado estará compuesto por 6 (seis) personalidades reconocidas en nuestra disciplina y será designado por los responsables de la Revista **Terapia Familiar**. En caso de empate, se requerirá el voto del Director de la Revista.
- El premio consistirá en un diploma y la publicación del trabajo en la Revista **Terapia Familiar**. Podrá ser compartido o declarado desierto. El jurado podrá otorgar menciones a otros trabajos que serían eventualmente publicados.
- Los trabajos que deberán ser inéditos, serán presentados en 7 (siete) copias escritas a máquina, a doble espacio, tamaño carta. Serán firmados con un seudónimo, que figurará con el título del trabajo en la cara externa de un sobre cerrado conteniendo en su interior el nombre y domicilio del o los autores.
- La recepción de los trabajos quedará a cargo de los responsables de la Revista **Terapia Familiar** desde la fecha de publicación de este número de la revista hasta el 31 de enero de 1980, inclusive. El trabajo premiado y las menciones que hubiera resuelto el jurado, serán publicados en el primer número del año 1980 de nuestra revista.

Comité de Redacción

Terapia Familiar, 3, 1979

ANNOUNCING...



The
Journal of Marital
and Family Therapy

Florence W. Kaslow, Ph.D., Editor

formerly known as
THE JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY COUNSELING

WE HAVE CHANGED OUR NAME . . . in order to more accurately reflect the education and nature of clinical practice in the present professional developments in the discipline. With this new title, we will continue to offer quality articles on theory, research and treatment interventions in marital and family therapy.

A publication of the American Association for Marriage and Family Therapy (formerly known as the American Association of Marriage and Family Counselors).

SUBSCRIPTION ORDER FORM

_____ Individual — \$20/year (4 issues)

_____ Institutional (Libraries and Multi-Reader Establishments) — \$30/year (4 issues)

(Orders outside the United States and Canada request latest prices from JMFT Business Office)

_____ Check Enclosed.

_____ Please bill me for this order plus postage and handling.

Name _____

(or Institution) _____

Address _____

City _____ State/Province _____ Zip _____

Please mail this form to: JMFT Business Office, 924 W Ninth, Upland CA 91786.

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Donald A. Bloch, *New York, N.Y.*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.* Edgar H. Auerswald, *Maui, Hawaii.* Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.* Salvador Minuchin, *Philadelphia, Pa.* Jules Riskin, *Palo Alto, Calif.* Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.* Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.* Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS is the definitive Journal in the field of family psychotherapy, study, and research, published quarterly. Original articles report on the theory and practice of family treatment as well as on related research. Additionally, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to Books, Abstracts of relevant literature, Training Announcements, and news of Activities in the family field.

Among the many contributors to FAMILY PROCESS in recent years have been *Nathan W. Ackerman, Edgar H. Auerswald, John E. Bell, Nathan B. Epstein, Andrew Ferber, Antonio J. Ferreira, James Framo, Jay Haley, Don D. Jackson, Walter Kempler, Frank S. Pittman, Ross V. Speck, and Gerald Zuk.*

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

DATE _____

Gentlemen:

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

- ☐ \$12.00 per year United States
☐ \$13.00 per year Canada & Latin America
☐ \$14.00 per year All other countries

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

- ☐ \$20.00 U. S.
☐ \$21.00 Canada & Latin America
☐ \$22.00 All other countries

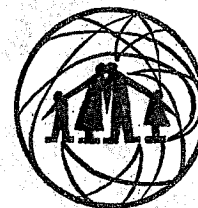
NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____ STATE/COUNTRY _____ ZIP _____

All subscriptions are entered on a calendar year basis

La rivista esce in collaborazione con le riviste: *Family Process* dell'Ackerman Institute for Family Therapy di New York e del Mental Research Institute di Palo Alto; *Journal of Marriage and Family Therapy* dell'American Association of Marriage and Family Therapy; the *American Journal of Family Therapy* della National Alliance for Family Life.



Abbonamenti 1979

Italia: Ordinario L. 11.000

Enti L. 20.000

Esteri: L. 15.000 o doll. 17

Sostenitore: L. 50.000

Numero separato: L. 6.500

Pubblicazioni arretrate:

Numero singolo: L. 7.500

Annata: L. 15.000

I versamenti per gli abbonamenti vanno inviati a mezzo modulo di c/c postale N. 23889009 intestato a Rivista «Terapia Familiare» della C.T.F. s.r.l. via Reno 30, 00198, Roma.

Gli abbonamenti non disdetti entro il Giugno dell'anno successivo si intendono tacitamente rinnovati. Dopo questa data la rivista sarà inviata 'contrassegno' agli abbonati che non hanno ancora inviato il versamento tramite c/c postale.

I reclami per eventuali dispersioni di fascicoli vanno presentati non oltre un mese dalla pubblicazione. Eventuali cambiamenti d'indirizzo vanno tempestivamente notificati.

Autorizzazione del Tribunale di Reggio Calabria n. 2467 di Reg. S.P. in data 2 marzo 1977.

Visigalli-Pasetti - arti grafiche - Roma.

TERAPIA FAMILIARE

Rivista semestrale

Organo ufficiale della Società Italiana di Terapia Familiare (S.I.T.F.)

Direttore Responsabile:
Maurizio Andolfi

Comitato Direttivo:
P. Menghi - A. Nicolò - C. Saccu

Comitato di redazione nazionale:

C. Angelo (Bolzano), J. Anzilotti (Firenze), A. Berardi (Latina), M. Bertini (Roma), R. de Bernart (Firenze), C. Dobrowolski (Firenze), K. Giacometti (Firenze), S. Montagano (Firenze), P. Pepe (Roma), R. Piperno (Roma), C. Pontalti (Roma), S. Soccorsi (Roma), C. Truppi (L'Aquila), F. Vanon (Firenze).

Comitato di redazione internazionale:

H. Aponte (Filadelfia), A. Bentovim (Londra), D. Bloch (New York), I. Boszormenyi-Nagy (Filadelfia), M. Bowen (Washington), P. Caillé (Oslo), A. Canevaro (Buenos Aires), Y. Colas (Lione), M. Elkaim (Bruxelles), J. Framo (Filadelfia), F. Kaslow (Filadelfia), L. L'Abate (Atlanta), K. LaPerrière (New York), B. Luban-Plozza (Locarno), S. Minuchin (Filadelfia), E. Panchari (Losanna), P. Papp (New York), A. Schefflen (New York), O. Silverstein (New York), C. Sluzki (San Francisco), H. Stierlin (Heidelberg), P. Watzlawick (Palo Alto), C. Whitaker (Madison), I. Zwerling (Filadelfia).

Responsabile pubblicazioni estere:
K. Giacometti

Segretarie di redazione:
A. La Mesa, G. Montinari, P. Valentini.

Diffusione e pubblicità:
E. Bentivegna, U. Capitani.

Progetto grafico e impaginazione:
D. Grauer.

Redazione:
Via Reno, 30 - 00198 Roma
Tel. 86.42.61

CLINICA GRADIVA



COORDINADORES:

Dr. MIGUEL A. BIANUCCI
Dr. JUAN A. YARIA

- TRATAMIENTO PSIQUIATRICO INTEGRAL
- INTERNACION
- CLINICA DE DIA
- CONSULTORIOS EXTERNOS
- URGENCIAS DOMICILIARIAS

Rivadavia 5840 Capital T.E.: 631-7581/632-5565
Radiomensaje: 46-5329/3701 • 45-9392/9549 • Código 4777

SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA DEL "HOSPITAL ITALIANO"

Integrado al Dto. de Medicina

Guardia médica psiquiátrica activa permanente: de un médico de planta y un médico residente

- Consultorio Externo: Sectores de Adolescentes, Adultos y Personas de Edad.
- Internación: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal.
- Hospital de Día: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal, Psicodrama.

Jefa int.: Prof. Dra. Lía Ricón de Tenconi

Gascón 450

Tel. 811-4149

centro de investigaciones en psicopatología

CIEP

- INTERNACION
 - HOSPITAL DE DIA
 - CONSULTORIOS EXTERNOS

Coordinadores:

Jorge Cosín y Carlos Lorusso

FRANKLIN D. ROOSEVELT 2296 esq. VUELTA DE OBLIGADO

Tel. 781-6929 (por radiollamado: 32-6383/84/85/86/87)

Códigos: 6800-6801 (especificando nombre, tel. y/o dirección)
1428 Buenos Aires - República Argentina

1968 - 1979

CLINICA PSIQUIATRICA

(Comunidad Terapéutica)

DIRECCION MEDICA Prof. Dr. Jorge E. García Badaracco
Dr. Norberto J. Proverbio
Dr. Alfredo A. Canevaro

Pone a disposición de los colegas una larga trayectoria de experiencia Institucional privada en los trastornos psíquicos graves que requieren Internación total o parcial, incluyendo los más modernos recursos terapéuticos, desde los recientes avances de la investigación biológica hasta la experiencia clínica psicoterapéutica individual, grupal, familiar e institucional.

O'Higgins 2328/48

1428 - CAPITAL FEDERAL

Radiollamada Código 9807

Teléfonos: 781-1306/6557/7825
31-0056/59 y 32-6383/87

COMUNIDAD TERAPEUTICA DIURNA

DIRECCION MEDICA Prof. Dr. Jorge E. Garcia Badaracco
Dr. Norberto J. Proverbio
Dr. Alfredo A. Canevaro

Ofrece a los colegas una nueva modalidad asistencial para aquellas personas que psicológicamente no hayan podido aún reintegrarse en forma plena a la sociedad.

Gorostiaga 1731
1426 - CAPITAL FEDERAL
TELEFONO 773 - 1308

RADIOLLAMADOS:
32 - 6383 / 87
31 - 0056 / 59
Código 9910

ACTA

Psiquiátrica y Psicológica
de América Latina

Publicación trimestral

Fundada en 1954

Suscripción anual
(4 números)

Argentina \$ 30.000
Exterior u\$s 30.00

Dirección y administración:
Malabia 2274, 130. A
1425 Buenos Aires

Indicaciones sobre los trabajos que se envíen como colaboraciones

Aquellos trabajos originales o comunicaciones sobre Congresos, conferencias y seminarios que traten el tema específico de la terapia familiar, deben ser enviados a:

Alfredo A. Canevaro, Gorostiaga 1731 - Cap. Federal (1426) - Rep. Argentina.

Las colaboraciones deberán ser originales y en dos (2) copias mecanografiadas a doble espacio, con un resumen final: La propiedad literaria de los artículos enviados pertenece a la revista y ésta se reserva todos los derechos de reproducción y publicación.

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Editorial ACE S.R.L., No a la orden, por pesos

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL
Argentina \$ 30.000.-
Exterior u\$s 22.- recargo vía aérea u\$s 5.